ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 03 · GH

Manual de

GASTROENTEROLOGÍA

& Hepatología

Módulo 1 · Medicina Interna · 26 clases

Índice general

01 Esófago y Estómago 3

1.1. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett 5
1.2. Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori 9
1.3. Disfagia y Trastornos Motores del Esófago 13
1.4. Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico 16
1.5. Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico 20
1.6. Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino 23

02 Intestino y Colon 27

2.1. Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable 29
2.2. Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación 31
2.3. Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa 36
2.4. Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn 39
2.5. Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje 44
2.6. Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula 48

03 Hígado 52

3.1. Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico 54
3.2. Hepatitis Aguda y Crónica 58
3.3. Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal 61
3.4. Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares 64

04 Vía Biliar y Páncreas 70

4.1. Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis 72
4.2. Pancreatitis Aguda 75

05 Abdomen Agudo y Urgencias Digestivas 80

5.1. Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis 82
5.2. Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular 85
5.3. Hemorragia Digestiva Alta y Baja 88
5.4. Cuerpo Extraño Digestivo 92

06 Gastroenterología y Cirugía Pediátrica 97

6.1. Diarrea Aguda y Crónica en el Niño 99
6.2. Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño 102
6.3. Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones 105
6.4. Trauma Abdominal y Torácico 108

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 113

MANUAL EUNACOM DE GASTROENTEROLOGÍA

BLOQUE 01 DE 06 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

01 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

6	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
1.1	Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	5
1.2	Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori	9
1.3	Disfagia y Trastornos Motores del Esófago	13
1.4	Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico	16
1.5	Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico	20
1.6	Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino	23

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.1.027, 1.06.4.007	Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	Específico	Completo	Completo
1.06.1.030, 1.06.1.014, 1.06.4.007, 4.01.5.012, 1.06.3.005	Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori	Específico	Completo	Completo
1.06.1.013, 4.01.1.004, 4.01.1.005, 4.01.1.002, 1.06.4.002, 6.03.1.032	Disfagia y Trastornos Motores del Esófago	Sospecha	Inicial	Derivar
1.06.1.030, 4.01.2.019, 4.01.2.001, 4.01.2.003, 4.01.4.008	Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico	Específico	Inicial	Derivar
1.06.1.004, 4.01.1.005, 1.06.3.003, 4.01.1.007, 4.01.1.008, 4.01.3.013	Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.1.006, 4.01.1.040, 4.01.1.041	Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino	—	—	—

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.
- El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H_2 están obsoletos y no se combinan con IBP.
- Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a endoscopía.
- Barrett = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos distintos.
- No se erradica H. pylori por ERGE; sí es obligatorio erradicarlo en úlcera péptica y linfoma MALT.
- El omeprazol trata el reflujo; la úlcera péptica se trata erradicando H. pylori. Sin erradicación, la úlcera recidiva en el 90 %.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 6 TEMAS

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	EUNACOM Enero 2023 · #65 · EUNACOM Enero 2023 · #74 · EUNACOM Diciembre 2022 · #26 · EUNACOM Agosto 2021 · #120
Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori	EUNACOM Diciembre 2025 · #129 · EUNACOM Julio 2025 · #160 · EUNACOM Diciembre 2025 · #117 · EUNACOM Enero 2023 · #71
Disfagia y Trastornos Motores del Esófago	EUNACOM Diciembre 2025 · #175 · EUNACOM Julio 2025 · #150 · EUNACOM Diciembre 2025 · #84 · EUNACOM Julio 2024 · #112
Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico	EUNACOM Diciembre 2025 · #129 · EUNACOM Enero 2023 · #71 · EUNACOM Enero 2023 · #70 · EUNACOM Enero 2023 · #174
Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico	EUNACOM Julio 2019 · #91 · EUNACOM Diciembre 2018 · #55 · EUNACOM Julio 2015 · #121 · EUNACOM Julio 2013 · #133

1.1. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.027 1.06.4.007

¿POR QUÉ?

El esfínter esofágico inferior no es una válvula anatómica sino un tono muscular mantenido que se relaja de forma transitoria decenas de veces al día. El reflujo se vuelve patológico cuando esas relajaciones son demasiado frecuentes o el aclaramiento esofágico falla: por eso el tratamiento es funcional (suprimir ácido, mejorar el vaciamiento) y la cirugía queda reservada para la excepción.

1. DEFINICIÓN Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

1.06.1.027

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es el paso retrógrado del contenido gástrico al esófago con síntomas o lesión de la mucosa. Su mecanismo es la **relajación transitoria del esfínter esofágico inferior**, no una obstrucción. **(ver Imagen 1.1A y B)**

Presentación típica: pirosis retroesternal y regurgitación ácida, que empeoran al acostarse y con la ingesta abundante. **Presentación atípica:** tos crónica, asma de difícil control, disfonía, erosiones dentales y dolor torácico no cardíaco.

2. DIAGNÓSTICO: CUÁNDO BASTA LA CLÍNICA Y CUÁNDO SE ENDOSCOPIA

1.06.1.027

En un paciente menor de 40–50 años con pirosis y regurgitación **típicas y sin signos de alarma**, el diagnóstico es clínico y se inicia prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones (IBP) por 4 a 8 semanas: la respuesta confirma el diagnóstico.

La **pH-metría esofágica de 24 horas** es el patrón de referencia y se reserva para la duda diagnóstica, la clínica atípica o la evaluación prequirúrgica.

1.06.1.027 1.06.4.007

Endoscopía digestiva alta obligatoria si hay signos de alarma: disfagia, odinofagia, baja de peso, anemia o hemorragia, síntomas que despiertan al paciente, inicio después de los 50 años o pirosis de más de 5 años de evolución (riesgo de esófago de Barrett). **(ver Imagen 1.1C)**

3. TRATAMIENTO

1.06.1.027

Medidas generales: fraccionar la alimentación, elevar la cabecera de la cama, bajar de peso, suspender tabaco y evitar alcohol, cafeína, comidas grasas y relajantes musculares antes de dormir.

Farmacoterapia: el IBP (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol) es el fármaco de elección y debe tomarse **en ayunas, 30–60 minutos antes del desayuno**. Los antagonistas H_2 (ranitidina, famotidina) están desplazados y no deben combinarse con IBP.

Cirugía antirreflujo (funduplicatura de Nissen): paciente joven con ERGE grave dependiente de IBP, hernia hiatal voluminosa sintomática, o esófago de Barrett con displasia de alto grado.

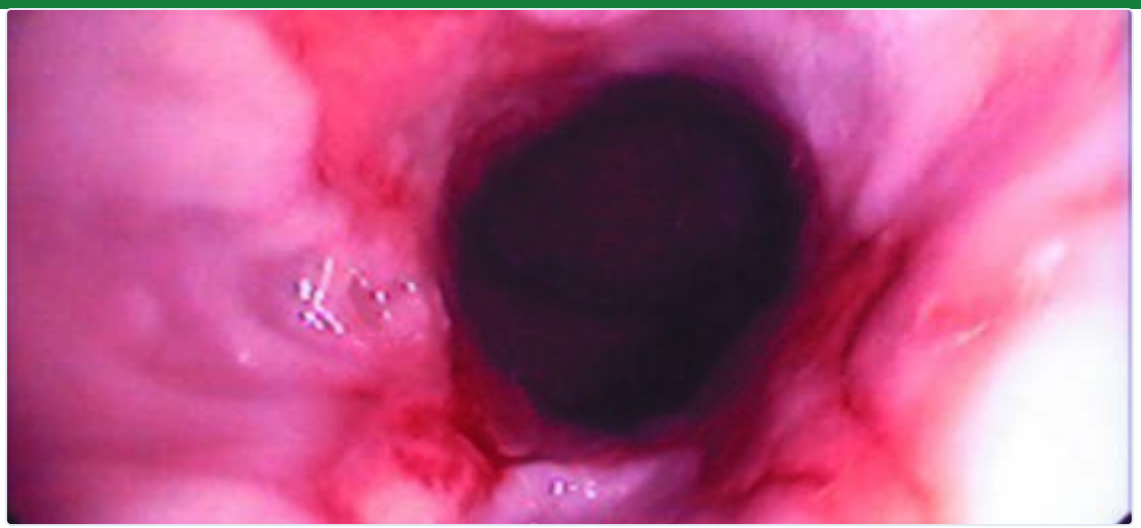
4. ESÓFAGO DE BARRETT

1.06.1.027

Es la **metaplasia intestinal** del epitelio esofágico (reemplazo del epitelio plano por cilíndrico) secundaria a la exposición ácida crónica. Es asintomático; los síntomas son los del RGE de base.

1.06.1.027 1.06.4.007

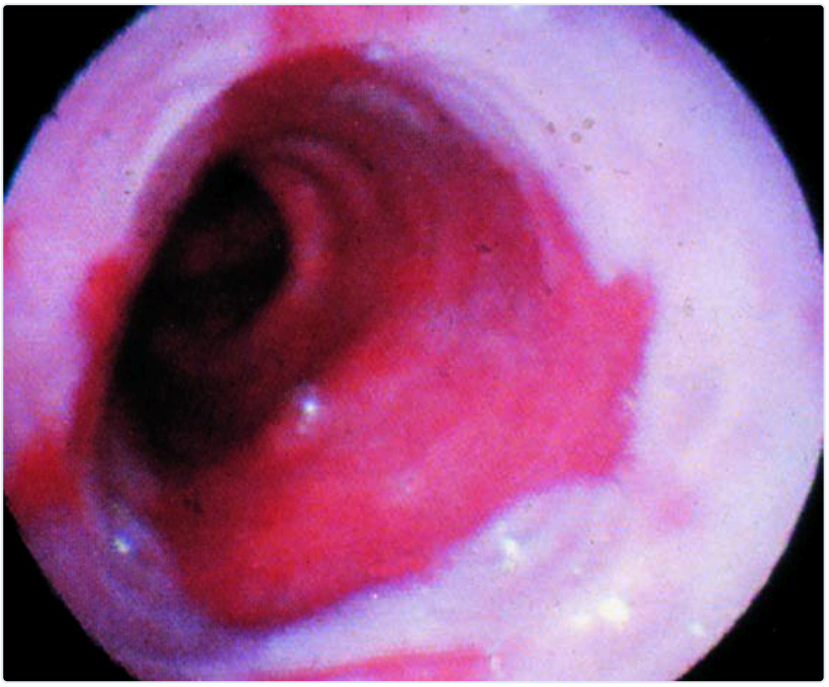
Su importancia es el riesgo de progresión a **adenocarcinoma de esófago**. La conducta la define la biopsia: metaplasia sin displasia → IBP y endoscopía de vigilancia; displasia de bajo grado → ablación endoscópica; **displasia de alto grado → resección endoscópica o esofagectomía**.



A. ESOFAGITIS EROSIVA



B. ESOFAGITIS (ENDOSCOPIA)



C. ESÓFAGO DE BARRETT

Imagen 1.1

TABLA 1.1 · ERGE — DECISIONES CLAVE QUE SE PREGUNTAN EN EL EUNACOM 1.06.1.027, 1.06.4.007

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Pirosis típica, < 50 años, sin alarma	Prueba con IBP 4–8 semanas	Pedir endoscopía de entrada
Pirosis + disfagia o baja de peso	Endoscopía digestiva alta	Subir la dosis de IBP sin estudiar
Duda diagnóstica / clínica atípica	pH-metría de 24 h	Tratar empíricamente de forma indefinida
Barrett con metaplasia sin displasia	IBP + vigilancia endoscópica	Indicar cirugía por el hallazgo de metaplasia
Barrett con displasia de alto grado	Resección endoscópica / esofagectomía	Solo aumentar IBP y controlar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Mujer de 44 años consulta por pirosis retroesternal y regurgitación ácida de 2 años de evolución, que empeora al acostarse. Ha usado antiácidos ocasionales con alivio parcial. No refiere disfagia, baja de peso ni anemia. Examen físico normal.

Conducta oficial. ERGE no complicada en una paciente menor de 50 años sin signos de alarma: la conducta es prueba terapéutica con IBP en ayunas por 4 a 8 semanas junto con medidas antirreflujo, sin necesidad de endoscopía inicial. La endoscopía se reservaría para falta de respuesta, recurrencia precoz al suspender el IBP o aparición de signos de alarma.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.
- El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H_2 están obsoletos y no se combinan con IBP.
- Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a endoscopía.
- Barrett = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos distintos.
- No se erradica H. pylori por ERGE; sí es obligatorio erradicarlo en úlcera péptica y linfoma MALT.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción EUNACOM 2013 · Pregunta #12

1. Hombre de 27 años, sin antecedentes, consulta por 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y el estrés, con pirosis ocasional. La endoscopía digestiva alta muestra una úlcera duodenal activa y el test de ureasa resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 14 días
B) Indicar omeprazol y repetir la endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar una nueva endoscopía con test de ureasa
D) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol a permanencia
E) Indicar solo omeprazol por 8 semanas y control clínico

Reconstrucción EUNACOM Julio 2015 · Pregunta #124

2. Paciente con úlcera gástrica y test de ureasa positivo recibe amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 10 días, seguido de omeprazol por 4 semanas. El control con test de ureasa a las 6 semanas post-tratamiento sigue positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el mismo esquema por 14 días
B) Realizar endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Indicar terapia erradicadora de segunda línea
D) Repetir el test de ureasa en 3 meses
E) Observar la evolución clínica

Más preguntas online de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett →

1.2. Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.030 | 1.06.1.014 | 1.06.4.007 | 4.01.5.012 | 1.06.3.005

¿POR QUÉ?

La clave de todo el tema es una sola distinción: el omeprazol trata el reflujo, pero la úlcera péptica se trata erradicando el H. pylori. Si solo se suprime ácido, la úlcera cicatriza y recidiva en el 90 % de los casos porque la causa sigue ahí. Y como la epigastralgia de la úlcera, del cáncer gástrico y de la dispepsia funcional es idéntica, la endoscopía es obligatoria en todo paciente con dispepsia y algún signo de alarma o ≥ 40 años.

1. SÍNDROME ULCEROSO Y CAUSAS

La úlcera gastroduodenal se presenta como epigastralgia urente que aumenta con el ayuno y alivia con la ingesta de alimentos o antiácidos. La misma clínica la produce el cáncer gástrico y la dispepsia funcional. **(ver Imagen 1.2C)** 1.06.1.030 1.06.1.014

Las dos causas son **Helicobacter pylori** (90 % de las úlceras duodenales, 70 % de las gástricas) y los **AINE**. El tabaco y los corticoides son cofactores. La prevalencia de H. pylori en Chile alcanza el 75 % de la población. 1.06.1.030

2. DIAGNÓSTICO

La endoscopía digestiva alta se solicita siempre en el paciente con dispepsia y signos de alarma o edad ≥ 40 años, con dos objetivos: confirmar la úlcera y **tomar biopsias para descartar cáncer gástrico** (obligatorio en toda úlcera gástrica). **(ver Imagen 1.2B)** 1.06.1.030 1.06.1.014 1.06.4.007 4.01.5.012

El H. pylori se detecta por test de ureasa en la biopsia, test del aliento con ^{13}C-urea o antígeno en deposiciones. La dispepsia funcional es un diagnóstico **de exclusión**: requiere una endoscopía normal. 1.06.1.030 1.06.1.014

3. ERRADICACIÓN DE H. PYLORI

Primera línea: IBP + amoxicilina 1 g + claritromicina 500 mg, todos cada 12 horas por 14 días. **Segunda línea** (si falla): terapia cuádruple con bismuto (IBP + bismuto + tetraciclina + metronidazol) por 14 días, evitando la claritromicina. 1.06.1.030

Se erradica siempre en la **úlcera gastroduodenal** y en el **linfoma MALT gástrico** (que regresa solo con antibióticos, sin quimioterapia). No se erradica en la ERGE (no hay asociación). Indicación relativa: dispepsia funcional, usuarios crónicos de AINE, antecedente familiar de cáncer gástrico, metaplasia o gastritis atrófica. 1.06.1.030 1.06.1.014

4. CONTROL DE LA ERRADICACIÓN Y COMPLICACIONES

El control se hace 4 semanas después de terminar los antibióticos: úlcera gástrica → endoscopía (además, para verificar cicatrización y descartar cáncer); úlcera duodenal → antígeno fecal o test del aliento. Los tests deben hacerse con el IBP suspendido 2 semanas antes. **(ver Imagen 1.2A)** 1.06.1.030 1.06.4.007

Complicaciones: **hemorragia digestiva alta** (la más frecuente) → IBP endovenoso + endoscopía de urgencia con terapia hemostática; y **perforación** → dolor "en puñalada", abdomen en tabla, radiografía de tórax de pie con neumoperitoneo y cirugía de urgencia (la endoscopía está contraindicada). 1.06.1.030

5. AINE, GASTROPROTECCIÓN Y LA ENDOSCOPÍA COMO PROCEDIMIENTO

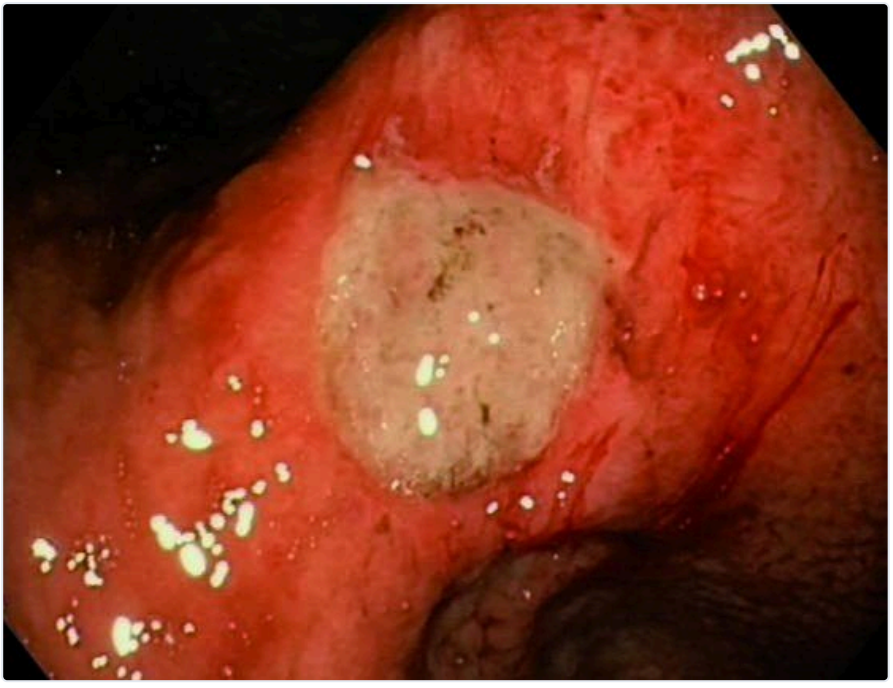
AINE y tracto digestivo: todos los antiinflamatorios no esteroidales (y la aspirina en dosis baja) lesionan la mucosa gastroduodenal al inhibir las prostaglandinas protectoras; pueden producir dispepsia, erosiones, úlcera, hemorragia y perforación, y el riesgo es mayor en la úlcera gástrica que en la duodenal. **Factores de riesgo:** edad ≥ 65 años, antecedente de úlcera o de hemorragia digestiva, uso simultáneo de corticoides, anticoagulantes o antiagregantes, dosis altas, dos AINE juntos e infección por H. pylori. 1.06.3.005

Uso seguro y gastroprotección: usar la menor dosis por el menor tiempo, con comida, y preferir paracetamol en el dolor leve. En el paciente de riesgo que necesita AINE se agrega **un IBP** (el fármaco de elección; los antagonistas H_2 y el sucralfato no protegen bien la mucosa gástrica); el misoprostol es eficaz pero mal tolerado (diarrea, contraindicado en el embarazo). En riesgo alto o con antecedente de úlcera complicada se prefiere un inhibidor selectivo de COX-2 (celecoxib) más IBP. Se **erradica H. pylori** antes de iniciar un AINE crónico si hay antecedente de úlcera. Ante una úlcera por AINE: suspender el AINE y dar IBP 8 semanas; si el AINE es imprescindible, IBP de mantención.

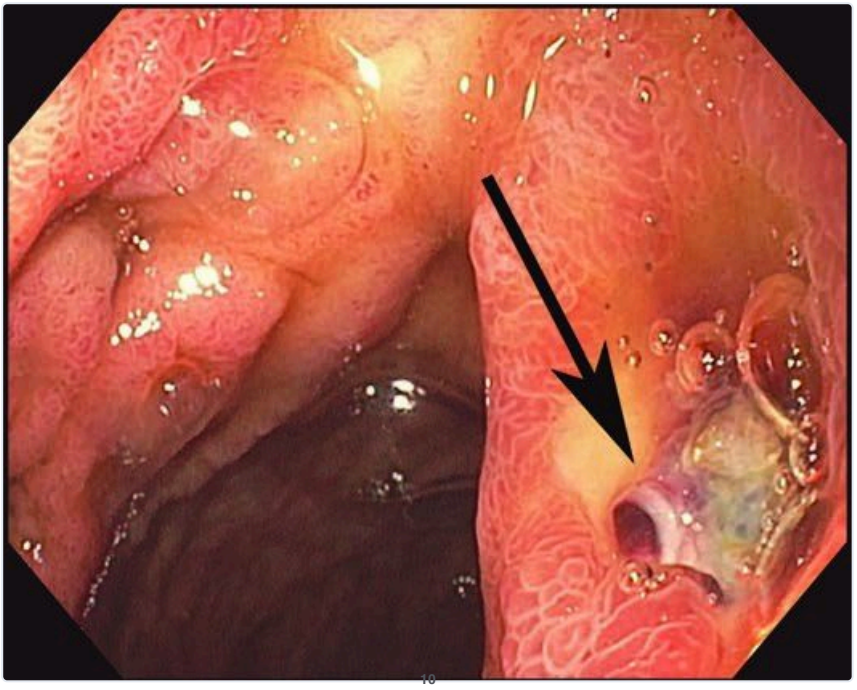
La endoscopía digestiva alta como procedimiento (nivel: derivar): la realiza el especialista con un endoscopio flexible; requiere **ayuno de 6–8 horas**, consentimiento informado, y habitualmente sedación (por eso el paciente debe ir acompañado y no conducir ese día). Permite ver la mucosa, tomar **biopsias** (cáncer, H. pylori, celiaquía) y hacer terapia (hemostasia, ligadura de várices, extracción de cuerpos extraños). El médico general la indica con los criterios ya vistos, prepara al paciente (informa de anticoagulantes y antiagregantes que el especialista debe manejar) y la solicita con urgencia en la hemorragia. Complicaciones raras: perforación, hemorragia tras la biopsia y depresión respiratoria por la sedación. 4.01.5.012



A. ÚLCERA DUODENAL



B. ÚLCERA GÁSTRICA



C. VASO VISIBLE

Imagen 1.2

TABLA 1.2 · ÚLCERA PÉPTICA — A QUIÉN SE ERRADICA Y CÓMO SE CONTROLA 1.06.1.030, 1.06.1.014, 1.06.4.007, 4.01.5.012, 1.06.3.005

SITUACIÓN	¿ERRADICAR H. PYLORI?	CONTROL POST-TRATAMIENTO
Úlcera duodenal (cualquiera)	Siempre, aunque el test sea negativo	Antígeno fecal / test del aliento a las 4 sem
Úlcera gástrica con H. pylori (+)	Sí	Endoscopía (cicatrización + biopsias)
Úlcera gástrica con H. pylori (–)	No	Endoscopía de control
ERGE con H. pylori (+)	No — no hay asociación	No aplica
Linfoma MALT gástrico	Sí — es el tratamiento (no quimioterapia)	Endoscopía seriada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.2

Hombre de 52 años consulta por epigastralgia urente de 6 semanas que aumenta con el ayuno y mejora al comer. No baja de peso ni presenta anemia. Por la edad se solicita endoscopía digestiva alta, que muestra una úlcera gástrica de 8 mm en curvatura menor; se toman biopsias del borde y el test de ureasa es positivo.

Conducta oficial. Úlcera gástrica con H. pylori positivo: el tratamiento es la terapia erradicadora de primera línea (IBP + amoxicilina + claritromicina 14 días) seguida de IBP hasta completar 6–8 semanas para asegurar la cicatrización. Toda úlcera gástrica obliga a biopsiar el borde para descartar cáncer y a repetir la endoscopía de control, tanto para verificar la cicatrización como para confirmar la erradicación. Dar solo IBP dejaría la causa sin tratar y la recidiva sería del 90 %.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El omeprazol trata el reflujo; la úlcera péptica se trata erradicando H. pylori. Sin erradicación, la úlcera recidiva en el 90 %.
- Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test de H. pylori sea negativo (falso negativo frecuente con IBP o sangrado reciente).
- Toda úlcera gástrica exige biopsia del borde para descartar cáncer y endoscopía de control tras el tratamiento.
- Primera línea: IBP + amoxicilina + claritromicina por 14 días. Segunda línea: cuádruple con bismuto, sin claritromicina.
- Linfoma MALT gástrico: se trata con erradicación de H. pylori, no con quimioterapia. En la ERGE no se erradica.
- Úlcera perforada: radiografía de tórax de pie (neumoperitoneo) y cirugía urgente; la endoscopía está contraindicada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 40 años con úlcera duodenal en la endoscopía. El test de ureasa para H. pylori resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta respecto de la erradicación?

A) No erradicar, porque el test de H. pylori es negativo
B) Erradicar igualmente con esquema de primera línea
C) Indicar solo omeprazol por 6 semanas
D) Repetir la endoscopía en 4 semanas antes de decidir
E) Solicitar antígeno fecal y erradicar solo si es positivo

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Mujer de 35 años con epigastralgia urente de 2 meses, sin baja de peso, anemia ni disfagia. La endoscopía digestiva alta es completamente normal y el test de H. pylori es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?

A) Úlcera péptica; iniciar terapia de erradicación
B) Cáncer gástrico incipiente; repetir endoscopía con cromoendoscopia
C) Dispepsia funcional; educación, manejo del estrés y prueba con IBP
D) Gastroparesia; solicitar cintigrafía de vaciamiento gástrico
E) ERGE; iniciar IBP a permanencia y cirugía antirreflujo

Más preguntas online de Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori →

1.3. Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

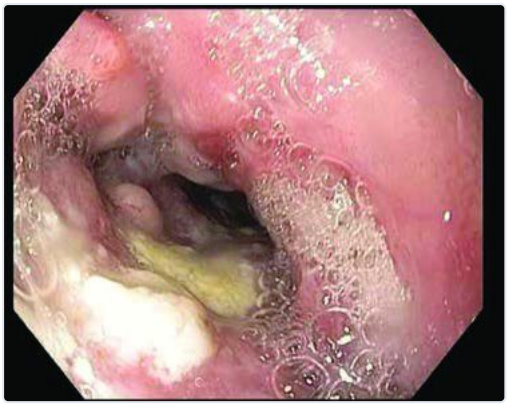
CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.013 | 4.01.1.004 | 4.01.1.005 | 4.01.1.002 | 1.06.4.002 | 6.03.1.032

¿POR QUÉ?

La sola descripción de cómo traga el paciente ya orienta la causa. Si la comida "se atasca" primero con los sólidos y luego progresa a los líquidos, hay una obstrucción que crece (disfagia lógica → cáncer). Si el problema es errático y afecta a los líquidos desde el inicio, el músculo no coordina (disfagia ilógica → acalasia, esclerodermia). El examen correcto se deduce del patrón, no al revés.

1. DISFAGIA LÓGICA VS ILÓGICA

Disfagia lógica: progresiva, comienza con los sólidos y luego afecta a los líquidos. Traduce una obstrucción mecánica que crece; la causa a descartar es el cáncer de esófago, sobre todo si hay baja de peso. **(ver Imagen 1.3A y B)** 1.06.1.013



Cáncer de esófago distal obstructivo en endoscopía

Disfagia ilógica: fluctuante o errática, afecta a los líquidos desde el inicio. Traduce un trastorno motor: acalasia o esclerodermia. Regla de oro: si afecta a los líquidos desde el principio, piensa en el músculo, no en un tumor.

2. CÁNCER DE ESÓFAGO (DISFAGIA LÓGICA)

Disfagia lógica progresiva + baja de peso, en un fumador (carcinoma escamoso) o con ERGE/Barrett de larga data (adenocarcinoma). El cáncer de cardias se comporta igual. 1.06.1.013 | 4.01.1.005

El diagnóstico es **endoscopía digestiva alta con biopsia**. La etapificación usa TAC de tórax-abdomen y endosonografía transesofágica (evalúa invasión transmural, el principal factor pronóstico). El único tratamiento curativo es la cirugía; la radioterapia tiene un rol relevante en el esófago. 4.01.1.005

3. ACALASIA (DISFAGIA ILÓGICA BAJA)

Disfagia ilógica y baja (a nivel del esfínter esofágico inferior), fluctuante, con neumonías aspirativas a repetición y regurgitación de alimentos no ácidos (nunca llegaron al estómago). 1.06.1.013 | 4.01.1.004

El diagnóstico de elección es la **manometría esofágica**: peristalsis disminuida + tono del esfínter esofágico inferior aumentado que no relaja. El esofagograma muestra dilatación del cuerpo con imagen "en pico de pájaro". Tratamiento: **esfinterotomía (miotomía) del EEI** de elección; toxina botulínica endoscópica en etapas iniciales o en pacientes no operables; los bloqueadores de calcio relajan el EEI pero producen reflujo. **(ver Imagen 1.3C)** 4.01.1.004 | 1.06.4.002

4. ESCLERODERMIA Y DIVERTÍCULO DE ZENKER

Esclerodermia / CREST: disfagia ilógica + pirosis intensa, en el contexto de fenómeno de Raynaud, calcinosis, telangiectasias. Es un trastorno motor esofágico con reflujo ácido grave (a diferencia de la acalasia). 1.06.1.013

Divertículo de Zenker: disfagia alta (esfínter esofágico superior) + halitosis marcada (alimento retenido que fermenta) + regurgitación de comida no digerida. Diagnóstico con **esofagograma con bario** (no endoscopía, no manometría). Tratamiento quirúrgico: diverticulectomía + miotomía cricofaríngea. 1.06.1.013 | 4.01.1.002 | 1.06.4.002



Divertículo de Zenker en esofagograma con bario



Divertículo de Zenker

5. TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN OROFARÍNGEA

Disfagia orofaríngea (alta): a diferencia de la esofágica, la dificultad aparece en el momento mismo de tragar (cuesta iniciar la deglución, el bolo «no baja»), con tos o atoragantamiento, voz «húmeda», regurgitación nasal y, a la larga, neumonías aspirativas y baja de peso. Sus causas son sobre todo **neurológicas** (accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, demencia, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia), el envejecimiento y los tumores o la radioterapia de cabeza y cuello. Hay que sospecharla en todo adulto mayor con neumonías a repetición. 6.03.1.032

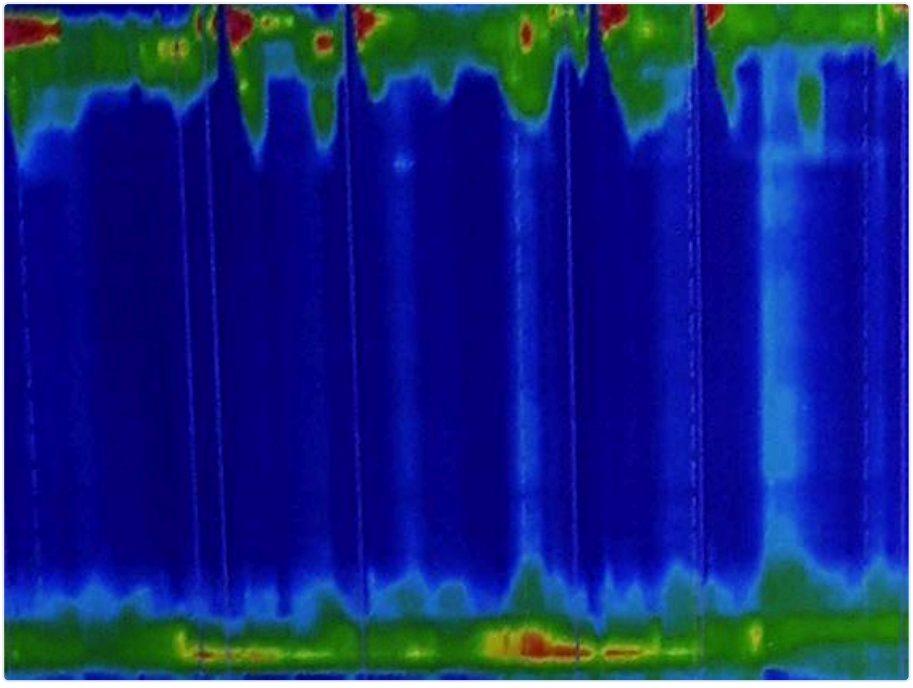
Manejo inicial (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): evaluación a la cabecera con una prueba de deglución de agua en pequeños volúmenes; si hay tos, voz húmeda o desaturación, **suspender la vía oral** y derivar. Medidas: sentar al paciente a 90°, flexionar el mentón, espesar los líquidos y dar dieta blanda o triturada en porciones pequeñas, y cuidar la higiene bucal. La videofluoroscopía o la nasofibroscopía de deglución (fonoaudiología/otorrinolaringología) define el trastorno; si la disfagia se prolonga más de unas 4 semanas o no hay vía oral segura, se indica alimentación enteral por sonda nasogástrica y, a largo plazo, gastrostomía.



A. CÁNCER DE ESÓFAGO



B. MEGAESÓFAGO CHAGÁSICO



C. MANOMETRÍA

Imagen 1.3

TABLA 1.3 · DISFAGIA — PATRÓN CLÍNICO Y EXAMEN DE ELECCIÓN

1.06.1.013, 4.01.1.004, 4.01.1.005, 4.01.1.002, 1.06.4.002, 6.03.1.032

CUADRO	CLAVE CLÍNICA	EXAMEN DE ELECCIÓN
Cáncer de esófago	Disfagia lógica progresiva + baja de peso	Endoscopía digestiva alta + biopsia
Acalasia	Disfagia ilógica baja + neumonías aspirativas	Manometría esofágica
Esclerodermia (CREST)	Disfagia ilógica + pirosis + Raynaud/calcinosis	Manometría + anticuerpos (anti-Scl-70, anticentrómero)
Divertículo de Zenker	Disfagia alta + halitosis + regurgitación	Esofagograma con bario
Anillo de Schatzki / estenosis péptica	Disfagia lógica intermitente a sólidos, sin baja de peso	Endoscopía (permite dilatar)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.3

Mujer de 46 años consulta por 8 meses de dificultad para tragar, más marcada con los líquidos que con los sólidos, de carácter fluctuante. Ha tenido dos neumonías basales derechas en el último año y regurgita alimentos sin sabor ácido durante la noche. No ha bajado de peso.

Conducta oficial. Disfagia ilógica (afecta a los líquidos desde el inicio, fluctuante) con neumonías aspirativas y regurgitación de contenido no ácido: el cuadro es acalasia. El examen de elección es la manometría esofágica, que mostrará aperistalsis del cuerpo y un esfínter esofágico inferior hipertónico que no relaja. La endoscopía se hace igualmente para descartar una pseudoacalasia por cáncer del cardias, pero no es el examen que confirma el trastorno motor.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Disfagia lógica (sólidos → líquidos, progresiva) = obstrucción = cáncer de esófago → endoscopía con biopsia.
- Disfagia ilógica (líquidos desde el inicio, fluctuante) = trastorno motor = acalasia o esclerodermia → manometría.
- Acalasia: regurgitación no ácida y neumonías aspirativas; tratamiento de elección = miotomía del EEI.
- Disfagia alta + halitosis = divertículo de Zenker → esofagograma con bario, tratamiento quirúrgico.
- Los bloqueadores de calcio relajan el EEI (útiles en acalasia inicial) pero producen reflujo; no se usan para tratar la ERGE.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 62 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 3 meses de disfagia que comenzó con la carne y el pan y ahora también le cuesta tragar líquidos, con baja de 7 kg de peso. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Manometría esofágica
B) Esofagograma con bario
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia
D) TAC de tórax con contraste
E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Mujer de 71 años consulta por sensación de que la comida "se le queda en la garganta" desde hace un año, regurgitación de alimentos no digeridos y halitosis intensa que le notan sus familiares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer de esófago
B) Acalasia
C) Divertículo de Zenker
D) Esclerodermia esofágica
E) Estenosis péptica por reflujo

Más preguntas online de Disfagia y Trastornos Motores del Esófago →

1.4. Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.030 4.01.2.019 4.01.2.001 4.01.2.003 4.01.4.008

¿POR QUÉ?

Las tres emergencias de esta clase comparten una regla contraintuitiva: la endoscopía, que parece el examen natural, está contraindicada en la úlcera perforada y en la perforación esofágica (el aire insuflado agranda la fuga), pero es la primera medida en la ingesta de cáustico (define el daño y la conducta). Y en la ingesta de cáustico, el carbón activado y el lavado gástrico están prohibidos: el daño ya ocurrió y ambos lo empeoran.

1. ÚLCERA GASTRODUODENAL PERFORADA

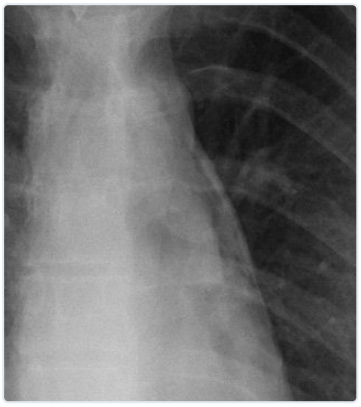
Antecedente de síndrome ulceroso + dolor epigástrico brusco "en puñalada" que se generaliza a todo el abdomen. Al examen: abdomen en tabla, Blumberg positivo, ruidos hidroaéreos abolidos. Lo que se vierte al peritoneo es contenido ácido, muy irritante. **(ver Imagen 1.4C)** 1.06.1.030 4.01.2.003

Examen inicial: radiografía de tórax de pie buscando neumoperitoneo (aire subdiafragmático, sobre todo bajo el hemidiafragma derecho). Si no está disponible, radiografía de abdomen de pie. **Tratamiento:** cirugía de urgencia (sutura + parche de epiplón de Graham); suero, IBP endovenoso y antibióticos de amplio espectro son complementos. La endoscopía está contraindicada. **(ver Imagen 1.4A)**

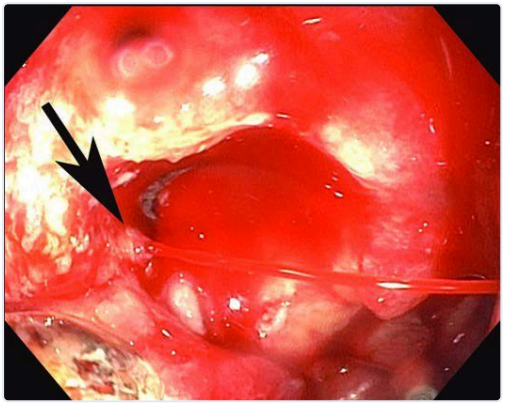
2. PERFORACIÓN ESOFÁGICA (SÍNDROME DE BOERHAAVE)

Causa más frecuente: iatrogénica por endoscopía. El síndrome de Boerhaave es la perforación espontánea tras vómitos intensos. Tríada: dolor torácico (o cervical) + vómitos + enfisema subcutáneo crepitante. 4.01.2.019

No confundir: vómitos → hematemesis = Mallory-Weiss (desgarro mucoso, se maneja distinto); vómitos → dolor torácico + enfisema + sepsis = Boerhaave (perforación transmural). Examen inicial: radiografía de tórax (neumomediastino, enfisema); TAC de tórax si la radiografía es negativa y la sospecha alta. La endoscopía está contraindicada. La complicación temida es la mediastinitis aguda. Tratamiento: cirugía de urgencia; manejo conservador (régimen cero + antibióticos) solo en perforaciones pequeñas, contenidas y con buena evolución. **(ver Imagen 1.4B)**



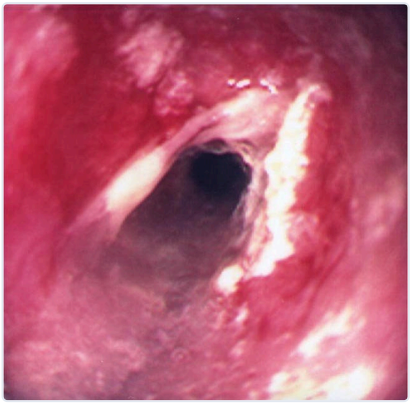
Síndrome de Boerhaave



Desgarro de Mallory-Weiss en la unión gastroesofágica

3. INGESTA DE CÁUSTICO (SODA CÁUSTICA)

Dolor y edema desde los labios hasta el epigastrio, sialorrea, disfagia. Puede haber hemorragia digestiva o perforación con peritonitis/mediastinitis. 4.01.2.001



Esofagitis cáustica

Primera medida: endoscopía digestiva alta precoz (idealmente en las primeras 12–24 h) para graduar el daño y decidir la conducta. Están **contraindicados el carbón activado y el lavado gástrico** (el daño es inmediato e irreversible, y ambos lo agravan); tampoco se administran neutralizantes ni se provoca el vómito.

4. CONDUCTA SEGÚN LA ENDOSCOPÍA EN LA INGESTA DE CÁUSTICO

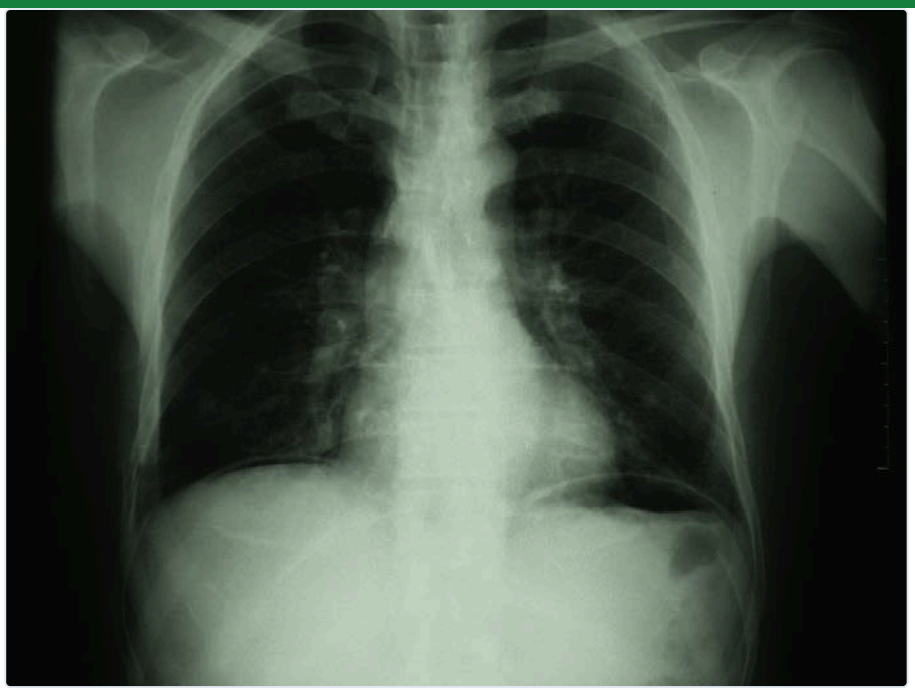
Mucosa normal o eritema leve: observación y realimentación oral progresiva. Úlceras / inflamación significativa: régimen cero, nutrición parenteral y endoscopía de control. 4.01.2.001

Necrosis extensa o perforación: régimen cero, nutrición parenteral y cirugía de urgencia. Secuela tardía: estenosis esofágica cicatricial (dilataciones o reconstrucción con estómago o colon) y riesgo aumentado de carcinoma escamoso a largo plazo.

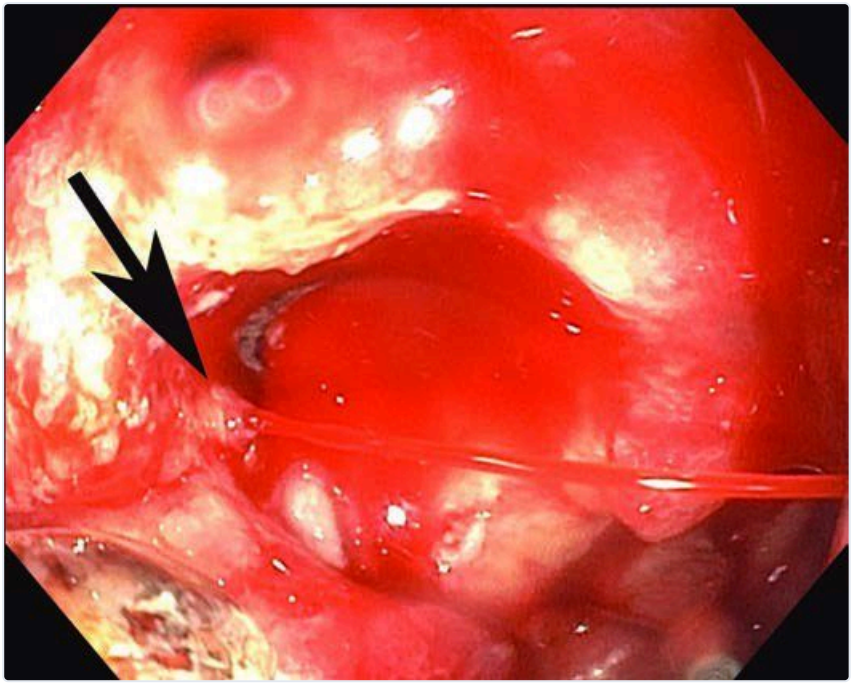
5. ESTUDIOS RADIOLÓGICOS CONTRASTADOS: CUÁNDO Y CON QUÉ MEDIO

Qué se pide y qué se informa (nivel: emplear el informe): esofagograma o tránsito esófago-gastro-duodenal con bario (acalasia en «pico de pájaro», divertículo de Zenker, estenosis, nicho ulceroso), tránsito intestinal (estenosis de Crohn) y enema baritada (cáncer en «manzana mordida», divertículos, vólvulo, megacolon). El informe se lee por sus términos clave: *defecto de llenado* (masa o cuerpo extraño), *nicho* (úlcera), *estenosis* y *dilatación* proximal, o *extravasación del medio* (perforación). 4.01.4.008

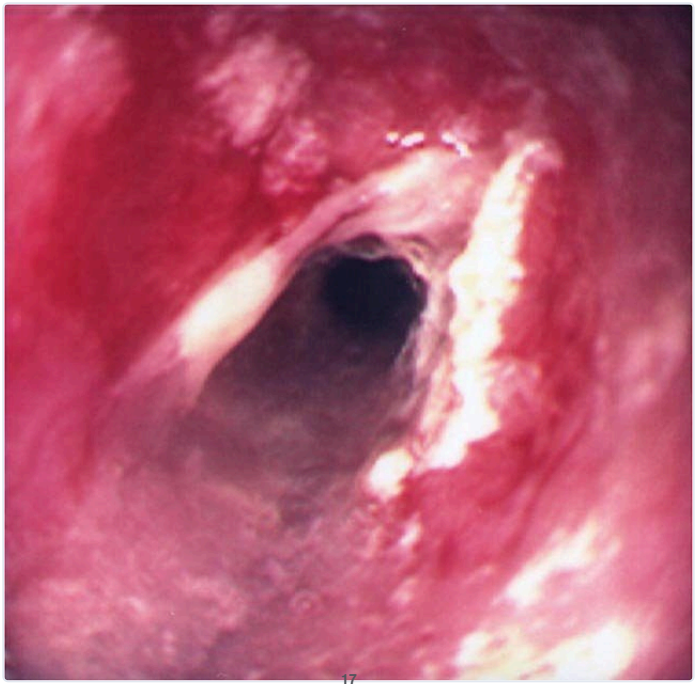
Regla de seguridad: ante la **sospecha de perforación** (esofágica, gástrica o intestinal) se usa un medio de contraste **hidrosoluble** (diatrizoato) y no bario, porque el bario que sale a mediastino o peritoneo causa mediastinitis o peritonitis graves. Si hay riesgo de aspiración se prefiere un medio no iónico. La enema baritada está contraindicada en la colitis fulminante, el megacolon tóxico y la perforación colónica; en la sospecha de perforación el estudio de elección es la TAC con contraste.



A. NEUMOPERITONEO



B. MALLORY-WEISS



C. ESOFAGITIS CÁUSTICA

Imagen 1.4

TABLA 1.4 · TRES URGENCIAS DEL TUBO DIGESTIVO ALTO — EXAMEN Y CONTRAINDICACIÓN 1.06.1.030, 4.01.2.019, 4.01.2.001, 4.01.2.003, 4.01.4.008

CUADRO	EXAMEN INICIAL	TRATAMIENTO	CONTRAINDICADO
Úlcera perforada	Rx tórax de pie (neumoperitoneo)	Cirugía de urgencia	Endoscopía
Perforación esofágica (Boerhaave)	Rx tórax → TAC tórax (neumomediastino)	Cirugía de urgencia	Endoscopía
Ingesta de cáustico	Endoscopía precoz (grada el daño)	Según hallazgo endoscópico	Carbón activado · lavado gástrico · vómito
Mallory-Weiss	Endoscopía digestiva alta	Suele ceder solo; hemostasia endoscópica si sangra	—

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 58 años con antecedente de epigastralgia de meses consulta por dolor epigástrico de inicio súbito, "como una puñalada", que en una hora se extendió a todo el abdomen. Está pálido, taquicárdico, con el abdomen rígido y doloroso de forma difusa, sin ruidos hidroaéreos.

Conducta oficial. El cuadro es una úlcera péptica perforada: síndrome ulceroso previo + dolor epigástrico brusco que se generaliza + abdomen en tabla con peritonitis difusa. El examen inicial es la radiografía de tórax de pie para buscar neumoperitoneo, y el tratamiento es la cirugía de urgencia (sutura con parche de epiplón). Suero, IBP endovenoso y antibióticos de amplio espectro acompañan, pero no reemplazan la cirugía. La endoscopía está contraindicada porque el aire insuflado aumenta la filtración peritoneal.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Úlcera perforada: dolor en puñalada + abdomen en tabla → Rx tórax de pie (neumoperitoneo) → cirugía urgente. Endoscopía contraindicada.
- Perforación esofágica: dolor torácico + vómitos + enfisema subcutáneo → Rx/TAC tórax (neumomediastino). Causa más frecuente: iatrogénica.
- Boerhaave (vómitos → perforación) ≠ Mallory-Weiss (vómitos → hematemesis).
- Ingesta de cáustico: endoscopía precoz define la conducta. Carbón activado y lavado gástrico están contraindicados.
- Si el enunciado ofrece suero + antibióticos + IBP + cirugía en una perforación, la respuesta es siempre la cirugía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Niño de 3 años que hace 2 horas bebió un sorbo de soda cáustica del envase mal rotulado. Presenta sialorrea y llanto al tragar, sin dificultad respiratoria. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Lavado gástrico con sonda nasogástrica
B) Carbón activado por vía oral
C) Endoscopía digestiva alta en las primeras horas
D) Administrar leche o vinagre diluido para neutralizar
E) Provocar el vómito y observar

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Hombre de 45 años, tras una cena copiosa con alcohol y varios episodios de vómitos, presenta dolor torácico intenso y, al examen, crepitación a la palpación del cuello. Está febril y taquicárdico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Mallory-Weiss
B) Perforación esofágica (síndrome de Boerhaave)
C) Infarto agudo de miocardio
D) Neumotórax espontáneo
E) Disección aórtica

Más preguntas online de Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico →

1.5. Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.004 | 4.01.1.005 | 1.06.3.003 | 4.01.1.007 | 4.01.1.008 | 4.01.3.013

¿POR QUÉ?

El cáncer gástrico da síntomas tarde: cuando aparece la epigastralgia o el síndrome pilórico, el tumor suele estar avanzado y el pronóstico es malo. Por eso Chile garantiza el acceso a endoscopía en todo mayor de 40 años con dispepsia: el objetivo es pillar el cáncer incipiente (limitado a mucosa-submucosa), el único con buen pronóstico. El factor que decide el pronóstico es la profundidad de invasión de la pared, no las adenopatías.

1. LO COMÚN A LOS CÁNCERES DIGESTIVOS ALTOS

Comparten baja de peso, hemorragia digestiva (con anemia ferropénica) y anorexia. El diagnóstico es siempre **endoscopía digestiva alta con biopsia**; la etapificación, TAC de tórax-abdomen-pelvis. **(ver Imagen 1.5A y B)** 1.06.1.004 | 4.01.1.008 | 4.01.1.005

El principal factor pronóstico es la **invasión transmural** (qué tan profundo penetra el tumor), no las adenopatías ni las metástasis. El único tratamiento curativo es la cirugía; quimio y radioterapia son adyuvantes. **(ver Imagen 1.5C)**

2. CÁNCER DE ESÓFAGO

Se presenta con disfagia lógica progresiva + baja de peso. Dos tipos: **carcinoma escamoso** (tabaco y alcohol, tercio medio) y **adenocarcinoma** (ERGE crónica y esófago de Barrett, tercio distal). El cáncer de cardias se maneja igual. 4.01.1.005



Cáncer de esófago distal obstructivo en endoscopía

Diagnóstico: endoscopía + biopsia. Etapificación: TAC + endosonografía transesofágica (invasión de la pared). Tratamiento: cirugía (esofagectomía); la radioterapia tiene un rol destacado, con frecuencia neoadyuvante.

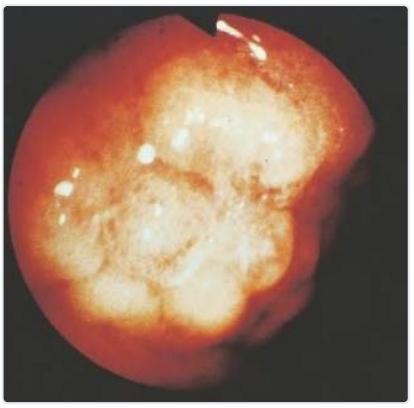
3. CÁNCER GÁSTRICO

Primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile (segunda en mujeres, tras el de mama). Causa principal: H. pylori; factores de riesgo: gastritis atrófica, metaplasia intestinal, antecedente familiar, dieta rica en ahumados y sal. 1.06.1.004 | 4.01.1.008 | 1.06.3.003 | 4.01.3.013

Formas de presentación: epigastralgia urente idéntica a la úlcera (siempre endoscopiar), **síndrome pilórico** (vómitos posprandiales de retención, en aumento = cáncer hasta demostrar lo contrario), masa epigástrica palpable, adenopatía supraclavicular izquierda (ganglio de Virchow). 1.06.1.004 | 4.01.1.008

4. CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER GÁSTRICO

Cáncer incipiente: limitado a mucosa y submucosa, independiente de las adenopatías. Buen pronóstico; tratamiento con resección (endoscópica en casos seleccionados o gastrectomía). 1.06.1.004 | 4.01.1.008

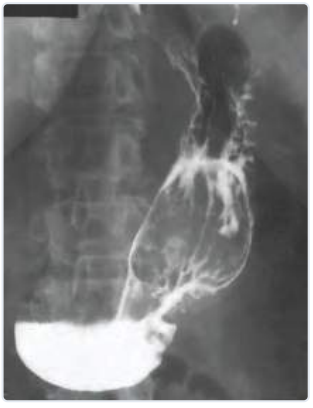


Cáncer gástrico incipiente

Cáncer avanzado: compromete la muscular propia o más allá. Gastrectomía (subtotal o total) con linfadenectomía D2 + quimioterapia perioperatoria. La detección precoz por endoscopía GES en dispépticos ≥ 40 años busca aumentar la proporción de cánceres incipientes.

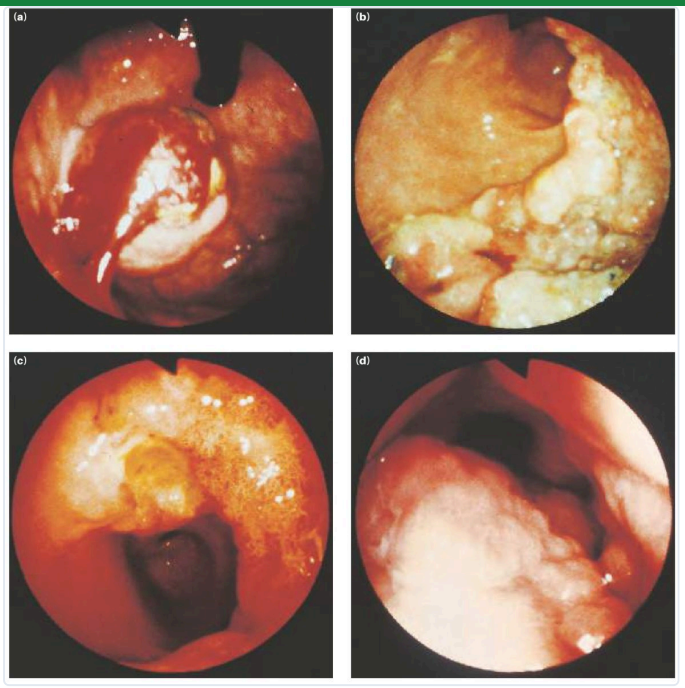
5. TUMORES GÁSTRICOS BENIGNOS Y EPIDEMIOLOGÍA DE LOS CÁNCERES DIGESTIVOS

Tumores gástricos benignos (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): lo más frecuente son los **pólipos** (hiperplásicos y de glándulas fúndicas, casi siempre benignos; el pólipo adenomatoso es premaligno y obliga a resecarlo); los tumores **submucosos** —**GIST**, leiomioma y tumor neuroendocrino— se ven como un abombamiento de mucosa normal, a veces con una úlcera central que sangra (hemorragia digestiva alta o anemia). Se diagnostican por endoscopía con biopsia y ecoendoscopía; el pólipo se reseca (polipectomía) y se busca H. pylori, y el GIST (c-KIT positivo) se reseca quirúrgicamente, con imatinib en los de alto riesgo. Todo tumor gástrico se deriva para estudio. 4.01.1.007



Tumor de músculo liso del estómago con ulceración

Epidemiología de los cánceres digestivos en Chile: los tumores del tubo digestivo y de los órganos anexos (estómago, vesícula y vías biliares, colon y recto, hígado, páncreas y esófago) aportan una proporción muy alta de las muertes por cáncer. El **cáncer gástrico** y el de **vesícula biliar** destacan por tasas de las más elevadas del mundo (la vesícula, sobre todo en mujeres), el **colorrectal** aumenta con el envejecimiento y la dieta occidental, el **hepatocarcinoma** crece con la cirrosis (alcohol, virus C, esteatohepatitis) y el **de páncreas** tiene sobrevida a 5 años menor de 10 %. La mayoría se diagnostica en etapa avanzada, por eso importan el tamizaje y la endoscopía precoz. 1.06.3.003 | 4.01.3.013



A. BORRMANN I A IV



C. TUMOR DE MÚSCULO LISO

Imagen 1.5

TABLA 1.5 · PRESENTACIONES QUE OBLIGAN A ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA

1.06.1.004, 4.01.1.005, 1.06.3.003, 4.01.1.007, 4.01.1.008, 4.01.3.013

PRESENTACIÓN	SOSPECHA	CONDUCTA
Epigastralgia ≥ 40 años o con signo de alarma	Úlcera o cáncer gástrico	Endoscopía digestiva alta con biopsias
Vómitos posprandiales de retención, en aumento	Cáncer gástrico con síndrome pilórico	Endoscopía digestiva alta
Baja de peso + epigastralgia	Cáncer gástrico	Endoscopía digestiva alta
Baja de peso + epigastralgia + ictericia	Cáncer de páncreas	TAC de abdomen con contraste
Disfagia lógica progresiva + baja de peso	Cáncer de esófago	Endoscopía digestiva alta con biopsia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.5

Hombre de 68 años consulta por 3 meses de plenitud posprandial y vómitos de alimentos ingeridos horas antes, cada vez más frecuentes, con baja de 9 kg de peso. Al examen destaca un chapoteo gástrico de ayuno y una adenopatía supraclavicular izquierda pequeña.

Conducta oficial. Síndrome pilórico (vómitos posprandiales de retención en aumento) con baja de peso y ganglio de Virchow: es un cáncer gástrico avanzado con obstrucción de la salida gástrica hasta que se demuestre lo contrario. El examen es la endoscopía digestiva alta con biopsias; luego se etapifica con TAC. La adenopatía supraclavicular izquierda indica enfermedad metastásica y contraindica la cirugía con intención curativa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Cáncer gástrico: primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile; causa principal H. pylori.
- Toda epigastralgia ≥ 40 años o con signo de alarma exige endoscopía digestiva alta con biopsias (GES).
- Síndrome pilórico (vómitos de retención en aumento) en adulto = cáncer gástrico hasta demostrar lo contrario.
- El factor pronóstico principal de los cánceres digestivos es la invasión transmural, no las adenopatías.
- Cáncer de esófago: escamoso (tabaco/alcohol) vs adenocarcinoma (ERGE/Barrett); radioterapia con rol importante.
- Baja de peso + epigastralgia + ictericia cambia la sospecha a cáncer de páncreas → pedir TAC, no endoscopía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 60 años consulta por baja de 8 kg de peso en 3 meses, epigastralgia sorda e hiporexia. No tiene ictericia. ¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) TAC de abdomen y pelvis con contraste
B) Endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Ecografía abdominal
D) Marcadores tumorales (CEA, CA 19-9)
E) Tránsito esofagogastroduodenal con bario

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Mujer de 55 años con endoscopía por dispepsia que informa un adenocarcinoma gástrico limitado a la mucosa, sin invasión de la submucosa, en una lesión de 15 mm bien diferenciada y sin úlcera. El TAC no muestra adenopatías ni metástasis. ¿Qué define el pronóstico y cuál es la conducta?

A) El tamaño de la lesión; observación con endoscopías seriadas
B) La profundidad de invasión de la pared; resección (endoscópica o quirúrgica) con intención curativa
C) La presencia de H. pylori; solo terapia de erradicación
D) El grado de diferenciación; quimioterapia paliativa
E) El nivel de CEA; radioterapia externa

Más preguntas online de Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico →

1.6. Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.01.1.006 4.01.1.040 4.01.1.041

¿POR QUÉ?

Estos tres temas casi nunca son el diagnóstico principal de una pregunta; aparecen como alternativa a descartar o como hallazgo incidental en una radiografía. Lo único que hay que tener claro es qué es benigno y se observa (hernia hiatal tipo I) y qué necesita cirugía (hernia paraesofágica, hernia diafragmática traumática, timoma con miastenia).

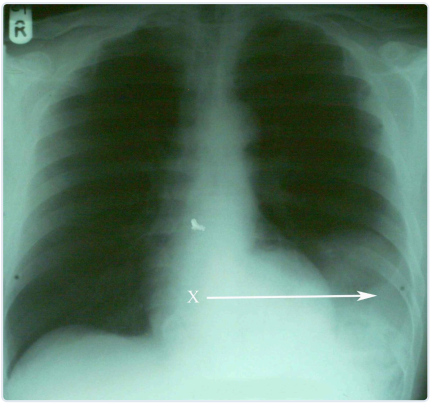
1. HERNIA HIATAL

Tipo I (por deslizamiento), > 95 % de los casos: la unión gastroesofágica asciende al tórax. Es prácticamente una variante normal; solo se trata el reflujo si lo hay. Un hallazgo incidental en endoscopía, sin síntomas, se observa. **(ver Imagen 1.6B)** 4.01.1.006

Tipo II–IV (paraesofágica), < 5 %: el fondo gástrico hernia junto al esófago, que se mantiene en su sitio. Es una hernia "real" con riesgo de vólvulo, incarceración y estrangulación → **cirugía electiva** (reparación + fundupli-catura), y urgente si se complica. **(ver Imagen 1.6A)**

2. HERNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA DEL ADULTO

Tras un trauma toracoabdominal (más frecuente a izquierda). Puede diagnosticarse en fase aguda o años después como hallazgo: radiografía de tórax con asas intestinales o cámara gástrica en el hemitórax. 4.01.1.040

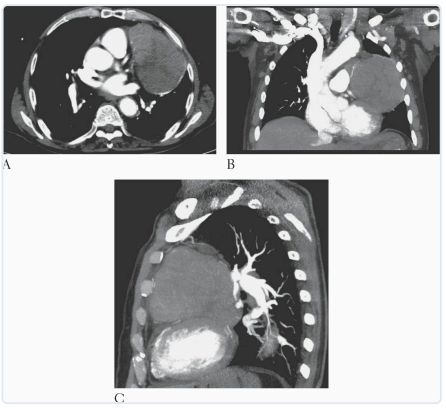


Hernia diafragmática traumática

Fase aguda (con compromiso respiratorio o víscera estrangulada): cirugía de urgencia. **Fase crónica** (hallazgo, paciente estable): cirugía electiva para prevenir la obstrucción o estrangulación futura. No se observa una hernia diafragmática verdadera.

3. TUMORES DEL MEDIASTINO

La localización orienta la causa. **Mediastino anterior — regla de las 4 T:** Timoma, Terrible linfoma, Teratoma (y tumores germinales), Tiroides (bocio endotorácico). **(ver Imagen 1.6C)** 4.01.1.041



Masa mediastínica anterior



Masa mediastínica anterior

Mediastino medio: quistes broncogénicos y pericárdicos, adenopatías, aneurismas. **Mediastino posterior:** tumores neurogénicos (neurinoma, ganglioneuroma) — los más frecuentes del mediastino en total.

4. ESTUDIO Y MANEJO DE LA MASA MEDIASTÍNICA

El examen de elección es el **TAC de tórax con contraste** (localización, tamaño, relaciones vasculares, características). Según el caso se completa con marcadores (alfa-fetoproteína y beta-hCG en tumores germinales), biopsia percutánea o quirúrgica. 4.01.1.041

Timoma: se reseca si es grande, sintomático o se asocia a **miastenia gravis** (la timectomía puede mejorar la miastenia). El linfoma se trata con quimioterapia, no cirugía; el teratoma maduro se reseca.



A. HERNIA PARAESOFÁGICA

B. COMPARTIMENTOS



C. MASA MEDIASTINO ANTERIOR

Imagen 1.6

TABLA 1.6 · QUÉ SE OBSERVA Y QUÉ SE OPERA 4.01.1.006, 4.01.1.040, 4.01.1.041

HALLAZGO	CONDUCTA
Hernia hiatal tipo I asintomática	Observar; tratar el reflujo solo si hay síntomas
Hernia hiatal paraesofágica (tipo II–IV)	Cirugía electiva (riesgo de vólvulo/estrangulación)
Hernia diafragmática traumática aguda	Cirugía de urgencia
Hernia diafragmática traumática crónica (hallazgo)	Cirugía electiva
Masa en mediastino (cualquier compartimento)	TAC de tórax con contraste
Timoma con miastenia gravis	Timectomía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.6

Hombre de 34 años, con antecedente de accidente de tránsito con trauma toracoabdominal hace 3 años, se realiza una radiografía de tórax por un cuadro respiratorio banal. El informe describe imágenes de asas intestinales ocupando el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Está asintomático desde el punto de vista digestivo.

Conducta oficial. Es una hernia diafragmática traumática en fase crónica, descubierta como hallazgo. Aunque el paciente esté asintomático, una hernia diafragmática verdadera no se observa: se repara de forma electiva para evitar la obstrucción, la incarceración o la estrangulación de las asas herniadas, complicaciones de alta mortalidad. La cirugía de urgencia se reserva para la fase aguda o para la hernia complicada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Hernia hiatal tipo I (deslizamiento, > 95 %): casi normal; se observa y solo se trata el reflujo si existe.
- Hernia hiatal paraesofágica (< 5 %): cirugía electiva por riesgo de vólvulo y estrangulación.
- Hernia diafragmática traumática: aguda → cirugía urgente; crónica (hallazgo) → cirugía electiva. Nunca se observa.
- Tumores del mediastino anterior: 4 T = Timoma, Terrible linfoma, Teratoma, Tiroides.
- Toda masa mediastínica se estudia con TAC de tórax con contraste. Timoma + miastenia gravis → timectomía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Mujer de 50 años, asintomática, a quien se realiza una endoscopía digestiva alta por anemia y se informa como hallazgo una hernia hiatal por deslizamiento de 2 cm. No refiere pirosis ni regurgitación. ¿Cuál es la conducta?

A) Cirugía antirreflujo (funduplicatura de Nissen)
B) Iniciar omeprazol profiláctico de por vida
C) Observación, sin tratamiento específico
D) Reparación laparoscópica electiva del hiato
E) pH-metría de 24 horas y decidir según resultado

Caso representativo · banco EUNACOM

2. En una radiografía de tórax de control se observa un ensanchamiento del mediastino anterior en un paciente de 40 años con diplopía y fatigabilidad muscular que mejora con el reposo. ¿Cuál es el examen a solicitar y la sospecha?

A) Ecografía torácica; quiste pericárdico
B) TAC de tórax con contraste; timoma asociado a miastenia gravis
C) Resonancia de columna; tumor neurogénico
D) PET-CT; linfoma de Hodgkin
E) Cintigrafía tiroidea; bocio endotorácico

Más preguntas online de Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba...	**El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H_2 están obsoletos...**	—
Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori	El omeprazol trata el reflujo; la úlcera péptica se trata erradicando H. pylori. Sin...	**Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test de H. pylori sea negativo (falso...**	Toda úlcera gástrica exige biopsia del borde para descartar cáncer y endoscopía de...
Disfagia y Trastornos Motores del Esófago	Disfagia lógica (sólidos → líquidos, progresiva) = obstrucción = cáncer de esófago →...	**Disfagia ilógica (líquidos desde el inicio, fluctuante) = trastorno motor = acalasia o...**	Disfagia ilógica (afecta a los líquidos desde el inicio, fluctuante) con neumonías...
Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico	Úlcera perforada: dolor en puñalada + abdomen en tabla → Rx tórax de pie...	**Perforación esofágica: dolor torácico + vómitos + enfisema subcutáneo → Rx/TAC tórax...**	Ingesta de cáustico: endoscopía precoz define la conducta. Carbón activado y lavado...
Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico	Cáncer gástrico: primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile; causa...	**Toda epigastralgia ≥ 40 años o con signo de alarma exige endoscopía digestiva alta con...**	Síndrome pilórico (vómitos posprandiales de retención en aumento) con baja de peso y...
Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino	Hernia hiatal tipo I (deslizamiento, > 95 %): casi normal; se observa y solo se trata...	**Hernia hiatal paraesofágica (< 5 %): cirugía electiva por riesgo de vólvulo y...**	Hernia diafragmática traumática: aguda → cirugía urgente; crónica (hallazgo) → cirugía...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.

El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H_2 están obsoletos y no se combinan con IBP.

Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a...

Barrett = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El IBP se toma en ayunas, 30–60 min antes de comer. Los antagonistas H_2 están obsoletos y no se combinan con IBP.
- Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > 50 años, > 5 años de pirosis) obligan a endoscopía.
- Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test de H. pylori sea negativo (falso negativo frecuente con IBP o sangrado reciente).
- Toda úlcera gástrica exige biopsia del borde para descartar cáncer y endoscopía de control tras el tratamiento.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de...	Tema 1.1 →
El omeprazol trata el reflujo; la úlcera péptica se trata erradicando H. pylori. Sin erradicación, la úlcera...	Tema 1.2 →
Disfagia lógica (sólidos → líquidos, progresiva) = obstrucción = cáncer de esófago → endoscopía con biopsia.	Tema 1.3 →
Úlcera perforada: dolor en puñalada + abdomen en tabla → Rx tórax de pie (neumoperitoneo) → cirugía urgente...	Tema 1.4 →
Cáncer gástrico: primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile; causa principal H. pylori.	Tema 1.5 →
Hernia hiatal tipo I (deslizamiento, > 95 %): casi normal; se observa y solo se trata el reflujo si existe.	Tema 1.6 →

MANUAL EUNACOM DE GASTROENTEROLOGÍA

BLOQUE 02 DE 06 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

INTESTINO Y COLON

6	21	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	29
2.2	Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación	31
2.3	Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa	36
2.4	Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn	39
2.5	Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje	44
2.6	Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula	48

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.1.008	Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	Específico	Completo	Completo
1.06.2.005, 1.06.1.011, 1.06.1.009, 1.04.1.009, 1.04.1.022, 1.06.1.010, 1.06.4.014, 1.07.1.002	Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación	Específico	Completo	Completo
1.06.1.015, 1.06.1.028, 1.06.1.023, 1.06.4.013, 2.01.1.048, 1.06.3.002	Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa	Específico	Completo	Completo
1.06.1.018, 1.06.4.007, 4.01.3.015	Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn	Sospecha	Inicial	Derivar
1.06.1.029, 4.01.1.014, 4.01.1.015, 1.06.3.004, 4.01.5.006, 1.06.4.009	Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje	Específico	Inicial	Derivar
4.01.1.016, 4.01.1.017, 4.01.1.020	Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula	—	—	—

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
21 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopía si no hay signos de alarma.

Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y síntomas nocturnos.

! TRAMPA · Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopía o colonoscopía para descartar cáncer.

Tratamiento: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si predomina la constipación.

Regla de los 3: diarrea = > 3 deposiciones/día; constipación = < 3 deposiciones/semana.

! TRAMPA · Diarrea aguda: el manejo es la hidratación (Plan A/B/C). Los antidiarreicos están contraindicados.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	EUNACOM Diciembre 2025 · #157 · EUNACOM Diciembre 2019 · #19
Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación	EUNACOM Julio 2025 · #101 · EUNACOM Julio 2025 · #110 · EUNACOM Diciembre 2024 · #126 · EUNACOM Julio 2024 · #132
Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa	EUNACOM Diciembre 2025 · #17 · EUNACOM Diciembre 2024 · #60 · EUNACOM Enero 2023 · #73 · EUNACOM Diciembre 2022 · #125
Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn	EUNACOM Julio 2025 · #163 · EUNACOM Julio 2025 · #164 · EUNACOM Diciembre 2025 · #16 · EUNACOM Diciembre 2025 · #103
Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje	EUNACOM Julio 2024 · #31 · EUNACOM Diciembre 2024 · #14 · EUNACOM Diciembre 2024 · #170 · EUNACOM Enero 2023 · #175
Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula	EUNACOM Julio 2025 · #27 · EUNACOM Julio 2017 · #54 · EUNACOM Julio 2015 · #41

2.1. Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.008

1. CONCEPTO Y PESO EN EL EXAMEN

Los trastornos digestivos funcionales (TDF) son síntomas digestivos crónicos o recurrentes sin una anomalía estructural o bioquímica que los explique. Son la **primera causa de consulta gastroenterológica** y la principal causa de dolor abdominal crónico, diarrea crónica y constipación crónica. 1.06.1.008

Hoy se entienden como trastornos del **eje cerebro-intestino**: hipersensibilidad visceral y alteración de la motilidad, gatilladas por estrés, dieta y disbiosis. El síndrome de intestino irritable (SII) es el prototipo.

2. DIAGNÓSTICO DEL SII (CRITERIOS DE ROMA IV)

Dolor abdominal recurrente al menos 1 día por semana en los últimos 3 meses, asociado a **2 o más** de: relación con la defecación, cambio en la frecuencia de las deposiciones o cambio en su consistencia. 1.06.1.008

Es un diagnóstico **clínico y positivo**, no de descarte: si el paciente cumple los criterios y no tiene signos de alarma, no se requiere una batería de exámenes. Sí se solicitan de rutina hemograma, PCR, TSH, anticuerpos de enfermedad celíaca y —en diarrea— calprotectina fecal.

3. SIGNOS DE ALARMA QUE OBLIGAN A ESTUDIO ORGÁNICO

Cualquier signo de alarma cambia la conducta: se abandona la hipótesis funcional y se estudia con **endoscopía digestiva alta o colonoscopía** según la localización del síntoma. 1.06.1.008

Regla mnemotécnica **ABCDEFH**: **A**nemia, **B**aja de peso, **C**ambio reciente del hábito o del patrón de síntomas, **D**isfagia, **E**dad de inicio > 50 años, **F**amiliar de primer grado con cáncer digestivo, **H**emorragia (rectorragia, melena) y síntomas nocturnos que despiertan al paciente.

4. TRATAMIENTO DEL SII

Base: **educación** (explicar la naturaleza benigna y descartar cáncer explícitamente en la conversación), **manejo del estrés** y ajuste dietético (dieta baja en FODMAP, fibra soluble). 1.06.1.008

Farmacoterapia dirigida al síntoma predominante: antiespasmódicos (trimebutino, bromuro de pinaverio) para el dolor; **antidepresivos tricíclicos en dosis baja (amitriptilina)** para el SII con predominio de diarrea; laxantes osmóticos (polietilenglicol) para el predominio de constipación.

TABLA 2.1 · FUNCIONAL VS ORGÁNICO — CÓMO SE DISTINGUE EN LA PRÁCTICA 1.06.1.008

RASGO	TRASTORNO FUNCIONAL (SII)	ENFERMEDAD ORGÁNICA
Edad de inicio	Joven (< 50 años)	> 50 años
Síntomas nocturnos	Ausentes (no despiertan)	Presentes
Baja de peso / anemia	Ausentes	Presentes
Relación con la defecación	Característica (alivia o cambia)	Sin relación clara
Exámenes de rutina	Normales	Alterados (VHS, PCR, calprotectina, Hb)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.1

Mujer de 32 años consulta por dolor abdominal en hipogastrio de 8 meses de evolución que alivia tras defecar, con períodos alternados de diarrea y constipación. Sin baja de peso, rectorragia ni anemia. Examen físico y hemograma normales.

Conducta oficial. Cumple criterios de Roma IV para síndrome de intestino irritable (dolor recurrente relacionado con la defecación y con cambio en la frecuencia y la forma de las deposiciones) y no presenta signos de alarma. El diagnóstico es clínico y positivo, no requiere endoscopía. El manejo es educación, dieta baja en FODMAP y fármacos según el síntoma predominante.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopía si no hay signos de alarma.
- Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y síntomas nocturnos.
- Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopía o colonoscopía para descartar cáncer.
- Tratamiento: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si predomina la constipación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta #41

1. Mujer de 48 años consulta por distensión y dolor abdominal de 1 año, alternando diarrea y constipación. En los últimos 2 meses refiere deposiciones más frecuentes, baja de 4 kg de peso no buscada y un episodio de rectorragia. Su madre tuvo cáncer de colon a los 55 años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Diagnosticar síndrome de intestino irritable e iniciar dieta baja en FODMAP
B) Solicitar colonoscopía
C) Indicar antiespasmódicos y control en 3 meses
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones y repetir en 1 año
E) Iniciar amitriptilina en dosis baja

Caso tipo EUNACOM (banco 2022)

2. Hombre de 29 años consulta por dolor abdominal recurrente de 6 meses que alivia al defecar, asociado a deposiciones más blandas cuando aparece el dolor. Sin baja de peso, anemia ni antecedentes familiares. Hemograma, PCR y anticuerpos anti-transglutaminasa normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Colonoscopía para descartar enfermedad inflamatoria intestinal
B) Diagnóstico de síndrome de intestino irritable e iniciar manejo
C) Endoscopía digestiva alta con biopsias duodenales
D) TAC de abdomen y pelvis con contraste
E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

Más preguntas online de Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable →

2.2. Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.2.005 | 1.06.1.011 | 1.06.1.009 | 1.04.1.009 | 1.04.1.022 | 1.06.1.010 | 1.06.4.014 | 1.07.1.002

¿POR QUÉ?

En la diarrea aguda el 90 % del examen es una sola cosa: hidratar bien y no dar de más. Los antibióticos y los antidiarreicos son la excepción, no la regla, porque en una diarrea infecciosa la loperamida aumenta el riesgo de complicaciones y el antibiótico rara vez cambia el curso. Cuando la diarrea se hace crónica, el eje del razonamiento son los signos de alarma: con ellos, colonoscopía; sin ellos, la causa más probable es funcional.

1. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN

Diarrea = deposiciones de menor consistencia y > 3 al día. Por duración: aguda (< 2 semanas), prolongada (2–4 semanas) y crónica (≥ 4 semanas). Constipación = deposiciones duras y < 3 por semana. 1.06.2.005 1.06.1.011 1.06.1.009

La diarrea aguda es habitualmente infecciosa y viral (más frecuente que la bacteriana). En la práctica no se estudia la etiología de cada caso: el diagnóstico es clínico y el manejo, sintomático. 1.06.2.005

2. MANEJO DE LA DESHIDRATACIÓN EN LA DIARREA AGUDA

Plan A (sin deshidratación o < 5 % de pérdida de peso): sales de rehidratación oral 100–200 mL tras cada deposición, en domicilio. **Plan B** (deshidratación moderada, 5–10 %: irritabilidad, mucosas secas, ojos hundidos): SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h, reevaluando; si vomita, fraccionar a sorbos. 1.06.2.005

Plan C (deshidratación grave > 10 %, shock, compromiso de conciencia, íleo o vómitos incoercibles): hidratación endovenosa con cristaloides (suero fisiológico o Ringer lactato). En hipernatremia se prefieren soluciones hipotónicas o glucosalinas.

3. FÁRMACOS EN LA DIARREA AGUDA

No se usan antidiarreicos (loperamida) en la diarrea aguda infecciosa: aumentan el riesgo de complicaciones. Sí pueden usarse antieméticos y antiespasmódicos para el confort. 1.06.2.005

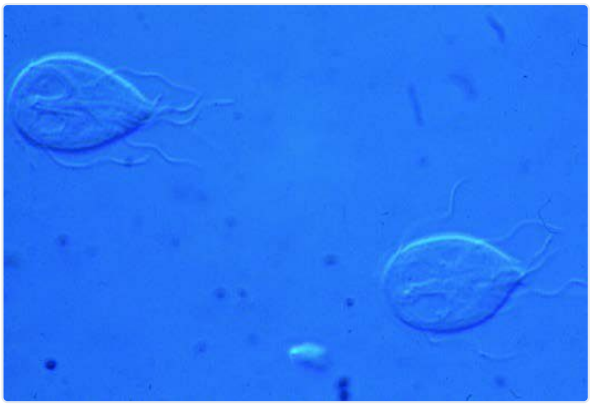
Antibióticos solo si: disentería (sangre en las deposiciones → Shigella, E. coli enteroinvasora), diarrea del viajero, fiebre persistente > 2–3 días o paciente séptico. Elección: **ciprofloxacino** oral (ceftriaxona endovenosa si es grave); cólera → azitromicina; Campylobacter → azitromicina.

4. DIARREA PROLONGADA/CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN

Prolongada (2–4 sem): buscar el agente (coprocultivo, parasitológico seriado por Giardia y Entamoeba, rotatest). Diarrea post-antibióticos (uso en el último mes) → sospechar **Clostridioides difficile**: diagnóstico por PCR de toxina; tratamiento metronidazol → vancomicina oral; la respuesta se evalúa clínicamente, no repitiendo la PCR. **(ver Imagen 2.2A y B)** 1.04.1.009 1.06.1.010 1.06.4.014



Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile en colonoscopía

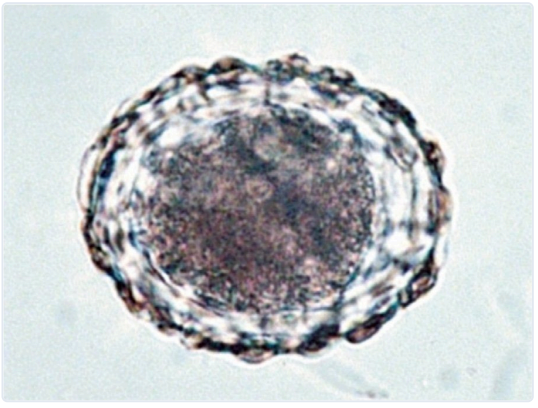


Trofozoíto de Giardia lamblia en microscopía

Crónica (≥ 4 sem): según la clínica → funcional (SII), malabsorción (test de Sudán, D-xilosa, serología celíaca), EII (colonoscopía) o cáncer de colon si hay signos de alarma (colonoscopía). Constipación: funcional (educación, fibra, agua, proquinéticos); con signos de alarma en el adulto mayor → colonoscopía para descartar cáncer. 1.06.1.011 1.06.1.009 1.07.1.002

5. PARASITOSIS INTESTINALES DEL ADULTO Y FECALOMA

Parasitosis intestinales (nivel: diagnóstico y tratamiento completos): el diagnóstico es el **parasitológico seriado de deposiciones** (3 muestras en días distintos, con conservante), más el test de Graham para oxiuros y la eosinofilia como pista. **Giardia:** flatulencia, dolor cólico y diarrea con malabsorción → tinidazol 2 g dosis única o metronidazol 250 mg cada 8 h por 5 días. **Entamoeba histolytica:** disentería y absceso hepático → metronidazol 500–750 mg cada 8 h por 7–10 días, seguido de un amebicida luminal. **Áscaris y tricocéfalo:** albendazol 400 mg (dosis única en áscaris; 3 días en tricocéfalo) o mebendazol. **Oxiuros:** albendazol o mebendazol, repetir a las 2 semanas y tratar a todo el grupo familiar. **Teniasis:** praziquantel. **Strongyloides** (diarrea, eosinofilia, riesgo de hiperinfección en inmunosuprimidos): ivermectina. **(ver Imagen 2.2C)** 1.04.1.022



Huevo de Ascaris lumbricoides

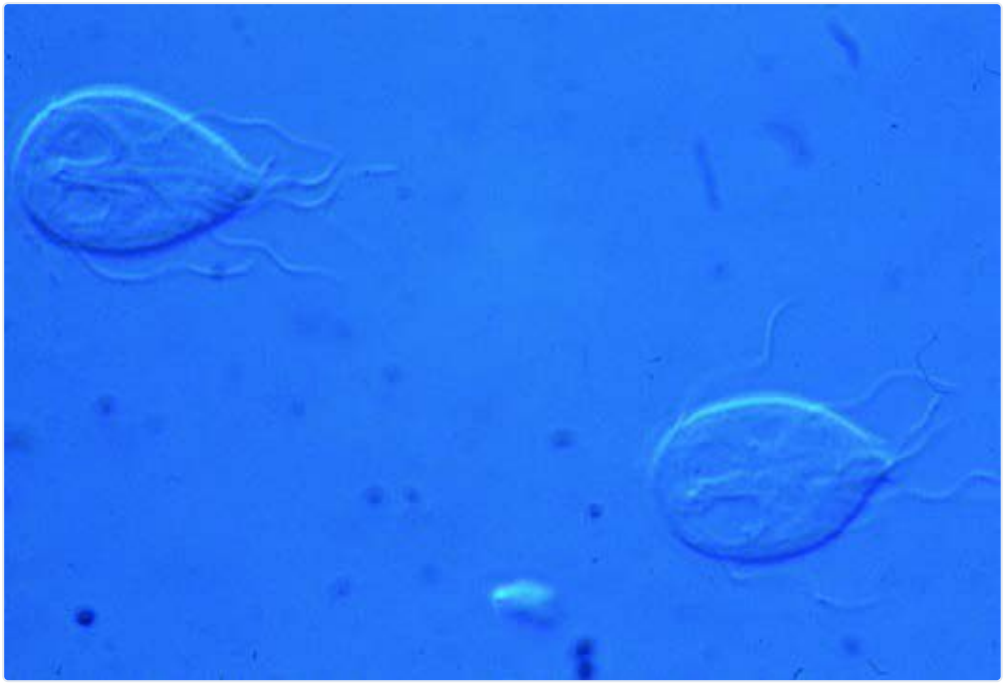


Huevo de Trichuris trichiura (tricocéfalo)

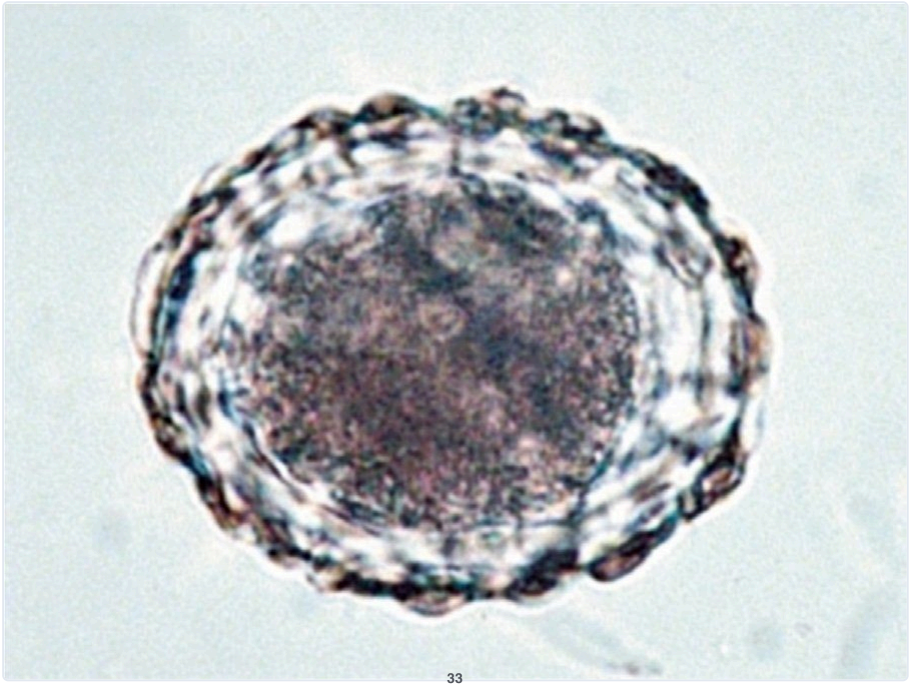
Fecaloma: masa de deposición endurecida en el recto, propia del adulto mayor postrado o con opioides, anticolinérgicos o constipación crónica. Puede dar **diarrea por rebosamiento** (paradójica), incontinencia fecal, retención urinaria, dolor y delirium; el **tacto rectal** lo diagnostica (masa dura y ampolla llena) y la radiografía de abdomen lo confirma si es alto. Tratamiento: desimpactación con enema, supositorios de glicerina o fragmentación manual, y luego prevención con fibra, hidratación, movilización, revisar los fármacos constipantes y un laxante osmótico de mantención. Si no se trata puede producir obstrucción o úlcera estercorácea con perforación. 1.07.1.002



A. C. DIFFICILE EN COLONOSCOPÍA



B. TROFOZOÍTOS DE GIARDIA



C. HUEVO DE ASCARIS

Imagen 2.2

TABLA 2.2 · DIARREA AGUDA — PLAN DE HIDRATACIÓN

1.06.2.005, 1.06.1.011, 1.06.1.009, 1.04.1.009, 1.04.1.022, 1.06.1.010, 1.06.4.014, 1.07.1.002

PLAN	ESTADO DEL PACIENTE	CONDUCTA
A	Sin deshidratación (< 5 % pérdida de peso)	SRO 100–200 mL post deposición, en casa
B	Deshidratación moderada (5–10 %): irritable, mucosas secas, ojos hundidos	SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h y reevaluar
C	Deshidratación grave (> 10 %), shock, compromiso de conciencia, íleo, vómitos incoercibles	Cristaloides endovenosos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Lactante de 8 meses con diarrea acuosa de 3 días, sin sangre ni fiebre alta. Al examen está irritable, con las mucosas secas, los ojos hundidos y el signo del pliegue enlentecido; ha perdido el 7 % de su peso habitual. Tolera pequeños sorbos de líquido.

Conducta oficial. Deshidratación moderada (7 % de pérdida de peso, mucosas secas, ojos hundidos, irritabilidad) por diarrea aguda sin disentería: corresponde el Plan B, con sales de rehidratación oral 50–100 mL/kg en 4–6 horas y reevaluación clínica. Como tolera la vía oral, no se necesita hidratación endovenosa. No se indican antibióticos (no hay disentería ni fiebre alta persistente) ni antidiarreicos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Regla de los 3: diarrea = > 3 deposiciones/día; constipación = < 3 deposiciones/semana.
- Diarrea aguda: el manejo es la hidratación (Plan A/B/C). Los antidiarreicos están contraindicados.
- Antibiótico en diarrea aguda solo si disentería, diarrea del viajero, fiebre persistente o sepsis. Elección: ciprofloxacino.
- Diarrea post-antibióticos (último mes) → C. difficile: PCR de toxina; la respuesta se evalúa clínicamente, no con PCR de control.
- Diarrea crónica o constipación con signos de alarma en adulto mayor → colonoscopía para descartar cáncer.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 46 años presenta diarrea líquida de 3 semanas que comenzó 10 días después de terminar un tratamiento con amoxicilina-clavulánico por una neumonía. Sin sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la etiología?

A) Coprocultivo corriente
B) PCR de toxina para Clostridioides difficile en deposiciones
C) Parasitológico seriado de deposiciones
D) Colonoscopía con biopsias
E) Calprotectina fecal

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Niño de 2 años con diarrea acuosa de 2 días y fiebre de 38,5 °C, sin sangre en las deposiciones, con buen estado general y sin signos de deshidratación. ¿Cuál es la conducta respecto de los antibióticos?

A) Ciprofloxacino oral
B) Ceftriaxona endovenosa
C) Azitromicina oral
D) No indicar antibióticos
E) Metronidazol oral

Más preguntas online de Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación →

2.3. Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.015 | 1.06.1.028 | 1.06.1.023 | 1.06.4.013 | 2.01.1.048 | 1.06.3.002

¿POR QUÉ?

Dos pruebas ordenan todo el tema. El test de Sudán solo dice "hay grasa en las deposiciones" (esteatorrea). El test de D-xilosa dice dónde está el problema: si sale alterado, la pared intestinal no absorbe (celíaca, Crohn); si sale normal, la pared está bien y faltan enzimas (páncreas). Y hay una perla que se repite: una anemia ferropénica que no responde a hierro oral, con o sin diarrea, obliga a descartar enfermedad celíaca, porque el hierro se absorbe justo en el duodeno.

1. SÍNDROME DE MALABSORCIÓN

Diarrea crónica + baja de peso con ingesta conservada + esteatorrea (deposiciones brillantes, que flotan, de mal olor) + lientería (restos de alimento sin digerir) + signos carenciales (anemia ferropénica refractaria, hipocalcemia, glositis, queilitis, piel seca). **(ver Imagen 2.3A)** 1.06.1.028 | 2.01.1.048

Estudio: test de Sudán en deposiciones confirma la esteatorrea. Test de D-xilosa: alterado = problema parietal (celíaca, Crohn, intestino corto); normal = problema enzimático pancreático (pancreatitis crónica, fibrosis quística). Ante sospecha de Giardia, parasitológico y tratamiento con tinidazol/metronidazol. 1.06.1.028 | 2.01.1.048 | 1.06.4.013

2. ENFERMEDAD CELÍACA — CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

Enteropatía inmune gatillada por el gluten (trigo, cebada, centeno; también la avena por contaminación/avenina). Puede ser oligosintomática: distensión, flatulencia, dispepsia "funcional", o solo anemia ferropénica o hipocalcemia aisladas (el hierro y el calcio se absorben en el duodeno, la zona más dañada). 1.06.1.015

Diagnóstico: **anticuerpos anti-transglutaminasa tisular IgA** (más antiendomisio) junto con IgA total (el déficit de IgA, más frecuente en celíacos, da falsos negativos). Confirmación con biopsia duodenal: atrofia vellositaria, hiperplasia de criptas, linfocitosis intraepitelial. El paciente debe estar consumiendo gluten al momento del estudio. **(ver Imagen 2.3B)**

3. ENFERMEDAD CELÍACA — TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES

Único tratamiento: **dieta sin gluten estricta y de por vida**. Seguimiento: mejoría clínica + negativización de los anticuerpos (habitualmente al año). 1.06.1.015 | 1.06.3.002

Si no responde: la causa más frecuente es la transgresión de la dieta (a menudo por contaminación cruzada). Si el paciente cumple la dieta, los anticuerpos están negativos y aun así persiste la malabsorción y la baja de peso → sospechar **linfoma T asociado a enteropatía** (linfoma MALT intestinal). 1.06.1.015

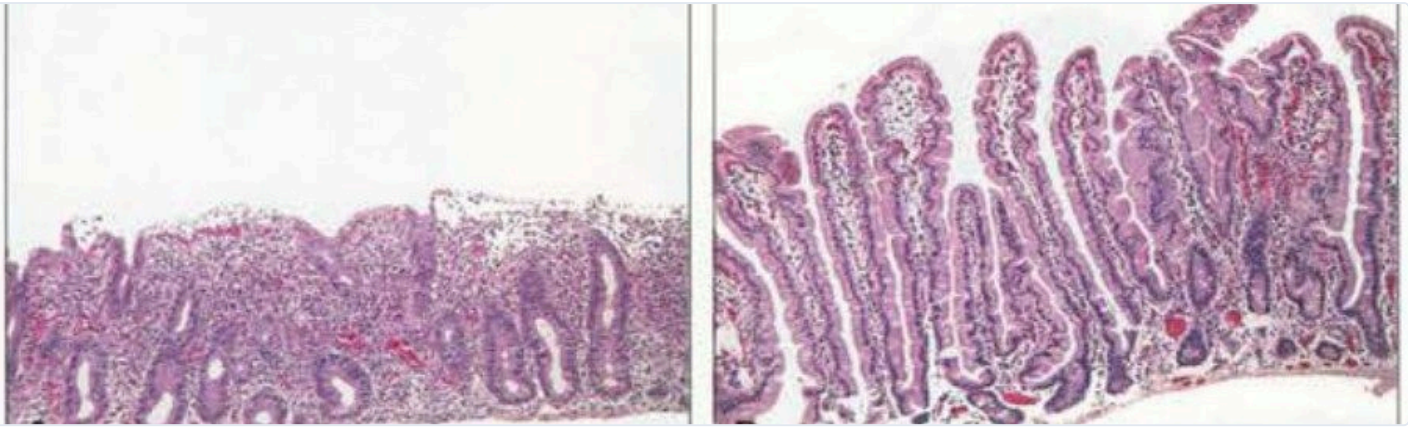
4. INTOLERANCIA A LA LACTOSA VS GALACTOSEMIA

Intolerancia a la lactosa: déficit de lactasa (frecuente en el adulto). Diarrea osmótica, meteorismo y dolor tras los lácteos, sin esteatorrea. Diagnóstico: test de hidrógeno espirado. Tratamiento: reducir lactosa o usar lactasa exógena (la "leche sin lactosa" es leche con lactasa añadida). 1.06.1.023 | 1.06.3.002

Galactosemia: enfermedad genética autosómica recesiva grave del recién nacido: ictericia, daño hepático, cataratas, retraso del desarrollo, sepsis por E. coli. Tratamiento: eliminar toda la galactosa → lactancia materna y fórmulas animales contraindicadas, se usa **fórmula de soya**. La "leche sin lactosa" está prohibida (contiene galactosa). 1.06.3.002



A. DERMATITIS HERPETIFORME



B. ATROFIA VELLOSITARIA

Imagen 2.3

TABLA 2.3 · MALABSORCIÓN — INTERPRETAR LA D-XILOSA; LACTOSA VS GALACTOSA

1.06.1.015, 1.06.1.028, 1.06.1.023, 1.06.4.013, 2.01.1.048, 1.06.3.002

PRUEBA / CUADRO	HALLAZGO	SIGNIFICADO
D-xilosa alterada	Baja excreción urinaria	Problema parietal: celíaca, Crohn, intestino corto
D-xilosa normal	Excreción urinaria normal	Problema enzimático: pancreatitis crónica, fibrosis quística
Anticuerpos celíacos negativos con clínica sugerente	Verificar IgA total	Déficit de IgA da falsos negativos
Intolerancia a la lactosa	Diarrea osmótica sin esteatorrea, en el adulto	Reducir lactosa; leche sin lactosa útil
Galactosemia	Recién nacido con cataratas, ictericia, retraso	Fórmula de soya; lactancia y leche sin lactosa prohibidas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Mujer de 30 años consulta por diarrea crónica, distensión y baja de 6 kg de peso en un año. Tiene una anemia ferropénica que no ha respondido a 4 meses de hierro oral bien tolerado. El test de D-xilosa resulta alterado.

Conducta oficial. Malabsorción con test de D-xilosa alterado indica un problema de la pared intestinal. En una adulta con diarrea crónica y, sobre todo, anemia ferropénica refractaria al hierro oral, la primera sospecha es la enfermedad celíaca, ya que el duodeno —donde se absorbe el hierro— es la zona más afectada. Se solicitan anticuerpos anti-transglutaminasa IgA con IgA total y se confirma con biopsia duodenal, manteniendo el gluten en la dieta hasta completar el estudio.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Test de Sudán confirma esteatorrea; test de D-xilosa localiza: alterado = pared (celíaca/Crohn), normal = enzimas (páncreas).
- Anemia ferropénica refractaria al hierro oral, con o sin diarrea, obliga a descartar enfermedad celíaca.
- Diagnóstico de celíaca: anti-transglutaminasa IgA + IgA total, y biopsia duodenal (con el paciente consumiendo gluten).
- Celíaca que no responde: casi siempre transgresión dietética; si cumple y anticuerpos negativos, sospechar linfoma MALT.
- Galactosemia (RN con cataratas e ictericia): fórmula de soya; lactancia materna y "leche sin lactosa" están contraindicadas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Paciente con enfermedad celíaca que lleva 1 año con dieta sin gluten. Refiere seguirla de forma estricta, pero persiste con diarrea y baja de peso. Los anticuerpos anti-transglutaminasa están negativos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

A) Transgresión oculta de la dieta
B) Linfoma T asociado a enteropatía (linfoma MALT)
C) Intolerancia a la lactosa secundaria
D) Síndrome de intestino irritable sobreagregado
E) Giardiasis crónica

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Recién nacido de 12 días con ictericia prolongada, hepatomegalia, mal incremento ponderal y cataratas bilaterales detectadas en el examen ocular. ¿Cuál es el tratamiento nutricional indicado?

A) Mantener lactancia materna exclusiva
B) Fórmula sin lactosa
C) Fórmula de soya (sin galactosa)
D) Fórmula extensamente hidrolizada
E) Suplemento oral de lactasa con leche materna

Más preguntas online de Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa →

2.4. Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.018 | 1.06.4.007 | 4.01.3.015

¿POR QUÉ?

Ante un joven con diarrea con sangre y mucosidad de meses, fiebre y baja de peso, la conducta siempre es colonoscopía con biopsias. Diferenciar las dos enfermedades se reduce a una regla: basta UNA característica de Crohn (compromiso del íleon o del tubo alto, lesiones en parches, afectación transmural, fístulas, masa o compromiso perianal) para llamarla Crohn. Si es puramente colónica, continua y empieza en el recto, es colitis ulcerosa. Esa distinción cambia la cirugía: colectomía cura la CU, pero en Crohn nunca se opera con intención curativa.

1. EL ESCENARIO Y POR QUÉ SIEMPRE TERMINA EN COLONOSCOPÍA

La colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC) son enfermedades autoinmunes por desregulación de la respuesta inmune frente a la microbiota en un individuo genéticamente predispuesto. Debutan en el adulto joven, con curso en brotes y remisiones: diarrea crónica disentérica (sangre, mucosidad o pus), dolor abdominal cólico, baja de peso, fiebre y compromiso del estado general por el estado hipercatabólico. **(ver Imagen 2.4A y B)** 1.06.1.018

Ante ese cuadro —o ante cualquier sospecha de cáncer de colon en un mayor— la conducta inicial es siempre **colonoscopía total con ileoscopía y biopsias escalonadas**, que confirma la enfermedad y permite diferenciarlas. La calprotectina fecal elevada apoya el origen inflamatorio (frente a un intestino irritable) y sirve para seguimiento; los anticuerpos p-ANCA (CU) y ASCA (Crohn) orientan pero no diagnostican. 1.06.1.018 | 1.06.4.007

2. LEER LA COLONOSCOPÍA: LA REGLA QUE RESUELVE LA PREGUNTA

Colitis ulcerosa: compromete solo el colon, siempre desde el recto (rectitis en el 100 %) y en forma continua, sin mucosa sana intercalada; inflamación limitada a la mucosa; endoscopía con mucosa eritematosa, granular, friable y pseudopólipos; clínica de pujo y tenesmo. 1.06.1.018 | 1.06.4.007

Enfermedad de Crohn: puede afectar de la boca al ano (típicamente íleon distal y unión ileocecal), en parches ("skip lesions"), puede respetar el recto, inflamación transmural; endoscopía con úlceras aftosas y aspecto en empedrado con mucosa normal entre las lesiones. **Regla de oro EUNACOM:** basta UNA característica de Crohn —compromiso del íleon o del tubo alto, lesiones en parches, respeto del recto, afectación transmural, fístula, masa/plastrón, úlceras orales o enfermedad perianal— para llamarla Crohn. Si es puramente colónica, continua y desde el recto, es colitis ulcerosa. **(ver Imagen 2.4C)**

3. MANIFESTACIONES EXTRAINTESTINALES Y COMPLICACIONES

Al ser autoinmunes, ambas dan síntomas fuera del intestino: artritis periférica (la más frecuente) y espondilitis anquilosante, uveítis anterior, eritema nodoso (el más frecuente en piel) y pioderma gangrenoso, y **colangitis esclerosante primaria** (fuertemente asociada a la CU). En un caso EUNACOM, la tríada diarrea disentérica + artralgias migratorias + aftas/nódulos en las piernas es casi patognomónica de EII. 1.06.1.018



Eritema nodoso en piernas



Pioderma gangrenoso



Eritema nodoso



Pioderma gangrenoso

Complicaciones según la profundidad de la inflamación: la EC transmural produce fístulas, abscesos perianales, obstrucción intestinal por estenosis cicatricial y síndrome de malabsorción si toma el delgado; la CU mucosa produce **megacolon tóxico** (dilatación > 6 cm con sepsis, urgencia vital) y, tras 8–10 años de enfermedad, un riesgo aumentado de cáncer colorrectal —sobre todo rectal— que obliga a colonoscopías de vigilancia periódicas. Por eso, un paciente con CU y sangrado nuevo se estudia con colonoscopía, no con rectosigmoidoscopía.

4. TRATAMIENTO MÉDICO Y LA DIFERENCIA CLAVE EN CIRUGÍA

Farmacológico (similar en ambas, escalonado para inducir y mantener remisión): 5-ASA (mesalazina/sulfasalazina, pilar en la CU leve-moderada, tópico + oral según extensión), corticoides para el brote agudo (budesonida, prednisona; nunca de mantención), inmunomo- 1.06.1.018

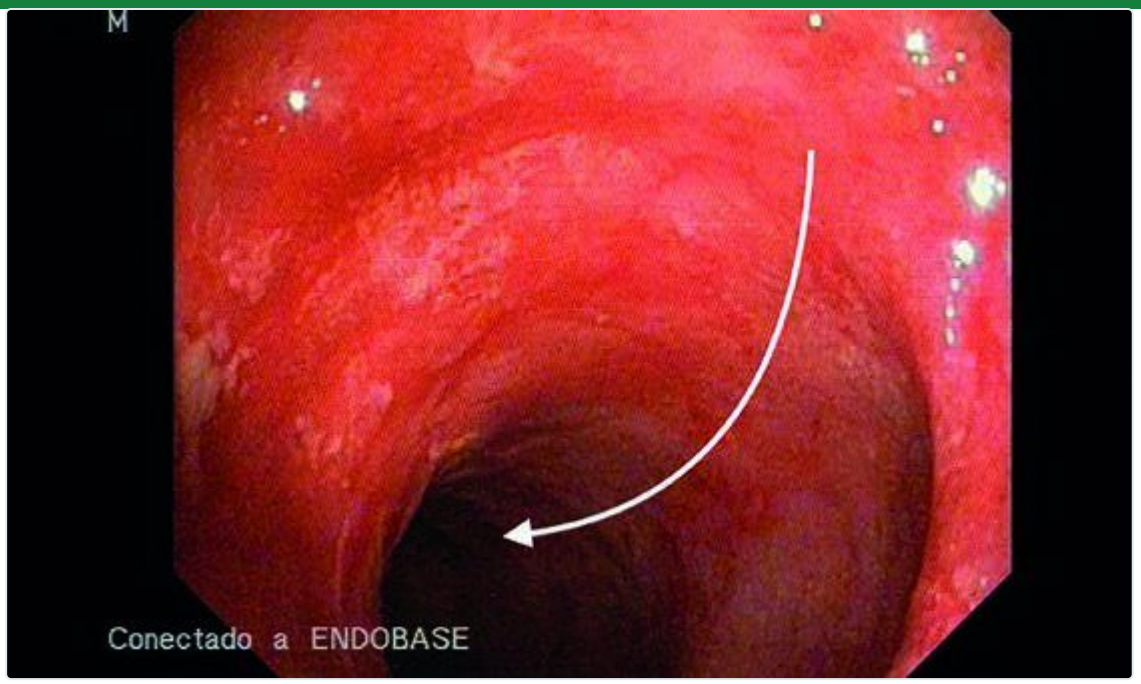
duladores (azatioprina, metotrexato), biológicos anti-TNF (infliximab, adalimumab) y otras dianas (vedolizumab, ustekinumab), más antibióticos en complicaciones sépticas.

La cirugía es el último escalón y su lógica es opuesta: en la colitis ulcerosa la colectomía es **CURATIVA** porque la enfermedad se limita al colon (colectomía subtotal con muñón rectal, o proctocolectomía total con reservorio ileoanal si hay displasia o cáncer de recto); en el Crohn la cirugía **NUNCA cura** —solo se reseca de forma económica el segmento complicado (estenosis, fístula, absceso) o se hace estenoplastía— porque la enfermedad puede reaparecer en cualquier tramo del tubo digestivo.

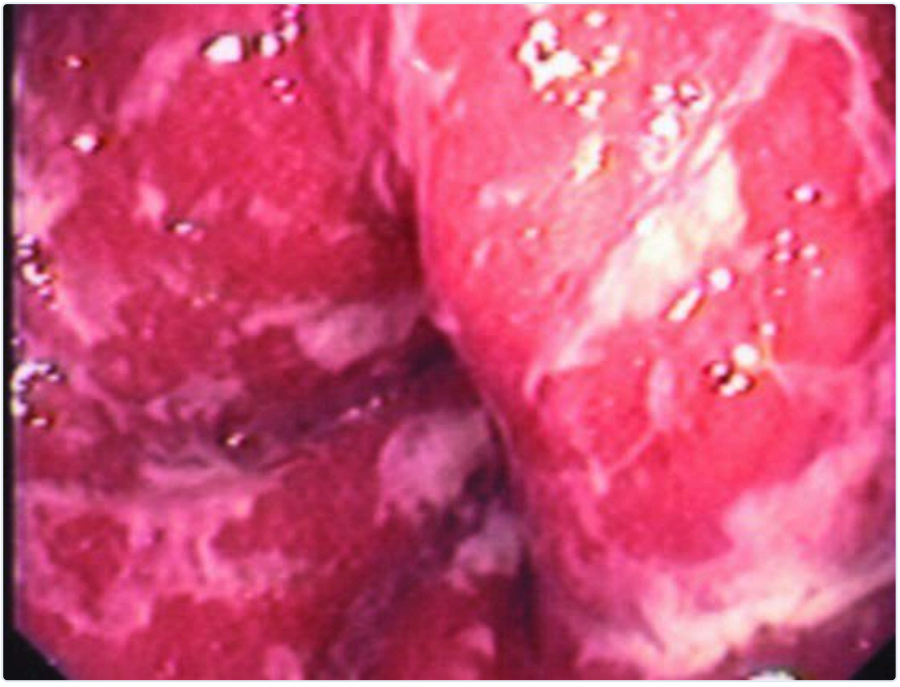
5. ILEOSTOMÍA: INDICACIONES, CUIDADOS Y COMPLICACIONES

Qué es y cuándo se hace: la ileostomía es la exteriorización del íleon por la pared abdominal, habitualmente en la **fosa ilíaca derecha** y con el borde evertido («en rosa») para que el efluente, rico en enzimas, no dañe la piel. La **ileostomía terminal** definitiva acompaña a la proctocolectomía total (colitis ulcerosa, Crohn colónico grave); la **ileostomía en asa** es temporal y protege una anastomosis o el reservorio ileoanal hasta que cicatrice. 4.01.3.015

Cuidados y complicaciones: el efluente normal es líquido-pastoso (500–1.000 mL/día). Un **alto débito** (> 1.500 mL/día) produce deshidratación, hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia e insuficiencia renal prerrenal → hidratación, sales de rehidratación oral hipertónicas, loperamida y IBP. Se enseña al paciente a recortar el dispositivo al tamaño del estoma y a cuidar la piel periestomal (dermatitis por filtración). Otras complicaciones: prolapso, retracción, estenosis, hernia paraestomal y necrosis isquémica precoz (estoma oscuro, urgencia quirúrgica). Si se resecó el íleon terminal, falta vitamina B_{12} y sales biliares (litiasis biliar).



A. COLITIS ULCEROSA



B. CROHN



C. CROHN: ÍLEON ENGROSADO (TC)

Imagen 2.4

TABLA 2.4 · COLITIS ULCEROSA VS ENFERMEDAD DE CROHN 1.06.1.018, 1.06.4.007, 4.01.3.015

RASGO	COLITIS ULCEROSA	ENFERMEDAD DE CROHN
Localización	Solo colon, desde el recto	Boca a ano (típico íleon distal)
Distribución	Continua	En parches (skip lesions)
Profundidad	Mucosa	Transmural
Anticuerpos	p-ANCA	ASCA
Complicaciones	Megacolon tóxico, cáncer colorrectal	Fístulas, abscesos, obstrucción
Cirugía	Colectomía = curativa	Resección segmentaria; nunca curativa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Hombre de 25 años consulta por 3 meses de diarrea con sangre y mucosidad, dolor abdominal, fiebre vespertina y baja de 5 kg de peso. Al examen se palpa una masa dolorosa mal definida en la fosa ilíaca derecha. Tiene además una úlcera aftosa en la mucosa oral.

Conducta oficial. Joven con diarrea disentérica crónica, síntomas sistémicos y, sobre todo, una masa en la fosa ilíaca derecha (plastrón inflamatorio del íleon) más úlceras orales: son características propias de la enfermedad de Crohn. Basta una de ellas para hacer el diagnóstico; la masa abdominal y el compromiso ileal no ocurren en la colitis ulcerosa, que es continua, solo colónica y limitada a la mucosa. La conducta es colonoscopía (con ileoscopía) y biopsias.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Joven con diarrea disentérica crónica + fiebre + baja de peso → colonoscopía con biopsias.
- Colitis ulcerosa: solo colon, desde el recto, continua, mucosa, p-ANCA. Crohn: boca-ano, en parches, transmural, ASCA.
- Basta UNA característica de Crohn (íleon, fístula, parches, masa, perianal) para diagnosticarlo.
- Colitis ulcerosa: riesgo de megacolon tóxico y de cáncer colorrectal tras 8–10 años (vigilancia colonoscópica).
- Cirugía: colectomía cura la colitis ulcerosa; en Crohn solo se reseca el segmento complicado y nunca cura.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 26

1. Hombre de 25 años con 1 mes de diarrea, dolor abdominal y malestar general; ha tenido disentería en algunas ocasiones y bajó 4 kg. La colonoscopía muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad de Crohn
C) Colitis isquémica
D) Parasitosis intestinal
E) Colitis por Clostridioides difficile

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 21

2. Paciente de 45 años con antecedente de colitis ulcerosa diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años. Desde hace una semana presenta deposiciones blandas con escasa sangre. El examen físico no aporta información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar rectosigmoidoscopía
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar parasitológico de deposiciones
D) Solicitar colonoscopía
E) Iniciar corticoides orales

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 164

3. Mujer de 35 años con diarrea crónica mucosanguinolenta de 6 meses, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Colonoscopía: mucosa eritematosa, granular, con pseudopólipos, desde el recto en forma continua hasta el ángulo esplénico, sin mucosa sana intercalada. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Colitis isquémica
B) Colitis ulcerosa
C) Síndrome de intestino irritable
D) Colitis infecciosa
E) Enfermedad de Crohn

Más preguntas online de Enfermedad Inflamatoria Intestinal →

2.5. Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

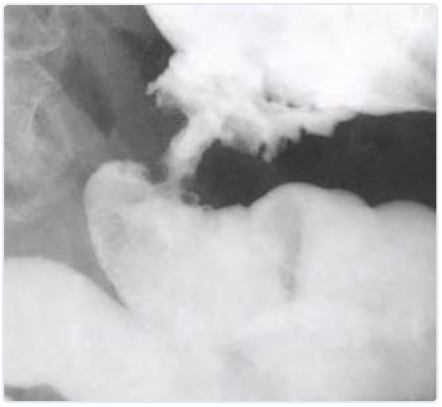
CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.029 4.01.1.014 4.01.1.015 1.06.3.004 4.01.5.006 1.06.4.009

¿POR QUÉ?

Casi todos los cánceres de colon nacen de un pólipo adenomatoso que tarda años en malignizarse: por eso resecar adenomas en la colonoscopía y vigilar previene el cáncer. Dos escenarios se preguntan una y otra vez: el adulto mayor con constipación reciente y anemia ferropénica (cáncer de colon hasta que la colonoscopía diga lo contrario) y el hallazgo de "innumerables pólipos" (poliposis adenomatosa familiar → colectomía profiláctica, porque el 100 % malignizará).

1. PÓLIPOS DE COLON

Hiperplásico: no es premaligno; se observa. **Adenomatoso** 4.01.1.014 (tubular, tubulovelloso, velloso el de mayor riesgo): es la lesión precursora del cáncer → polipectomía endoscópica + colonoscopía de control en 1–3 años según número, tamaño e histología. 4.01.5.006 **(ver Imagen 2.5A, B y C)**



Cáncer colorrectal en colonoscopía o enema baritado con imagen en "man

La secuencia adenoma-carcinoma tarda ~10 años, lo que da la ventana para el tamizaje. 4.01.1.014

2. CÁNCER COLORRECTAL — CLÍNICA

Colon derecho: anemia ferropénica y masa palpable (sangrado oculto). **Colon izquierdo:** cambio del hábito, constipación progresiva, rectorragia; la obstrucción intestinal es su complicación más frecuente (primera causa de obstrucción del colon en el adulto). 1.06.1.029 4.01.1.015

Recto: hematoquecia, disquecia, tenesmo, deformación del bolo fecal. Factores de riesgo del cáncer de recto: colitis ulcerosa, VIH y VPH.

3. DIAGNÓSTICO, ETAPIFICACIÓN Y SÍNDROMES HEREDITARIOS

Diagnóstico: colonoscopía total con biopsia. Etapificación: TAC de tórax-abdomen-pelvis; en el recto se agregan RM de pelvis y endosonografía, y el TAC de tórax es obligatorio (puede dar metástasis pulmonares sin pasar por el hígado). El **CEA solo sirve para el seguimiento posoperatorio**, no para el diagnóstico. 1.06.1.029 4.01.1.015 4.01.5.006

Poliposis adenomatosa familiar (PAF): cientos de pólipos, 100 % malignizan → colectomía total profiláctica. **Síndrome de Lynch (HNPCC):** pocos pólipos, alto riesgo → vigilancia colonoscópica intensiva. 4.01.1.014 4.01.1.015

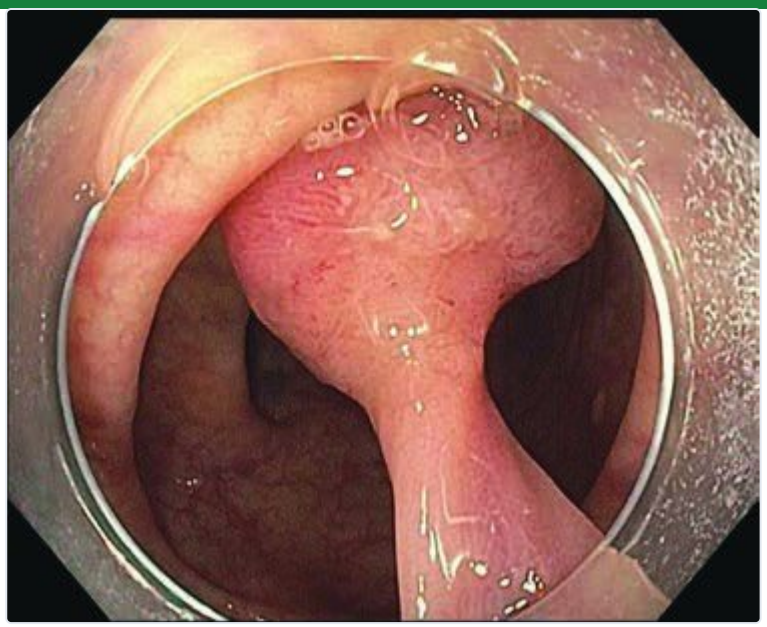


Poliposis adenomatosa familiar

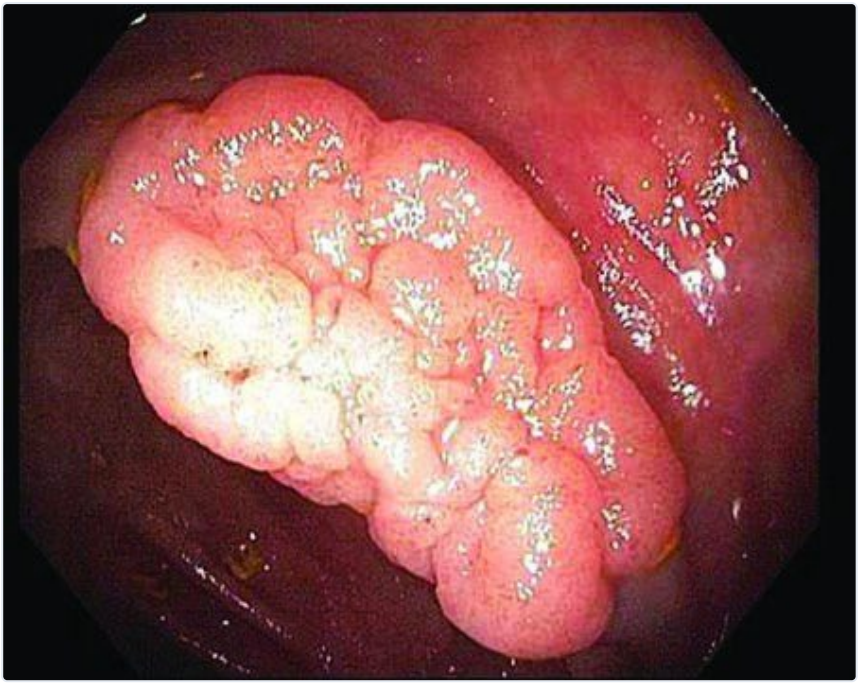
4. TRATAMIENTO Y TAMIZAJE

Tratamiento: cirugía (hemicolectomía derecha o izquierda según la localización) siempre, incluso en enfermedad avanzada, para evitar la obstrucción. La quimioterapia del cáncer de colon es especialmente eficaz (puede lograr curación con metástasis hepáticas resecables). El cáncer de recto agrega radioterapia (complicación: rectitis actínica). 1.06.1.029 4.01.1.015

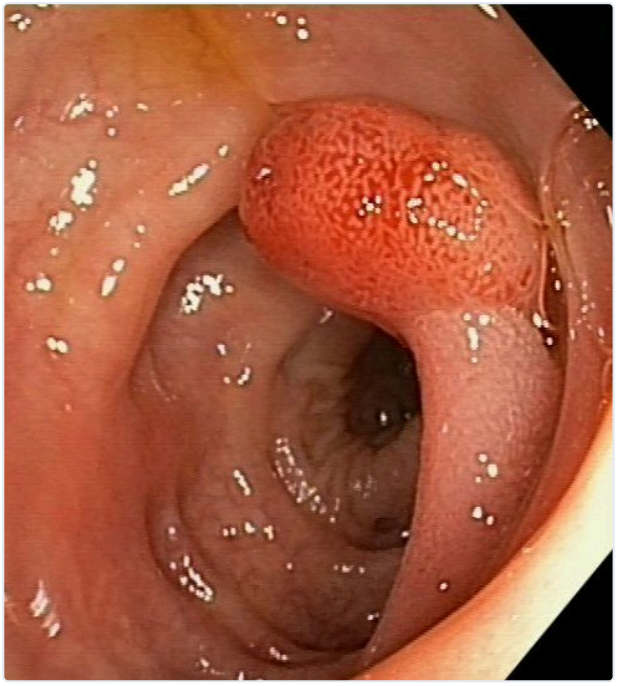
Tamizaje poblacional (personas asintomáticas de riesgo promedio, desde los 50 años): test de sangre oculta inmunoquímico anual/bienal y, si es positivo, colonoscopía; o colonoscopía cada 10 años. No se usa el test de sangre oculta para estudiar a un paciente sintomático: a ese se le hace colonoscopía directamente. 1.06.3.004 4.01.5.006 1.06.4.009



A. PÓLIPO PEDICULADO



B. PÓLIPO SÉSIL



C. PÓLIPO EN COLONOSCOPÍA

Imagen 2.5

TABLA 2.5 · PÓLIPOS Y SÍNDROMES HEREDITARIOS DE CÁNCER DE COLON

1.06.1.029, 4.01.1.014, 4.01.1.015, 1.06.3.004, 4.01.5.006, 1.06.4.009

HALLAZGO	RIESGO	CONDUCTA
Pólipo hiperplásico	Nulo	Observar
Pólipo adenomatoso (tubular/velloso)	Premaligno	Polipectomía + colonoscopía de control 1–3 años
Poliposis adenomatosa familiar (PAF)	100 % evoluciona a cáncer	Colectomía total profiláctica
Síndrome de Lynch (HNPCC)	Alto, pocos pólipos	Vigilancia colonoscópica intensiva
Paciente sintomático con signos de alarma	A descartar cáncer	Colonoscopía (no test de sangre oculta)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.5

Mujer de 74 años consulta por 4 meses de constipación progresiva que antes no tenía, con deposiciones más delgadas y episodios de rectorragia escasa. El hemograma muestra una anemia microcítica hipocroma con ferritina baja.

Conducta oficial. Cambio reciente del hábito intestinal hacia la constipación en una adulta mayor, con deposiciones acintadas, rectorragia y anemia ferropénica: es un cáncer colorrectal (probablemente izquierdo) hasta que se demuestre lo contrario. La conducta es la colonoscopía total con biopsia, no el test de sangre oculta (que es una herramienta de tamizaje en asintomáticos). Luego se etapifica con TAC de tórax-abdomen-pelvis.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La mayoría de los cánceres de colon nacen de un adenoma; resecar adenomas en la colonoscopía previene el cáncer.
- Constipación reciente + anemia ferropénica en el adulto mayor = cáncer de colon → colonoscopía.
- Innumerables pólipos = poliposis adenomatosa familiar → colectomía total profiláctica (100 % maligniza).
- El CEA solo sirve para el seguimiento posoperatorio, no para el diagnóstico ni el pronóstico.
- El test de sangre oculta es tamizaje de asintomáticos; al paciente con signos de alarma se le hace colonoscopía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. En una colonoscopía realizada a un hombre de 28 años con antecedentes familiares de cáncer de colon se describen más de 150 pólipos distribuidos por todo el colon y el recto. Varias biopsias muestran adenomas tubulares con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Polipectomía endoscópica de los pólipos mayores y control anual
B) Colectomía total (proctocolectomía) profiláctica
C) Quimioprevención con AINE y seguimiento
D) Control con CEA seriado cada 6 meses
E) Colonoscopía de control en 3 años

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Hombre de 55 años, asintomático, sin antecedentes familiares, consulta para "chequeo". ¿Cuál es la estrategia de tamizaje de cáncer colorrectal más apropiada?

A) No corresponde tamizaje por ser asintomático
B) Test de sangre oculta inmunoquímico y, si es positivo, colonoscopía; o colonoscopía cada 10 años
C) CEA anual
D) TAC de abdomen y pelvis cada 5 años
E) Colonoscopía solo si aparecen síntomas

Más preguntas online de Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje →

2.6. Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.01.1.016 4.01.1.017 4.01.1.020

¿POR QUÉ?

Casi todo se ordena con dos ejes. Primero: ¿duele o no duele? El sangrado sin dolor es el hemorroide interno; el dolor con la defecación es la fisura; el dolor que crece día a día con una masa fluctuante es el absceso. Segundo: ¿médico o quirúrgico? La fisura y el hemorroide externo trombosado se manejan con baños de asiento y tratar la constipación; el absceso perianal se drena en pabellón sí o sí (los antibióticos solos no sirven).

1. FISURA ANAL

Desgarro del anodermo por un bolo fecal duro. Dolor intenso que comienza con la defecación y persiste minutos por espasmo del esfínter interno, con rectorragia escasa al papel. Diagnóstico: inspección. 4.01.1.016 4.01.1.020

Tratamiento: baños de asiento (relajan el esfínter interno y alivian el dolor) + tratar la constipación (fibra, agua, laxantes osmóticos). Si es crónica (> 6 semanas) y no responde: **esfinterotomía lateral interna** — se secciona siempre el esfínter interno (el externo, voluntario, no se toca: su sección produce incontinencia).

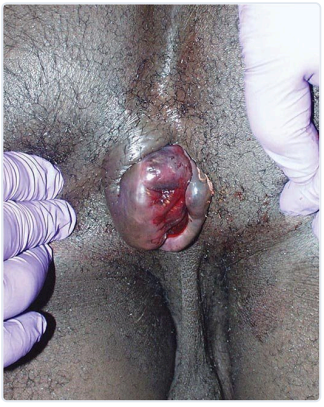
2. HEMORROIDES

Hemorroide interno: hematoquecia sin dolor. Grado I (no protruye) a IV (irreductible). Es causa frecuente de hemorragia digestiva baja, pero siempre hay que descartar otras causas (cáncer, diverticulosis) con rectoscopía/colonoscopía. Tratamiento: ligadura con banda elástica (electiva) + tratar la constipación; cirugía (hemorroidectomía) en grados avanzados. **(ver Imagen 2.6B)** 4.01.1.016

Hemorroide externo trombosado: dolor anal agudo con nódulo violáceo visible. Baños de asiento siempre; trombectomía si consulta dentro de las 48–72 h (después ya no aporta). Fluxión hemorroidal: hemorroides internos prolapsados y trombosados afuera, extremadamente dolorosos → cirugía (urgente o electiva precoz). **(ver Imagen 2.6C)**



Hemorroide externo trombosado



Hemorroide trombosado

3. ABSCESO PERIANAL Y FÍSTULA

Absceso perianal: dolor anal que aumenta progresivamente (no súbito) + masa eritematosa fluctuante. Tratamiento: **drenaje quirúrgico en pabellón** — los antibióticos solos no reemplazan el drenaje. 4.01.1.017



Absceso perianal



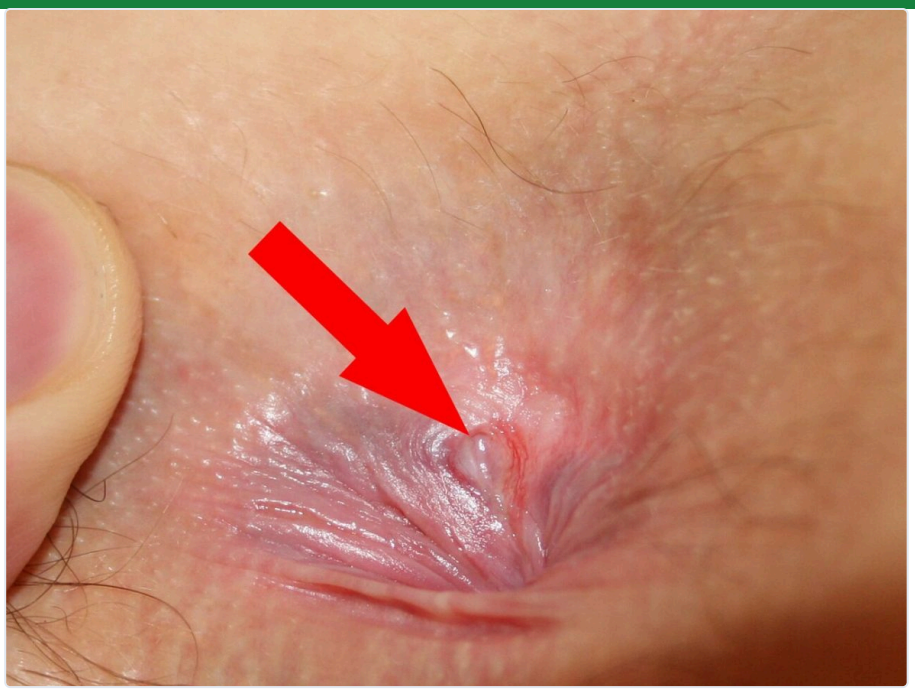
Absceso perianal

Fístula anal: secuela de un absceso que drena a la piel por un orificio que supura de forma crónica. Diagnóstico clínico. Tratamiento quirúrgico (fistulotomía / sedal). Absceso pelvirrectal (isquioanal): absceso + sepsis + síntomas urinarios → RM de pelvis + drenaje en pabellón + antibióticos endovenosos (aquí sí).

4. NO CONFUNDIR: FISURA ≠ FÍSTULA

Fisura: herida lineal dolorosa del margen anal, causada por constipación, de manejo médico (baños de asiento). **(ver Imagen 2.6A)** 4.01.1.016 4.01.1.020

Fístula: trayecto que comunica el canal anal con la piel, secuela de un absceso, de manejo quirúrgico. Se escriben parecido y se manejan al revés. 4.01.1.017



A. FISURA ANAL



B. HEMORROIDES GRADO CUATRO



C. HEMORROIDE TROMBOSADO

Imagen 2.6

TABLA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL — CLÍNICA Y CONDUCTA 4.01.1.016, 4.01.1.017, 4.01.1.020

CUADRO	CLAVE CLÍNICA	CONDUCTA
Fisura anal	Dolor con la defecación + rectorragia al papel	Baños de asiento + tratar constipación
Hemorroide interno	Hematoquecia sin dolor	Ligadura elástica electiva; descartar otras causas
Hemorroide externo trombosado	Dolor agudo + nódulo violáceo	Baños de asiento; trombectomía si < 72 h
Absceso perianal	Dolor creciente + masa fluctuante	Drenaje en pabellón (no ATB solos)
Fístula anal	Orificio cutáneo que supura crónicamente	Cirugía (fistulotomía)
Absceso pelvirrectal	Absceso + sepsis + síntomas urinarios	RM de pelvis + drenaje + ATB endovenosos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.6

Hombre de 38 años consulta por dolor anal que ha ido aumentando durante 4 días, ahora intenso e invalidante, con fiebre de 38 °C. Al examen se palpa una tumoración perianal eritematosa, caliente y fluctuante a las 5 del reloj, sin nódulo violáceo.

Conducta oficial. Dolor anal de curso progresivo (no súbito) con una masa eritematosa y fluctuante y fiebre: es un absceso perianal. El tratamiento es el drenaje quirúrgico en pabellón; los antibióticos por sí solos no resuelven la colección. La fluctuación y la ausencia de nódulo violáceo lo diferencian del hemorroide externo trombosado (dolor de inicio brusco, nódulo violáceo, sin fiebre).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Fisura ≠ fístula: la fisura es una herida dolorosa de manejo médico; la fístula es un trayecto de manejo quirúrgico.
- Hemorroide interno = sangrado sin dolor; siempre descartar otras causas de hemorragia digestiva baja.
- Hemorroide externo trombosado: baños de asiento; trombectomía útil solo dentro de las primeras 48–72 h.
- Absceso perianal: drenaje quirúrgico en pabellón. Los antibióticos solos no bastan.
- En la esfinterotomía de la fisura crónica se secciona el esfínter interno; nunca el externo (incontinencia).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Mujer de 34 años consulta por dolor anal intenso que aparece cada vez que defeca y dura media hora después, junto con manchas de sangre roja en el papel. Lleva semanas con deposiciones duras. Al separar los glúteos se observa una solución de continuidad lineal en la línea media posterior del margen anal. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Esfinterotomía lateral interna de urgencia
B) Baños de asiento y manejo de la constipación (fibra, agua, laxante osmótico)
C) Hemorroidectomía
D) Drenaje quirúrgico en pabellón
E) Antibióticos orales de amplio espectro

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Hombre de 45 años consulta porque desde hace 3 meses tiene un pequeño orificio en la piel de la región glútea, cercano al ano, que supura material purulento de forma intermitente. Tuvo un absceso perianal drenado hace 4 meses. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Fisura anal crónica; baños de asiento
B) Fístula anal; tratamiento quirúrgico
C) Hidradenitis supurativa; antibióticos prolongados
D) Hemorroide interno grado IV; ligadura elástica
E) Quiste pilonidal; observación

Más preguntas online de Patología Perianal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.6

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no...	**Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad >...**	Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopía o colonoscopía para descartar...
Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación	Regla de los 3: diarrea = > 3 deposiciones/día; constipación = < 3 deposiciones/semana.	**Diarrea aguda: el manejo es la hidratación (Plan A/B/C). Los antidiarreicos están...**	Diarrea crónica o constipación con signos de alarma en adulto mayor → colonoscopía para...
Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa	Test de Sudán confirma esteatorrea; test de D-xilosa localiza: alterado = pared...	**Anemia ferropénica refractaria al hierro oral, con o sin diarrea, obliga a descartar...**	Galactosemia (RN con cataratas e ictericia): fórmula de soya; lactancia materna y...
Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn	Joven con diarrea disentérica crónica + fiebre + baja de peso → colonoscopía con...	**Colitis ulcerosa: solo colon, desde el recto, continua, mucosa, p-ANCA. Crohn...**	Cirugía: colectomía cura la colitis ulcerosa; en Crohn solo se reseca el segmento...
Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje	La mayoría de los cánceres de colon nacen de un adenoma; resecar adenomas en la...	**Constipación reciente + anemia ferropénica en el adulto mayor = cáncer de colon →...**	—
Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula	Fisura ≠ fístula: la fisura es una herida dolorosa de manejo médico; la fístula es un...	**Hemorroide interno = sangrado sin dolor; siempre descartar otras causas de hemorragia...**	En la esfinterotomía de la fisura crónica se secciona el esfínter interno; nunca el...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopía si no hay signos...

Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y...

Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopía o colonoscopía para descartar cáncer.

Tratamiento: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Signos de alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y síntomas nocturnos.
- Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopía o colonoscopía para descartar cáncer.
- Diarrea aguda: el manejo es la hidratación (Plan A/B/C). Los antidiarreicos están contraindicados.
- Antibiótico en diarrea aguda solo si disentería, diarrea del viajero, fiebre persistente o sepsis. Elección: ciprofloxacino.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopía si...	Tema 2.1 →
Regla de los 3: diarrea = > 3 deposiciones/día; constipación = < 3 deposiciones/semana.	Tema 2.2 →
Test de Sudán confirma esteatorrea; test de D-xilosa localiza: alterado = pared (celíaca/Crohn), normal = enzimas...	Tema 2.3 →
Joven con diarrea disentérica crónica + fiebre + baja de peso → colonoscopía con biopsias.	Tema 2.4 →
La mayoría de los cánceres de colon nacen de un adenoma; resecar adenomas en la colonoscopía previene el cáncer.	Tema 2.5 →
Fisura ≠ fístula: la fisura es una herida dolorosa de manejo médico; la fístula es un trayecto de manejo...	Tema 2.6 →

MANUAL EUNACOM DE GASTROENTEROLOGÍA

BLOQUE 03 DE 06 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

03 HÍGADO

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico	54
3.2	Hepatitis Aguda y Crónica	58
3.3	Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	61
3.4	Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares	64

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.1.007, 4.01.1.026, 1.06.1.002, 1.06.4.006, 4.01.1.030, 4.01.1.031, 4.01.4.012, 1.01.4.012, 1.06.4.010	Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico	Específico	Inicial	Derivar
1.06.1.019, 1.06.1.020, 1.06.1.021, 1.06.4.012, 2.01.1.010, 2.01.1.045, 1.02.4.002, 1.02.4.011, 1.06.2.008, 1.06.2.009, 1.06.3.006, 1.06.4.008	Hepatitis Aguda y Crónica	Específico	Completo	Completo
1.06.1.005, 1.06.1.001, 1.06.2.011, 1.06.2.006, 4.01.3.009, 4.01.5.025, 1.02.3.010, 1.06.1.022, 1.06.4.011, 1.06.5.001, 1.10.2.006	Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	Específico	Inicial	Derivar
1.06.1.024, 4.01.1.023, 4.01.1.022, 1.06.1.003, 4.01.1.024, 4.01.1.028, 1.08.5.003	Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · HÍGADO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Paso 1: ¿bilirrubina indirecta (Gilbert, hemólisis) o directa? Paso 2 en la directa: transaminasas (hepatitis) vs FA/GGT (colestasia).
- Síndrome de Gilbert: hiperbilirrubinemia indirecta con el resto de las pruebas hepáticas normales → observar.
- Colestasia con dolor = patología biliar; con dolor y fiebre = colangitis; sin dolor en el adulto mayor = cáncer.
- Cáncer de páncreas: 3 D (diabetes, depresión, dolor) + baja de peso + ictericia silente + Courvoisier-Terrier.
- La ecografía abdominal es siempre el primer examen de toda ictericia; el TAC se reserva para la sospecha de cáncer de páncreas.
- Hepatitis aguda: el riesgo es la fulminante (ictericia + encefalopatía); se vigila con el tiempo de protrombina.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico	EUNACOM Diciembre 2025 · #85 · EUNACOM Diciembre 2025 · #108 · EUNACOM Julio 2024 · #169 · EUNACOM Diciembre 2024 · #161
Hepatitis Aguda y Crónica	EUNACOM Julio 2024 · #26 · EUNACOM Diciembre 2024 · #102 · EUNACOM Diciembre 2022 · #146 · EUNACOM Diciembre 2019 · #83
Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	EUNACOM Diciembre 2025 · #125 · EUNACOM Julio 2025 · #129 · EUNACOM Diciembre 2024 · #39 · EUNACOM Julio 2024 · #175
Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares	EUNACOM Diciembre 2024 · #44 · EUNACOM Julio 2024 · #118 · EUNACOM Enero 2023 · #79 · EUNACOM Diciembre 2022 · #164

3.1. Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.007 | 4.01.1.026 | 1.06.1.002 | 1.06.4.006 | 4.01.1.030 | 4.01.1.031 | 4.01.4.012 | 1.01.4.012 | 1.06.4.010

¿POR QUÉ?

La ictericia se ordena con dos preguntas y en ese orden. Primero: ¿la bilirrubina que sube es la indirecta o la directa? Si es indirecta con todo lo demás normal, es Gilbert y se observa. Si es directa, la segunda pregunta separa hepatitis (suben las transaminasas) de colestasia (suben las fosfatasas alcalinas y la GGT). Y dentro de la colestasia, el dolor y la fiebre lo dicen todo: sin dolor en un adulto mayor = cáncer.

1. CONCEPTOS Y PRIMER PASO: TIPO DE BILIRRUBINA

Bilirrubina total normal < 1,1 mg/dL; la ictericia se hace visible sobre 2,5–3 mg/dL (primero en las escleras). La carotenemia tiñe palmas y plantas pero no las escleras y es benigna. **(ver Imagen 3.1A y C)** 1.01.4.012 | 1.06.4.010



Ictericia escleral



Ictericia escleral

Hiperbilirrubinemia indirecta (no conjugada): síndrome de Gilbert (resto de las pruebas hepáticas normales, benigno, 5–10 % de la población → observar) y hemólisis (LDH alta, esquistocitos, anemia → tratar la causa). **Hiperbilirrubinemia directa** (directa > 30 % del total): siempre patológica. 4.01.4.012 | 1.01.4.012 | 1.06.4.010

2. SEGUNDO PASO: HEPATITIS VS COLESTASIA

Dentro de la hiperbilirrubinemia directa, las transaminasas (AST/ALT) elevadas indican **hepatitis** (lesión del hepatocito); las fosfatasas alcalinas y la GGT elevadas indican **colestasia** (obstrucción del flujo biliar). La GGT alta confirma que la fosfatasa alcalina alta es de origen hepatobiliar y no óseo. 1.06.1.007 | 4.01.4.012 | 1.01.4.012 | 1.06.4.010

3. CLASIFICACIÓN DE LA COLESTASIA

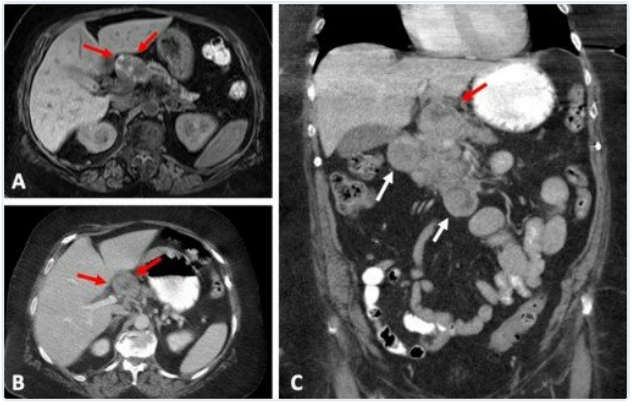
Colestasia crónica autoinmune: cirrosis biliar primaria (AMA, prurito, mujer) y colangitis esclerosante primaria (ANCA, colitis ulcerosa) — ver clase de hepatitis crónica. 1.06.1.007

Colestasia aguda con dolor: coledocolitiasis (dolor + ictericia) y colangitis (tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre). **Colestasia sin dolor (silente) en el adulto mayor: cáncer** — de páncreas (el más frecuente), de la ampolla de Vater, colangiocarcinoma o de vesícula. 1.06.1.007 | 4.01.1.026 | 1.06.1.002 | 4.01.1.030 | 4.01.1.031

4. ICTERICIA MALIGNA: CLÍNICA Y ESTUDIO

Cáncer de páncreas — las **"3 D"**: Diabetes de reciente inicio, Depresión inexplicada, Dolor sordo, más baja de peso e ictericia progresiva indolora. **Signo de Courvoisier-Terrier:** vesícula palpable e indolora con ictericia. 4.01.1.026 | 1.06.1.002 | 4.01.1.030 | 4.01.1.031

Estudio: ecografía abdominal siempre primero (¿vía biliar dilatada?, ¿colédoco?, ¿masa?). Luego colangiorresonancia como examen de elección de la vía biliar; si la ecografía muestra o sugiere una masa pancreática, el examen es el TAC de abdomen con contraste (mejor para el páncreas). **(ver Imagen 3.1B)** 4.01.1.026 | 1.06.1.002 | 4.01.1.030 | 4.01.1.031 | 1.06.4.006



TAC con masa en cabeza de páncreas y vía biliar dilatada

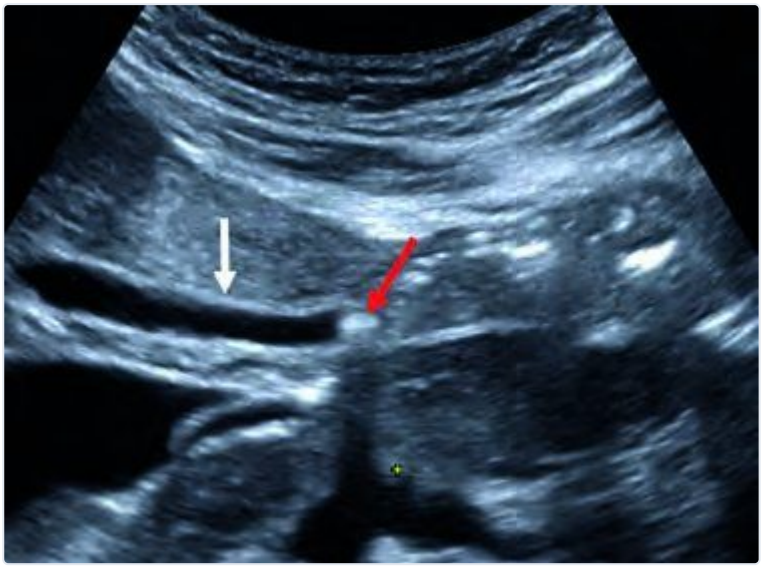
5. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS Y TUMORES PREAMPULARES

Cáncer de páncreas (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): solo el 15–20 % es resecable al diagnóstico. En tumores de la cabeza resecables se hace la **duodenopancreatectomía cefálica (Whipple)** seguida de quimioterapia adyuvante; en los localmente avanzados o con metástasis se da quimioterapia paliativa (FOLFIRINOX o gemcitabina). La paliación incluye la **prótesis biliar por CPRE** para la ictericia y el prurito, analgesia (bloqueo del plexo celíaco si el dolor es refractario), enzimas pancreáticas y anticoagulación si hay trombosis. La sobrevida a 5 años es menor de 10 %: el médico general sospecha, hace el estudio inicial y deriva sin demora. 1.06.1.002 | 4.01.1.030

Otros tumores preampulares: el **ampuloma** (tumor de la ampolla de Vater) da ictericia *fluctuante* (el tumor se necrosa y se reabre), anemia o melena y a veces pancreatitis; tiene mejor pronóstico porque obstruye precozmente. También se incluyen el colangiocarcinoma distal y el cáncer duodenal. Se diagnostican con ecoendoscopía o duodenoscopía con biopsia de la papila y se tratan igual con cirugía de Whipple. 4.01.1.030



A. ICTERICIA ESCLERAL



B. COLÉDOCO DILATADO (ECO)



C. CÁLCULO EN COLANGIO-RM

Imagen 3.1

TABLA 3.1 · ICTERICIA — PATRÓN BIOQUÍMICO Y ORIENTACIÓN

1.06.1.007, 4.01.1.026, 1.06.1.002, 1.06.4.006, 4.01.1.030, 4.01.1.031, 4.01.4.012, 1.01.4.012, 1.06.4.010

PATRÓN	CONTEXTO	DIAGNÓSTICO / CONDUCTA
Bilirrubina indirecta aislada, resto normal	Joven asintomático	Síndrome de Gilbert → observar
Bilirrubina indirecta + anemia + LDH alta	Esquistocitos	Hemólisis → tratar la causa
↑ AST/ALT (transaminasas)	Con o sin ictericia	Hepatitis
↑ FA/GGT + dolor	Cólico biliar	Coledocolitiasis → eco → colangio-RM → CPRE
↑ FA/GGT + dolor + fiebre	Tríada de Charcot	Colangitis → CPRE urgente + antibióticos
↑ FA/GGT sin dolor	Adulto mayor, baja de peso	Cáncer → eco → colangio-RM (o TAC si páncreas)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Hombre de 70 años consulta por ictericia que ha ido en aumento durante 6 semanas, prurito, coluria y baja de 8 kg de peso. No tiene dolor abdominal ni fiebre. Le diagnosticaron diabetes hace 2 meses. Al examen: ictericia marcada y una vesícula palpable, no dolorosa, en el hipocondrio derecho.

Conducta oficial. Ictericia progresiva e indolora en un adulto mayor, con baja de peso, diabetes de reciente inicio y signo de Courvoisier-Terrier (vesícula palpable indolora): es una ictericia obstructiva maligna, y la primera causa a considerar es el cáncer de cabeza de páncreas ("las 3 D"). El estudio comienza con ecografía abdominal y, ante la sospecha de masa pancreática, el examen de elección es el TAC de abdomen con contraste.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Paso 1: ¿bilirrubina indirecta (Gilbert, hemólisis) o directa? Paso 2 en la directa: transaminasas (hepatitis) vs FA/GGT (colestasia).
- Síndrome de Gilbert: hiperbilirrubinemia indirecta con el resto de las pruebas hepáticas normales → observar.
- Colestasia con dolor = patología biliar; con dolor y fiebre = colangitis; sin dolor en el adulto mayor = cáncer.
- Cáncer de páncreas: 3 D (diabetes, depresión, dolor) + baja de peso + ictericia silente + Courvoisier-Terrier.
- La ecografía abdominal es siempre el primer examen de toda ictericia; el TAC se reserva para la sospecha de cáncer de páncreas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Estudiante de 22 años, asintomático, consulta porque en un examen preventivo le encontraron una bilirrubina total de 2,6 mg/dL, a expensas de la indirecta. Las transaminasas, fosfatasas alcalinas, GGT, hemograma y LDH son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A) Hepatitis viral aguda; solicitar serología viral y control seriado
B) Anemia hemolítica; frotis y test de Coombs
C) Síndrome de Gilbert; tranquilizar y no requiere tratamiento
D) Coledocolitiasis; ecografía abdominal urgente
E) Cirrosis biliar primaria; anticuerpos antimitocondriales

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Mujer de 55 años con dolor cólico en el hipocondrio derecho e ictericia de 2 días, sin fiebre. Laboratorio: bilirrubina 4 mg/dL de predominio directo, fosfatasas alcalinas y GGT elevadas, transaminasas levemente altas. La ecografía muestra colelitiasis y una vía biliar de 9 mm, sin visualizar cálculos en el colédoco. ¿Cuál es el siguiente examen?

A) CPRE directa
B) Colangiorresonancia
C) TAC de abdomen con contraste
D) Biopsia hepática percutánea
E) Repetir la ecografía en 48 horas

Más preguntas online de Ictericia y Colestasia →

3.2. Hepatitis Aguda y Crónica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.019 1.06.1.020 1.06.1.021 1.06.4.012 2.01.1.010 2.01.1.045 1.02.4.002 1.02.4.011 1.06.2.008 1.06.2.009 1.06.3.006 1.06.4.008

¿POR QUÉ?

Toda la clase gira en torno a un contraste: la hepatitis aguda mata rápido (por fulminante: ictericia + encefalopatía) y se vigila con el tiempo de protrombina; la hepatitis crónica mata lento (por cirrosis) y se evalúa con biopsia. Y hay una tabla de serología de la hepatitis B que se pregunta literal: el antígeno de superficie dice "hay virus", la IgM anti-core dice "es agudo", y si solo está la IgM sin antígeno, es el período de ventana.

1. AGUDA VS CRÓNICA: EL EJE QUE ORDENA TODA LA CLASE

Hepatitis es la elevación de transaminasas (AST/GOT y ALT/GPT) por inflamación del hepatocito; el manejo universal es identificar la causa, tratarla y dar soporte. La división aguda (< 6 meses) vs crónica (> 6 meses) no es académica: define el riesgo que se vigila y el examen que se pide.

La hepatitis aguda —VHA, VHB, VHE, herpesvirus (VEB, CMV, VHS), alcohol, fármacos y tóxicos (Amanita phalloides)— mata por **hepatitis fulminante**: encefalopatía (desorientación, asterixis, sopor) que aparece dentro de las 8 semanas de iniciada la ictericia en un hígado previamente sano. El marcador pronóstico y el criterio de derivación a trasplante es el **tiempo de protrombina / INR**, no la bilirrubina ni el nivel de transaminasas. **(ver Imagen 3.2)** 2.01.1.045 1.06.2.009 1.02.4.011

La hepatitis crónica —NASH, VHB, VHC, hepatitis autoinmune — mata por cirrosis; se estadifica con elastografía hepática (FibroScan) o biopsia, que separan el grado de inflamación (velocidad de progresión) del estadio de fibrosis (daño ya establecido). 1.06.1.021 1.06.4.008

2. HEPATITIS A Y E: LA AGUDA QUE SE RESUELVE SOLA

VHA: transmisión fecal-oral (agua y alimentos contaminados, contactos en jardines infantiles, práctica sexual oro-anal); en Chile es endémica, con brotes, y es enfermedad de notificación obligatoria inmediata a la SEREMI de Salud. Clínica: pródromo de fiebre y malestar → ictericia, coluria y acolia; en niños suele ser anictérica. Diagnóstico: **IgM anti-VHA** (primer examen ante toda hepatitis aguda); la IgG aislada indica infección pasada o vacunación. 1.06.1.019 1.06.4.012 2.01.1.010

Formas atípicas: colestásica (predominan FA y GGT), recurrente (recae a las 4–8 semanas por mecanismo inmune) y fulminante (~0,1 %). Contactos: extradomiciliarios → vacuna; convivientes → inmunoglobulina más vacuna. Desde 2018 la vacuna anti-VHA está en el PNI chileno a los 18 meses. La VHE se comporta como la VHA salvo en la embarazada, en quien la falla hepática aguda tiene letalidad de hasta 20 %. 1.06.1.019 1.06.2.008 2.01.1.010

3. HEPATITIS B: LA SEROLOGÍA QUE SE PREGUNTA DE MEMORIA

VHB: transmisión sexual (principal en el adulto), parenteral (~30 % de contagio en accidente cortopunzante con fuente AgHBs+) y vertical. En el adulto inmunocompetente el 90 % cura y solo el 10 % cronifica —a la inversa del recién nacido, que cronifica > 90 %—. Riesgo de fulminante ~1 % (diez veces el de la VHA). 1.06.1.020 2.01.1.010

Serología EUNACOM: AgHBs (+) = "hay virus" (infección activa) e IgM anti-HBc (+) = "es aguda". Combinaciones: AgHBs (+) + IgM anti-HBc (+) → hepatitis B aguda; AgHBs (+) + IgM anti-HBc (–) → hepatitis B crónica; AgHBs (–) + IgM anti-HBc (+) → período de ventana. Anti-HBs aislado (sin anti-HBc) = inmune por vacuna; anti-HBs + anti-HBc IgG = infección resuelta. La vacuna genera solo anti-HBs: si hay cualquier anticuerpo anti-HBc, el paciente estuvo infectado, no vacunado. 1.06.1.020 1.06.4.012 2.01.1.010

Brote agudo: soporte + TP. La hepatitis crónica B y C tiene garantía GES: derivar para carga viral, HBeAg, elastografía y antivirales (tenofovir o entecavir). Contactos: vacuna; exposición reciente → inmunoglobulina anti-HB + vacuna; RN de madre AgHBs (+) → vacuna + inmunoglobulina en las primeras 12 h, sin contraindicar la lactancia. 1.06.1.020 1.06.1.021 2.01.1.010

4. HEPATITIS C: CASI SIEMPRE CRÓNICA, HOY CURABLE

VHC: transmisión parenteral (drogas endovenosas, transfusiones previas a 1996, tatuajes y pírsines sin control); rara vez produce un cuadro agudo reconocible y el 80–90 % cronifica. Diagnóstico en dos pasos: anticuerpos anti-VHC como tamizaje → confirmación con **ARN-VHC por PCR**, porque un anticuerpo positivo con PCR negativa corresponde a infección pasada resuelta. 1.06.1.020 1.06.4.012 2.01.1.010

Tratamiento: **antivirales de acción directa (AAD)** por 8–12 semanas, con > 95 % de respuesta viral sostenida (curación); el interferón quedó obsoleto. En Chile el tratamiento está garantizado, con meta sanitaria de eliminación. Si ya hay cirrosis, la vigilancia semestral de hepatocarcinoma con ecografía se mantiene aunque el virus se haya erradicado. 1.06.1.020 1.06.1.021 2.01.1.010

5. HEPATITIS ALCOHÓLICA Y POR FÁRMACOS: PATRÓN DE LABORATORIO Y CONDUCTA

Hepatitis alcohólica: ictericia y hepatomegalia dolorosa en un bebedor; el sello es la **relación AST/ALT > 2** con ambas habitualmente < 300–400 U/L —a diferencia de las hepatitis virales o tóxicas, que superan 1.000— más GGT y VCM elevados. La gravedad se estima con la función discriminante de Maddrey (usa TP y bilirrubina): si es grave o hay encefalopatía se agregan corticoides (prednisolona) a la abstinencia y el soporte nutricional. 1.06.1.020 1.02.4.011

Hepatitis por fármacos: cualquier fármaco; los clásicos son paracetamol (dosis-dependiente; antídoto N-acetilcisteína, útil incluso de forma tardía), antituberculosos (isoniazida, pirazinamida, rifampicina → suspender todos y derivar), amoxicilina-clavulánico, estatinas, isotretinoína, antiepilépticos y nitrofurantoína. La conducta es siempre suspender el fármaco de inmediato; el diagnóstico es por descarte y por la relación temporal con el inicio del fármaco. 1.06.1.020 1.06.2.009

6. HEPATITIS CRÓNICAS NO VIRALES: NASH Y LAS AUTOINMUNES

NASH / esteatohepatitis metabólica: hoy la causa más frecuente de hepatopatía crónica; ocurre en resistencia a la insulina (obesidad, DM2, dislipidemia, síndrome metabólico). Ecografía con hígado hiperecogénico ("brillante"); transaminasas levemente altas con AST/ALT < 1. Diagnóstico de exclusión. Tratamiento: baja de peso ≥ 7–10 %, ejercicio y control metabólico. 1.06.1.021 1.02.4.002 1.06.3.006

Hepatitis autoinmune: mujer con otra enfermedad autoinmune (tiroiditis de Hashimoto), hipergammaglobulinemia y ANA/ASMA/anti-LKM1; biopsia con hepatitis de interfase → corticoides + azatioprina. Cirrosis biliar primaria: mujer de 40–60 años con prurito y colestasia (FA y GGT altas, transaminasas normales), AMA (+) → ácido ursodesoxicólico. Colangitis esclerosante primaria: hombre joven con colitis ulcerosa y p-ANCA; colangio-RM con vía biliar "en rosario" y riesgo de colangiocarcinoma. 1.06.1.021 1.06.4.008

7. ECOGRAFÍA Y BIOPSIA HEPÁTICA, Y HEPATITIS A COMPLICADA

Ecografía hepática sistemática (nivel: emplear el informe): se revisa tamaño y borde del hígado, ecogenicidad, vía biliar, vena porta, bazo y líquido libre. **Esteatosis:** hígado hiperecogénico («brillante»). **Cirrosis:** borde nodular, ecogenicidad heterogénea, atrofia del lóbulo derecho con hipertrofia del caudado, esplenomegalia, vena porta > 13 mm y ascitis. Es también el método de vigilancia del **hepatocarcinoma**: ecografía cada 6 meses (con alfa-fetoproteína) en todo cirrótico y en la hepatitis B crónica de riesgo. 1.02.4.002



Ecografía de hígado graso / esteatosis hepática

Biopsia hepática (informe): hoy se reserva para casos dudosos (hepatitis autoinmune, superposiciones, hepatopatía de causa no aclarada). Se hace por vía percutánea guiada por ecografía, con INR < 1,5 y plaquetas > 50.000–60.000/mm³; con ascitis o coagulopatía se usa la vía transyugular. El informe entrega el **grado** de actividad necroinflamatoria (p. ej. METAVIR A0–A3) y el **estadio** de fibrosis (F0 a F4; F4 = cirrosis); la elastografía y los marcadores no invasivos la han reemplazado en la mayoría. Complicaciones: dolor (frecuente), hemorragia (< 1 %), neumotórax y peritonitis biliar. 1.06.4.008

Hepatitis A complicada (nivel: diagnóstico específico, tratamiento inicial, derivar): se sospecha ante vómitos incoercibles, ictericia intensa con bilirrubina muy alta, **INR alargado** o cualquier signo de encefalopatía, y en pacientes mayores de 40 años o con hepatopatía crónica previa (más riesgo de falla hepática). Conducta: hospitalizar, controlar INR y glicemia, evitar sedantes, paracetamol y alcohol, y derivar a un centro con unidad de trasplante si hay encefalopatía o INR ≥ 1,5 (hepatitis fulminante). La forma colestásica prolongada tiene buen pronóstico y se maneja ambulatoria; la recurrente (4–8 semanas) también evoluciona bien. 1.06.2.008

MARCADORES EN EL TIEMPO

Imagen 3.2

TABLA 3.2 · SEROLOGÍA DE LA HEPATITIS B — LAS COMBINACIONES QUE SE PREGUNTAN

1.06.1.019, 1.06.1.020, 1.06.1.021, 1.06.4.012, 2.01.1.010, 2.01.1.045, 1.02.4.002, 1.02.4.011, 1.06.2.008, 1.06.2.009, 1.06.3.006, 1.06.4.008

AGHBS	IGM ANTI-HBC	ANTI-HBS	INTERPRETACIÓN
(+)	(+)	(–)	Hepatitis B aguda
(+)	(–)	(–)	Hepatitis B crónica
(–)	(+)	(–)	Período de ventana (aguda, antígeno aún negativo)
(–)	(–)	(+) con anti-HBc IgG (+)	Infección pasada resuelta
(–)	(–)	(+) con anti-HBc (–)	Inmune por vacuna

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.2

Hombre de 38 años, asintomático, se realiza exámenes por una donación de sangre. Resultado: transaminasas levemente elevadas, HBsAg positivo e IgM anti-HBc negativa. Se solicita carga viral, que resulta detectable.

Conducta oficial. HBsAg positivo indica infección activa por virus B; la IgM anti-HBc negativa descarta que sea una infección aguda. La combinación HBsAg (+) con IgM anti-HBc (−) define una hepatitis B crónica. Corresponde derivar a especialista para estadificar (elastografía o biopsia, carga viral, HBeAg) y decidir tratamiento antiviral, además de estudiar coinfecciones y vacunar a los contactos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Hepatitis aguda: el riesgo es la fulminante (ictericia + encefalopatía); se vigila con el tiempo de protrombina.
- Hepatitis crónica: el riesgo es la cirrosis; se evalúa con biopsia o elastografía.
- HBsAg = "hay virus"; IgM anti-HBc = "es aguda"; HBsAg (+) con IgM anti-HBc (−) = hepatitis B crónica.
- Hepatitis A: contacto extradomiciliario → vacuna; contacto intradomiciliario → inmunoglobulina.
- Relación AST/ALT > 2 = hepatitis alcohólica. Paracetamol → N-acetilcisteína.
- Prurito + AMA + mujer = cirrosis biliar primaria. Colitis ulcerosa + ANCA + vía biliar "en rosario" = colangitis esclerosante primaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 122

1. Una paciente se realiza exámenes porque su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para VHB (AgHBs) negativo y anticuerpos anti-HBs (antisuperficie) positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vacunada contra la hepatitis B
B) Hepatitis B aguda
C) Hepatitis B crónica
D) Hepatitis B en período de ventana
E) Infección asintomática por virus hepatitis B

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 26

2. Mujer de 30 años con 10 días de astenia, fiebre, malestar y dolor epigástrico; hace 2 días se agregó ictericia y hoy orinas oscuras. Al examen: FC 96/min, PA 100/60, ictericia franca, sin compromiso de conciencia, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho sin signos peritoneales. Laboratorio: GOT 2.640 U/L, GPT 2.860 U/L, GGT 180, FA 412, protrombinemia 52 %, bilirrubina total 9,2 mg/dL (directa 6,6), albúmina 3,4 g/dL. IgM anti-VHA 5,5 U (VN < 0,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar de forma ambulatoria
D) Solicitar colangiopancreatografía por resonancia magnética
E) Indicar N-acetilcisteína oral

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 83

3. Mujer de 20 años en tratamiento con isotretinoína hace 10 días por acné consulta por dolor abdominal, malestar y astenia, con ictericia y orinas oscuras. Examen: ictericia, dolor en epigastrio e hipocondrio, hígado palpable 3 cm bajo el reborde costal. Laboratorio: GOT 328 U/L, GPT 459 U/L, bilirrubina 1,8 mg/dL, FA 80, GGT 92, protrombinemia 80 %. Serología: IgG anti-VHA (+), IgM anti-VHA (−), AgHBs (−), anti-HBc totales (+); anti-VHC y autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por fármacos
E) Hepatitis autoinmune

Más preguntas online de Hepatitis Aguda y Crónica →

3.3. Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

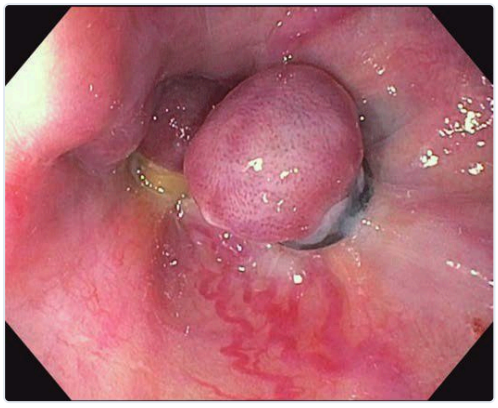
CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.005 | 1.06.1.001 | 1.06.2.011 | 1.06.2.006 | 4.01.3.009 | 4.01.5.025 | 1.02.3.010 | 1.06.1.022 | 1.06.4.011 | 1.06.5.001 | 1.10.2.006

¿POR QUÉ?

La cirrosis descompensa por dos vías. La hipertensión portal genera várices, ascitis y síndrome hepatorrenal; la insuficiencia hepática genera encefalopatía y coagulopatía. Dos reglas se preguntan sin falta: a todo cirrótico con ascitis que llega a urgencias se le hace paracentesis diagnóstica antes que nada (para descartar peritonitis bacteriana espontánea), y el TIPS está contraindicado si hay encefalopatía, porque desviar la sangre del hígado la empeora.

1. VÁRICES ESOFÁGICAS

Todo cirrótico se hace endoscopía para pesquisar várices. 1.06.1.005 **Profilaxis primaria** (nunca sangró): betabloqueo no selectivo (propranolol/carvedilol); si está contraindicado, ligadura endoscópica. 4.01.3.009 **Profilaxis secundaria** (ya sangró): propranolol + ligadura. **(ver Imagen 3.3A, B y C)**



Várices esofágicas en endoscopía y ligadura con bandas

Hemorragia variceal activa: reposición de volumen + terlipresina (o somatostatina/octreótido) + antibióticos (ceftriaxona, profilaxis de PBE) + endoscopía con ligadura en las primeras 12 h; tiamina si es alcohólico. Refractaria → TIPS.

2. ASCITIS

Tratamiento de la ascitis no complicada: restricción de sodio + espironolactona ± furosemida. Ascitis a tensión: paracentesis evacuadora + albúmina (≈ 8 g por litro extraído). Ascitis refractaria: paracentesis seriadas con albúmina; considerar TIPS o trasplante. 1.06.1.005 | 1.06.1.001 | 4.01.5.025 | 1.06.5.001 | 1.02.3.010

El gradiente albúmina sérica-ascítica ≥ 1,1 g/dL confirma que la causa es hipertensión portal. Una albúmina en el líquido < 1,5 g/dL indica alto riesgo de PBE (profilaxis primaria). 1.06.1.001 | 4.01.3.009

3. PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA (PBE)

A todo cirrótico con ascitis que consulta se le hace **paracentesis diagnóstica**. Diagnóstico: ≥ 250 polimorfonucleares/mm³ en el líquido ascítico. Agente más frecuente: E. coli. 1.06.1.001 | 1.06.2.011 | 4.01.5.025 | 1.06.5.001

Tratamiento: cefotaxima (o ceftriaxona) endovenosa por 5–7 días + **albúmina (día 1 y día 3)** para prevenir el síndrome hepatorrenal. Tras una PBE, profilaxis secundaria indefinida con ciprofloxacino mientras persista la ascitis. 1.06.2.011

4. ENCEFALOPATÍA, SÍNDROME HEPATORRENAL Y COAGULOPATÍA

Encefalopatía hepática: desorientación + asterixis; precipitante más frecuente = infección (también hemorragia digestiva, constipación, sedantes, diuréticos). Tratamiento: buscar y tratar el precipitante + lactulosa titulada a 2–3 deposiciones blandas al día (+ rifaximina). **El TIPS está contraindicado en la encefalopatía.** 1.06.1.005 | 1.06.2.006 | 1.10.2.006

Síndrome hepatorrenal: falla renal funcional del cirrótico avanzado, de muy mal pronóstico → terlipresina + albúmina y trasplante. Coagulopatía: INR alto (déficit de factores) + trombopenia (hiperesplenismo); se corrige solo ante sangrado o procedimientos. 1.06.1.005 | 1.06.1.022 | 1.06.4.011

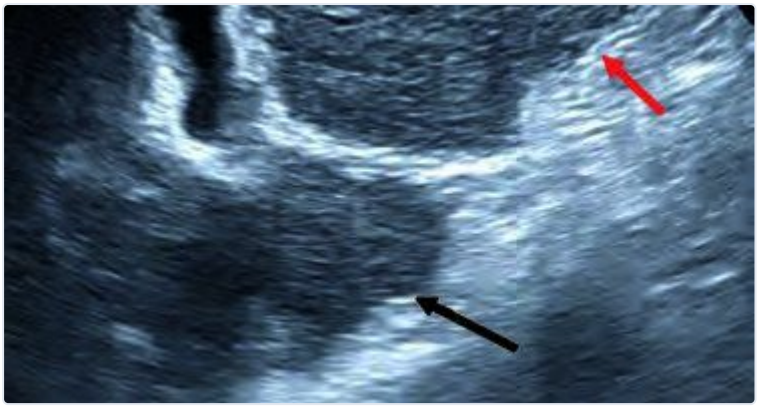
5. PARACENTESIS, DIETA Y FUNCIÓN HEPÁTICA DEL CIRRÓTICO

Técnica de la paracentesis (nivel: realizar): con consentimiento, vejiga vacía y paciente semisentado o en decúbito lateral. Se punciona en la **fosa ilíaca izquierda** (2–3 cm sobre y medial a la espina ilíaca anterosuperior) o en la línea media bajo el ombligo, evitando cicatrices y los vasos epigástricos; asepsia, anestesia local y **técnica en Z** para que no filtre líquido. **Diagnóstica:** 30–60 mL para recuento celular, albúmina (gradiente), cultivo en frascos de hemocultivo junto a la cama y, según el caso, proteínas y citología. **Evacuadora:** con catéter, y albúmina 6–8 g por litro si se sacan más de 5 L. No se corrige el INR ni las plaquetas de rutina. Complicaciones: filtración, hematoma de pared, perforación intestinal e hipotensión por disfunción circulatoria posparacentesis. 4.01.5.025 | 1.06.5.001

Régimen dietético del cirrótico: sodio < 2 g/día (sin sal agregada y sin alimentos procesados); **no restringir líquidos** salvo hiponatremia < 125 mEq/L; **no restringir proteínas** (1,2–1,5 g/kg/día, incluso en la encefalopatía); aporte calórico adecuado (35 kcal/kg), comidas fraccionadas y una colación nocturna para evitar el catabolismo; abstinencia absoluta de alcohol. 1.02.3.010

Estudio de la función hepática y Child-Pugh (nivel: interpretar y emplear): la función de síntesis se lee con la **albúmina**, el **INR** (factores de coagulación) y la bilirrubina; las transaminasas miden daño, no función. El **Child-Pugh** suma cinco variables (bilirrubina, albúmina, INR, ascitis y encefalopatía): A = 5–6 puntos (compensado), B = 7–9, C = 10–15 (descompensado, peor pronóstico). El **MELD** (bilirrubina, INR, creatinina, sodio) ordena la lista de espera de trasplante. 1.06.4.011

Insuficiencia hepática crónica, enfoque global: se reconoce por ictericia, coagulopatía, hipoalbuminemia con edema y ascitis, encefalopatía, eritema palmar, arañas vasculares, ginecomastia y atrofia testicular. Ante una descompensación se busca el desencadenante (infección, hemorragia, alcohol, fármacos, trombosis portal, hepatocarcinoma). Medidas de base: abstinencia, vacunas (hepatitis A, B, neumococo, influenza), evitar AINE y sedantes, vigilancia ecográfica del hepatocarcinoma y derivación a trasplante al aparecer una complicación mayor o un MELD ≥ 15. 1.06.1.022



A. ECOGRAFÍA EN LA CIRROSIS



B. PORTOGRAFÍA: COLATERALES



C. CABEZA DE MEDUSA

Imagen 3.3

TABLA 3.3 · COMPLICACIONES DEL CIRRÓTICO — CONDUCTA CLAVE

1.06.1.005, 1.06.1.001, 1.06.2.011, 1.06.2.006, 4.01.3.009, 4.01.5.025, 1.02.3.010, 1.06.1.022, 1.06.4.011, 1.06.5.001, 1.10.2.006

SITUACIÓN	CONDUCTA DE PRIMERA LÍNEA	TRAMPA FRECUENTE
Várices que nunca sangraron	Betabloqueo no selectivo (propranolol)	Ligar de entrada sin indicación
Hemorragia variceal activa	Volumen + terlipresina + antibióticos + ligadura	Omitir los antibióticos
Ascitis a tensión	Paracentesis diagnóstica primero, luego evacuadora + albúmina	Drenar sin descartar PBE
Líquido ascítico con ≥ 250 PMN/mm³	Cefotaxima + albúmina	Usar aminoglucósidos (nefrotóxicos)
Encefalopatía + ascitis refractaria	Lactulosa + tratar precipitante; NO TIPS	Indicar TIPS

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.3

Hombre de 58 años con cirrosis por alcohol, en control ambulatorio, consulta por aumento del perímetro abdominal en la última semana y febrículas. Al examen: ascitis moderada, sin dolor peritoneal, sin encefalopatía. Está hemodinámicamente estable.

Conducta oficial. Cirrótico con ascitis y fiebre: la primera conducta, antes de ajustar diuréticos o cualquier otra medida, es la paracentesis diagnóstica para descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Si el recuento de polimorfonucleares en el líquido ascítico es ≥ 250/mm³, se inicia cefotaxima endovenosa y albúmina. La fiebre, aunque sea baja, en un cirrótico con ascitis obliga a puncionar.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Todo cirrótico con ascitis que consulta: paracentesis diagnóstica antes que nada (descartar PBE).
- PBE: ≥ 250 PMN/mm³ → cefotaxima/ceftriaxona endovenosa + albúmina (días 1 y 3).
- Várices: profilaxis primaria = propranolol; secundaria = propranolol + ligadura; sangrado activo = terlipresina + antibióticos + ligadura.
- Ascitis a tensión: paracentesis evacuadora + albúmina (~8 g/L). El gradiente albúmina suero-ascitis ≥ 1,1 confirma hipertensión portal.
- Encefalopatía: tratar el precipitante (casi siempre infección) + lactulosa a 2–3 deposiciones/día. El TIPS está contraindicado.
- Síndrome hepatorrenal: terlipresina + albúmina y trasplante; pronóstico muy malo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Paciente con cirrosis y várices esofágicas medianas encontradas en una endoscopía de tamizaje. Nunca ha presentado hemorragia digestiva. ¿Cuál es la profilaxis indicada?

A) Ligadura endoscópica de várices + propranolol
B) Propranolol (o carvedilol) por vía oral, titulado por frecuencia cardíaca
C) Instalación electiva de TIPS
D) Terlipresina endovenosa mensual
E) Ácido tranexámico oral permanente

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Cirrótico con ascitis refractaria a diuréticos que además ha tenido dos episodios de encefalopatía hepática en el último mes. El equipo tratante propone instalar un TIPS para controlar la ascitis. ¿Cuál es la conducta correcta?

A) Instalar el TIPS: resuelve simultáneamente la ascitis y reduce el riesgo de várices
B) No instalar el TIPS: la encefalopatía es una contraindicación
C) Instalar el TIPS solo si se agrega lactulosa profiláctica
D) Instalar el TIPS y suspender los betabloqueadores
E) Instalar el TIPS con anestesia general para evitar la descompensación

Más preguntas online de Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal →

3.4. Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.024 | 4.01.1.023 | 4.01.1.022 | 1.06.1.003 | 4.01.1.024 | 4.01.1.028 | 1.08.5.003

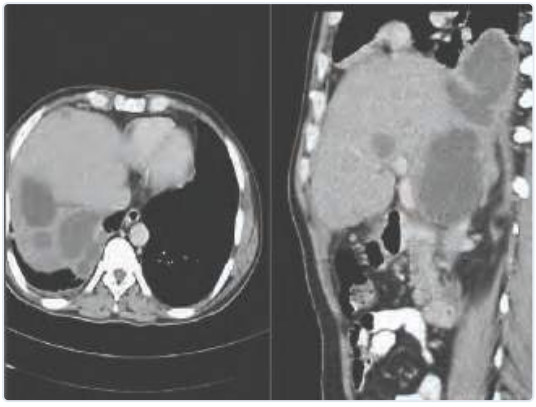
¿POR QUÉ?

El eco describe la lesión y la palabra clave orienta casi todo. Anecogénica y lisa = quiste simple (observar). Hiperecogénica y homogénea = hemangioma (observar). Hipoecogénica única y homogénea en una mujer que usa anticonceptivos = adenoma (resecar, porque sangra y puede malignizar). Heterogénea e irregular en un cirrótico = hepatocarcinoma. Y con los pólipos de vesícula, el umbral es 1 cm: sobre 1 cm o heterogéneo, colecistectomía.

1. LESIONES QUÍSTICAS

Quiste simple: anecogénico, de pared fina, sin tabiques ni contenido → observar. Quiste hidatídico: con membrana, tabiques o vesículas hijas (contexto rural, contacto con perros) → albendazol + cirugía (o PAIR); evitar la punción libre por riesgo de anafilaxia y siembra. **(ver Imagen 3.4A)** 1.06.1.024 | 4.01.1.023 | 4.01.1.022

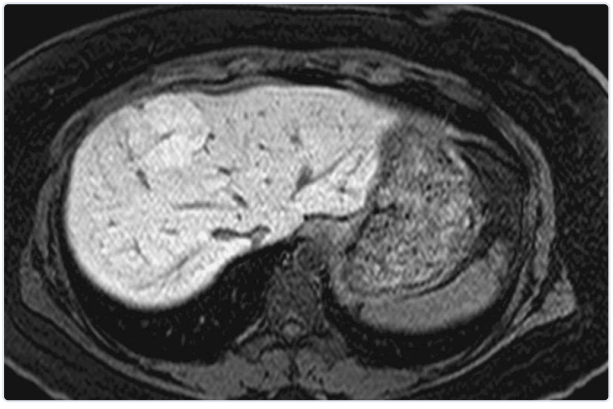
Absceso hepático: lesión hipoecogénica de contornos irregulares, con fiebre y dolor. Amebiano (serología, viajero) → metronidazol, habitualmente sin drenaje. Piógeno → antibióticos de amplio espectro + drenaje. 1.06.1.024 | 4.01.1.023



Absceso hepático en ecografía/TC

2. LESIONES SÓLIDAS BENIGNAS

Hemangioma: la lesión hepática benigna más frecuente; hiperecogénico, homogéneo, bien delimitado. Conducta: observar (cirugía solo si es gigante y sintomático). Hiperplasia nodular focal: cicatriz central; benigna, sin riesgo → observar. **(ver Imagen 3.4B)** 1.06.1.024 | 4.01.1.024



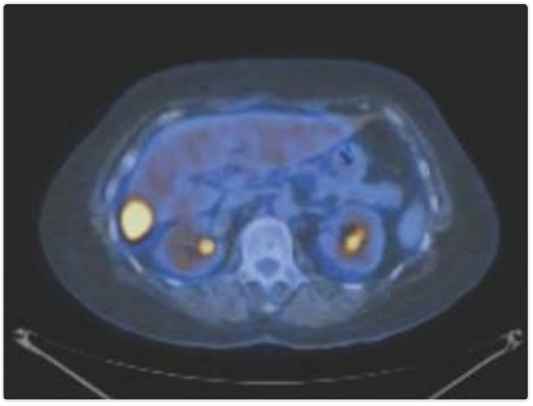
Hiperplasia nodular focal con cicatriz central

Adenoma hepático: lesión hipoecogénica, única, homogénea, en mujeres usuarias de anticonceptivos orales o esteroides anabólicos; riesgo de hemorragia y de malignización → suspender los estrógenos y resecar los > 5 cm o sintomáticos.

3. LESIONES MALIGNAS

Hepatocarcinoma: lesión heterogénea, de contornos irregulares, en un hígado con daño hepático crónico (sobre todo cirrosis por virus B o C); alfa-fetoproteína elevada; se confirma por el comportamiento del contraste en TAC/RM trifásico (realce arterial + lavado). Tratamiento: resección, ablación o trasplante (criterios de Milán). **(ver Imagen 3.4C)** 1.06.1.024 | 4.01.1.024

Metástasis hepáticas: lesiones múltiples, hipoecogénicas; buscar el primario (colon, mama, pulmón, estómago). En el cáncer de colon, algunas metástasis hepáticas son resecables con intención curativa.

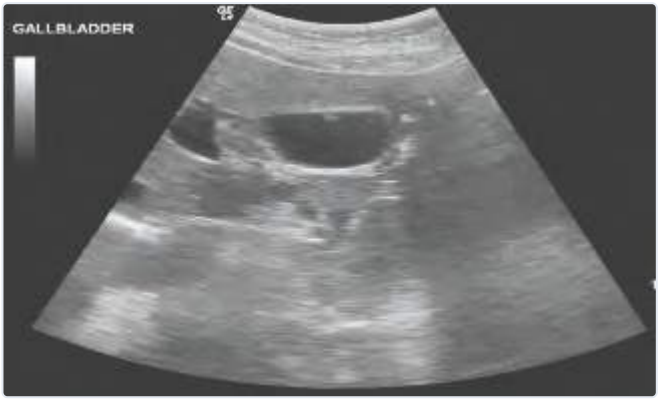


Metástasis hepáticas múltiples en TC

4. PÓLIPOS VESICULARES

Colesterolínicos (los más frecuentes): pequeños (< 10 mm), múltiples, homogéneos → seguimiento ecográfico.

Sospecha de pólipo neoplásico → colecistectomía: pólipo ≥ 10 mm, único, sésil o heterogéneo, de crecimiento rápido, en > 50 años o asociado a colelitiasis o a colangitis esclerosante primaria. Ante sospecha de cáncer de vesícula invasor, la cirugía es abierta (colecistectomía radical), no laparoscópica. 1.06.1.003 | 4.01.1.028



Pólipo vesicular en ecografía

5. BIOPSIA HEPÁTICA, CÁNCER DE VESÍCULA Y DE VÍAS BILIARES

Biopsia hepática (nivel: derivar): en una lesión focal se indica solo cuando la imagen no es concluyente (en un cirrótico con lesión típica de hepatocarcinoma no se biopsia). **Está contraindicada ante la sospecha de quiste hidatídico** (riesgo de diseminación y anafilaxia), de lesión vascular (hemangioma) o con coagulopatía no corregible; en ese caso se usa la vía transyugular. La realiza el especialista, guiada por ecografía o TAC. 1.08.5.003

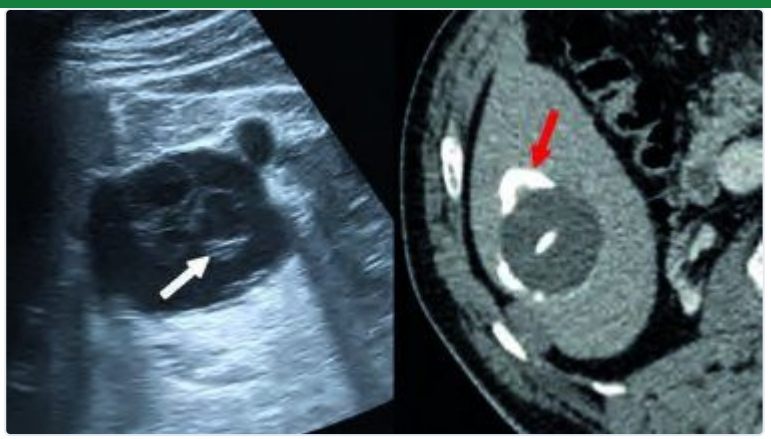
Cáncer de vesícula biliar (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): adenocarcinoma asociado a colelitiasis de larga data (cálculos grandes), vesícula en porcelana, pólipos > 1 cm y anomalías de la unión biliopancreática; Chile tiene una incidencia de las más altas del mundo, con predominio femenino. Es silente: dolor en el hipocondrio derecho, baja de peso, ictericia o masa indican enfermedad avanzada, y muchas veces es un **hallazgo en la pieza de la colecistectomía**. Si invade solo la mucosa (T1a) basta la colecistectomía; desde T1b se hace **colecistectomía radical** (resección hepática en cuña y linfadenecto- 1.06.1.003 | 4.01.1.028

mía). La colecistectomía preventiva en la colelitiasis sintomática de 35 a 49 años está garantizada por el GES.

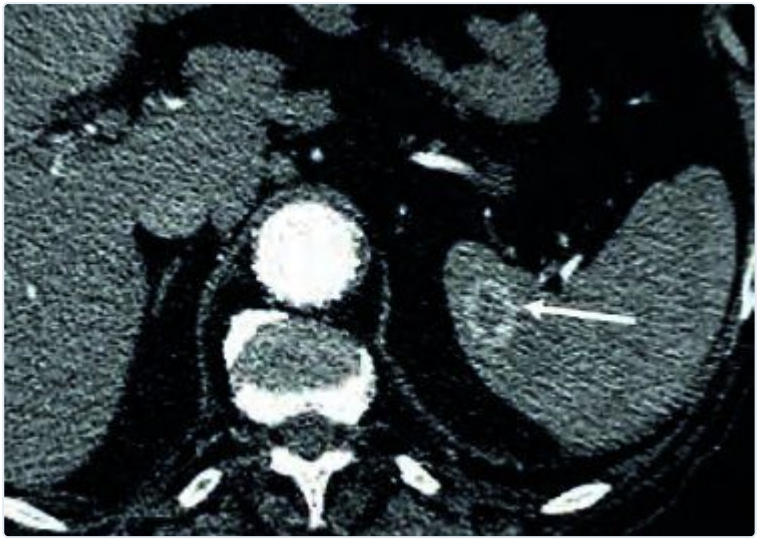
Cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma): se presenta como **ictericia progresiva indolora con prurito**. Es intrahepático, **hiliar** (tumor de Klatskin, el más frecuente; vesícula colapsada) o distal (vesícula palpable, como en el páncreas). Factores de riesgo: colangitis esclerosante primaria, quiste de colédoco y litiasis intrahepática. Estudio: ecografía, colangiorresonancia y CA 19-9; el tratamiento es la resección si es posible, y si no, drenaje biliar paliativo con prótesis.



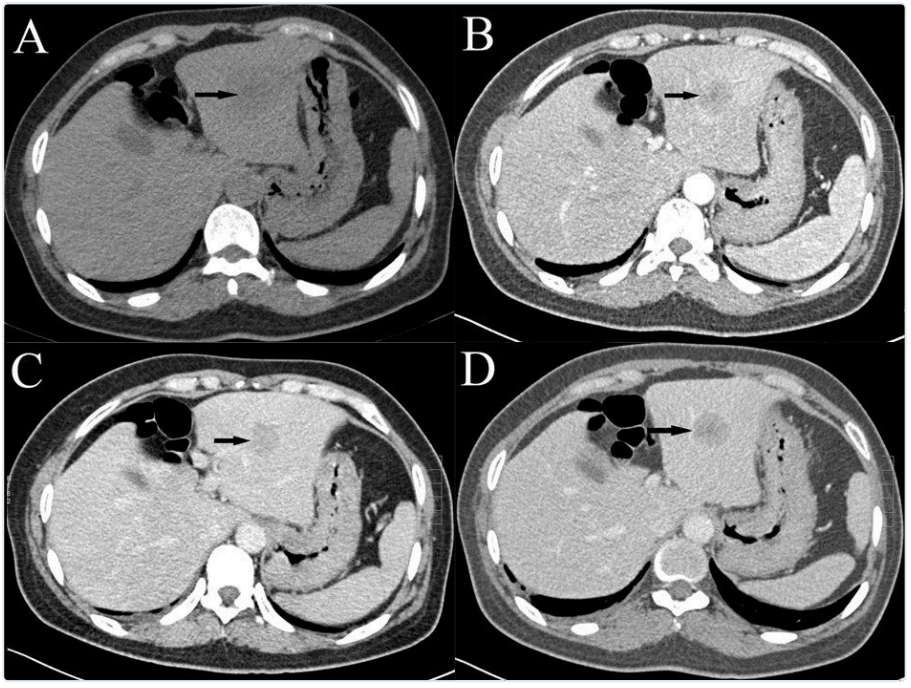
Colangiocarcinoma hiliar: estenosis en la colangiografía endoscópica



A. QUISTE HIDATÍDICO



B. HEMANGIOMA



C. HEPATOCARCINOMA

Imagen 3.4

TABLA 3.4 · LESIÓN HEPÁTICA EN LA ECOGRAFÍA — DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA

1.06.1.024, 4.01.1.023, 4.01.1.022, 1.06.1.003, 4.01.1.024, 4.01.1.028, 1.08.5.003

ASPECTO ECOGRÁFICO	DIAGNÓSTICO PROBABLE	CONDUCTA
Anecogénica, pared fina, sin tabiques	Quiste simple	Observar
Quística con membrana/tabiques (contexto rural)	Quiste hidatídico	Albendazol + cirugía
Hiperecogénica, homogénea	Hemangioma	Observar
Hipoecogénica única y homogénea, mujer con ACO	Adenoma hepático	Suspender estrógenos; resecar si > 5 cm o sintomático
Heterogénea irregular en cirrótico + AFP alta	Hepatocarcinoma	TAC/RM trifásico → resección/ablación/trasplante
Múltiples lesiones hipoecogénicas	Metástasis	Buscar el tumor primario

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.4

Mujer de 34 años, usuaria de anticonceptivos orales desde hace 8 años, se realiza una ecografía abdominal por dolor vago en el hipocondrio derecho. Se informa una lesión hepática sólida, hipoecogénica, homogénea, única, de 6 cm, en el lóbulo derecho. No tiene daño hepático crónico y la alfa-fetoproteína es normal.

Conducta oficial. Lesión sólida hipoecogénica, homogénea y única, en una mujer joven usuaria prolongada de anticonceptivos orales, sin cirrosis: el diagnóstico más probable es un adenoma hepático. Por su tamaño (> 5 cm) y el riesgo de hemorragia y de transformación maligna, la conducta es suspender los anticonceptivos orales y resecar la lesión. El hemangioma sería hiperecogénico y el hepatocarcinoma aparecería en un hígado dañado y con alfa-fetoproteína elevada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Anecogénica lisa = quiste simple (observar); hiperecogénica homogénea = hemangioma (observar).
- Hipoecogénica única y homogénea + anticonceptivos orales = adenoma → suspender estrógenos y resecar si > 5 cm.
- Heterogénea e irregular en un hígado cirrótico + AFP alta = hepatocarcinoma.
- Múltiples lesiones hipoecogénicas = metástasis → buscar el primario.
- Pólipo vesicular ≥ 10 mm, heterogéneo o con colelitiasis → colecistectomía; sospecha de cáncer invasor → cirugía abierta.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. En una ecografía abdominal solicitada por dispepsia se informa una lesión hepática de 3 cm, hiperecogénica, homogénea y de bordes bien definidos, en un paciente de 40 años sin antecedentes hepáticos ni baja de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A) Metástasis hepática; solicitar TAC de tórax-abdomen-pelvis
B) Hemangioma hepático; observación
C) Hepatocarcinoma; derivar para resección
D) Absceso hepático; iniciar antibióticos y drenaje
E) Quiste hidatídico; albendazol

Caso representativo · banco EUNACOM

2. En un paciente de 60 años, sin colelitiasis, se detecta en la ecografía un pólipo vesicular único, sésil, de 14 mm, que ha crecido 4 mm respecto de un control previo. ¿Cuál es la conducta?

A) Seguimiento ecográfico en 6 meses
B) Colecistectomía
C) Ácido ursodesoxicólico para disolver el pólipo
D) Biopsia percutánea del pólipo
E) Colangiorresonancia y control anual

Más preguntas online de Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico	Paso 1: ¿bilirrubina indirecta (Gilbert, hemólisis) o directa? Paso 2 en la directa...	**Síndrome de Gilbert: hiperbilirrubinemia indirecta con el resto de las pruebas...**	—
Hepatitis Aguda y Crónica	Hepatitis aguda: el riesgo es la fulminante (ictericia + encefalopatía); se vigila con...	**Hepatitis crónica: el riesgo es la cirrosis; se evalúa con biopsia o elastografía.**	HBsAg positivo indica infección activa por virus B; la IgM anti-HBc negativa descarta...
Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	Todo cirrótico con ascitis que consulta: paracentesis diagnóstica antes que nada...	**PBE: ≥ 250 PMN/mm³ → cefotaxima/ceftriaxona endovenosa + albúmina (días 1 y 3).**	Encefalopatía: tratar el precipitante (casi siempre infección) + lactulosa a 2–3...
Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares	Anecogénica lisa = quiste simple (observar); hiperecogénica homogénea = hemangioma...	**Hipoecogénica única y homogénea + anticonceptivos orales = adenoma → suspender...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Paso 1: ¿bilirrubina indirecta (Gilbert, hemólisis) o directa? Paso 2 en la directa: transaminasas (hepatitis) vs FA/GGT...

Síndrome de Gilbert: hiperbilirrubinemia indirecta con el resto de las pruebas hepáticas normales → observar.

Colestasia con dolor = patología biliar; con dolor y fiebre = colangitis; sin dolor en el adulto mayor = cáncer.

Cáncer de páncreas: 3 D (diabetes, depresión, dolor) + baja de peso + ictericia silente + Courvoisier-Terrier.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Síndrome de Gilbert: hiperbilirrubinemia indirecta con el resto de las pruebas hepáticas normales → observar.
- Colestasia con dolor = patología biliar; con dolor y fiebre = colangitis; sin dolor en el adulto mayor = cáncer.
- Hepatitis crónica: el riesgo es la cirrosis; se evalúa con biopsia o elastografía.
- HBsAg = "hay virus"; IgM anti-HBc = "es aguda"; HBsAg (+) con IgM anti-HBc (–) = hepatitis B crónica.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Paso 1: ¿bilirrubina indirecta (Gilbert, hemólisis) o directa? Paso 2 en la directa: transaminasas (hepatitis) vs... Tema 3.1 →

Hepatitis aguda: el riesgo es la fulminante (ictericia + encefalopatía); se vigila con el tiempo de protrombina. Tema 3.2 →

Todo cirrótico con ascitis que consulta: paracentesis diagnóstica antes que nada (descartar PBE). Tema 3.3 →

Anecogénica lisa = quiste simple (observar); hiperecogénica homogénea = hemangioma (observar). Tema 3.4 →

MANUAL EUNACOM DE GASTROENTEROLOGÍA

BLOQUE 04 DE 06 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
2 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 2 clases

VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

2	8	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

4.1	Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis	72
4.2	Pancreatitis Aguda	75

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 2 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.1.006, 1.06.2.004, 1.06.2.003, 1.06.4.004, 4.01.2.012, 1.06.4.015	Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis	Específico	Inicial	Derivar
1.06.2.010, 1.06.4.005, 4.01.1.029, 4.01.2.013, 4.01.3.001, 1.06.1.025	Pancreatitis Aguda	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
8 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Solo dolor = cólico biliar; + fiebre = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + fiebre + ictericia = colangitis (Charcot).
- Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso asintomática — riesgo de cáncer de vesícula en Chile.
- La colecistitis aguda es la única patología biliar de resolución quirúrgica urgente (colecistectomía < 72 h).
- Coledocolitiasis: eco → colangiorresonancia → CPRE. Directo a CPRE si hay colangitis o si la eco ve el cálculo.
- Colangitis: lo esencial es el drenaje biliar urgente por CPRE, junto con volumen y antibióticos.
- Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 2 TEMAS

Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis	EUNACOM Julio 2025 · #109 · EUNACOM Julio 2025 · #152 · EUNACOM Diciembre 2024 · #56 · EUNACOM Enero 2023 · #67
Pancreatitis Aguda	EUNACOM Julio 2025 · #100 · EUNACOM Julio 2025 · #5 · EUNACOM Julio 2025 · #140 · EUNACOM Julio 2024 · #138

4.1. Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.1.006 | 1.06.2.004 | 1.06.2.003 | 1.06.4.004 | 4.01.2.012 | 1.06.4.015

¿POR QUÉ?

Las cuatro patologías biliares se separan sumando síntomas. Solo dolor = cólico biliar. Dolor + fiebre = colecistitis. Dolor + ictericia = coledocolitiasis. Dolor + fiebre + ictericia = colangitis (tríada de Charcot). Eso define la urgencia: la única que se opera de urgencia es la colecistitis; la colangitis se drena de urgencia con CPRE. Y como Chile tiene la tasa de cáncer de vesícula más alta del mundo, toda colelitiasis termina en colecistectomía, aunque sea asintomática.

1. COLELITIASIS Y CÓLICO BILIAR

1.06.1.006

Cólico biliar: dolor sordo en el epigastrio/hipocondrio derecho de 30–60 min que cede solo, desencadenado por comidas grasas, con náuseas. La ecografía muestra los cálculos (imagen con sombra acústica). Manejo agudo: analgesia (dipirona) + antiespasmódico. **(ver Imagen 4.1B)**

Toda colelitiasis se opera con colecistectomía laparoscópica electiva, incluso la asintomática, por el riesgo de complicaciones y —en Chile— de cáncer de vesícula. El programa GES garantiza la colecistectomía entre los 35 y 49 años. **(ver Imagen 4.1A)**

2. COLECISTITIS AGUDA

1.06.2.004

Dolor persistente (> 6 h) en el hipocondrio derecho + fiebre + signo de Murphy + leucocitosis. Ecografía: cálculo enclavado, pared > 4 mm, líquido perivesicular, Murphy ecográfico.

Tratamiento: hospitalización, antibióticos, y **colecistectomía laparoscópica precoz (en las primeras 72 h)** — es la única patología biliar que se opera de urgencia. En el paciente de muy alto riesgo quirúrgico, colecistostomía percutánea transitoria.

3. COLEDOCOLITIASIS

1.06.1.006 | 1.06.4.004 | 1.06.4.015

Dolor + ictericia con patrón colestásico (FA y GGT altas), sin fiebre si no hay infección. Secuencia: ecografía (colédoco > 6–7 mm = sospecha; rara vez ve el cálculo) → colangiorresonancia (confirma) → CPRE (extrae el cálculo).

Se va directo a CPRE, sin colangiorresonancia, si hay colangitis o si la ecografía ya vio el cálculo en el colédoco. Después de la CPRE: colecistectomía laparoscópica electiva.

1.06.4.004 | 1.06.4.015

4. COLANGITIS AGUDA

1.06.2.003 | 4.01.2.012

Tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre. **Péntada de Reynolds** (forma grave): agrega hipotensión y compromiso de conciencia.

1.06.2.003 | 4.01.2.012 | 1.06.4.004

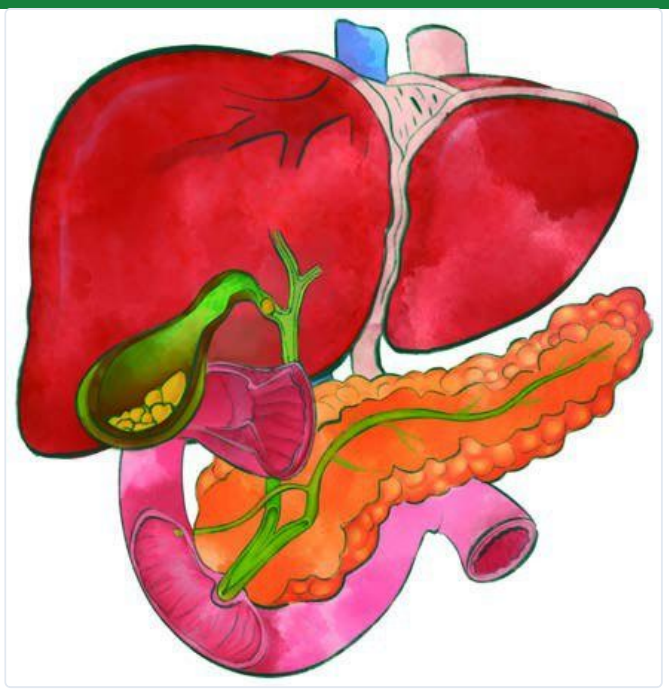
Tratamiento: reposición de volumen + antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol) + **drenaje biliar urgente por CPRE** (lo esencial). La colecistectomía se hace después, de forma electiva. Las colecistitis crónicas (vesícula en porcelana, escleroatrófica) se operan de forma electiva por el riesgo de cáncer. **(ver Imagen 4.1C)**



Cáncer de vesícula biliar / vesícula en porcelana



A. COLELITIASIS



B. VESÍCULA CON CÁLCULOS



C. COLECISTITIS

Imagen 4.1

TABLA 4.1 · PATOLOGÍA BILIAR — CLÍNICA, EXAMEN Y CIRUGÍA

1.06.1.006, 1.06.2.004, 1.06.2.003, 1.06.4.004, 4.01.2.012, 1.06.4.015

CUADRO	DOLOR + ...	CONDUCTA
Cólico biliar (colelitiasis sintomática)	solo dolor	Analgesia; colecistectomía electiva
Colecistitis aguda	dolor + fiebre + Murphy	Antibióticos + colecistectomía de urgencia (< 72 h)
Coledocolitiasis	dolor + ictericia	Eco → colangio-RM → CPRE → colecistectomía electiva
Colangitis aguda	dolor + ictericia + fiebre (Charcot)	Volumen + antibióticos + CPRE urgente
Vesícula en porcelana / escleroatrófica	hallazgo (riesgo de cáncer)	Colecistectomía electiva

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.1

Mujer de 48 años consulta por 8 horas de dolor intenso y continuo en el hipocondrio derecho, con fiebre de 38,5 °C y vómitos. Al examen tiene un signo de Murphy claramente positivo. Laboratorio: leucocitos 15.000/mm³, PCR elevada, bilirrubina normal. La ecografía muestra colelitiasis, pared vesicular de 6 mm y líquido perivesicular.

Conducta oficial. Dolor persistente en el hipocondrio derecho + fiebre + Murphy positivo + hallazgos ecográficos (pared engrosada, líquido perivesicular) configuran una colecistitis aguda. La bilirrubina normal la separa de la coledocolitiasis y la colangitis. Es la única patología biliar que se opera de urgencia: el tratamiento es hospitalización, antibióticos y colecistectomía laparoscópica precoz, idealmente en las primeras 72 horas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Solo dolor = cólico biliar; + fiebre = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + fiebre + ictericia = colangitis (Charcot).
- Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso asintomática — riesgo de cáncer de vesícula en Chile.
- La colecistitis aguda es la única patología biliar de resolución quirúrgica urgente (colecistectomía < 72 h).
- Coledocolitiasis: eco → colangiorresonancia → CPRE. Directo a CPRE si hay colangitis o si la eco ve el cálculo.
- Colangitis: lo esencial es el drenaje biliar urgente por CPRE, junto con volumen y antibióticos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 62 años consulta por dolor en el hipocondrio derecho, ictericia progresiva, fiebre de 39 °C con calofríos y, en las últimas horas, tendencia a la somnolencia y presión arterial de 90/50 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta prioritaria?

A) Colecistitis aguda; colecistectomía laparoscópica de urgencia
B) Colangitis aguda grave; reposición de volumen, antibióticos y CPRE urgente para drenaje
C) Coledocolitiasis; colangiorresonancia y luego CPRE electiva
D) Hepatitis aguda; manejo de soporte
E) Absceso hepático; antibióticos y drenaje percutáneo

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Mujer de 40 años, sin síntomas, a quien en una ecografía de rutina se le detecta una colelitiasis (múltiples cálculos, vesícula de pared normal). ¿Cuál es la conducta?

A) Observación; operar solo si aparecen síntomas
B) Ácido ursodesoxicólico para disolver los cálculos
C) Colecistectomía laparoscópica electiva
D) Dieta baja en grasas y control ecográfico anual
E) Colecistectomía solo si los cálculos superan los 2 cm

Más preguntas online de Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis →

4.2. Pancreatitis Aguda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.2.010 | 1.06.4.005 | 4.01.1.029 | 4.01.2.013 | 4.01.3.001 | 1.06.1.025

¿POR QUÉ?

La pancreatitis aguda es autodigestión: la activación intraacinar prematura del tripsinógeno desencadena una cascada de enzimas que digieren el propio páncreas y el retroperitoneo. Eso explica el dolor transfixiante, el íleo, la pérdida masiva de líquido al tercer espacio y por qué el pilar del tratamiento en las primeras 24 horas es la reposición agresiva de volumen — el paciente está perdiendo litros hacia el retroperitoneo aunque su piel esté seca.

1. DIAGNÓSTICO: 2 DE 3 CRITERIOS

1.06.2.010 4.01.2.013

El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere **2 de los siguientes 3** (criterios de Atlanta revisada 2012): (1) dolor abdominal compatible —epigástrico, intenso, transfixiante, irradiado en faja al dorso—; (2) **lipasa o amilasa > 3 veces el límite superior normal**; (3) hallazgos de pancreatitis en imagen (TAC con contraste, ecografía o resonancia). **(ver Imagen 4.2A y C)**

La **lipasa es más sensible y específica** que la amilasa y permanece elevada más días. La magnitud de la elevación enzimática **no** se correlaciona con la gravedad.

1.06.2.010 4.01.2.013 1.06.4.005

Si el paciente cumple los dos primeros criterios, **no se necesita TAC para el diagnóstico**. La TAC con contraste se indica a las 72 horas si hay duda diagnóstica o si el paciente evoluciona mal (para evaluar necrosis).

2. ETIOLOGÍA: BUSCAR SIEMPRE LA CAUSA

1.06.2.010 4.01.2.013

Las dos causas más frecuentes en Chile son la **litiasis biliar** (cálculo que obstruye la ampolla de Vater; más frecuente en mujeres, con elevación de transaminasas y de fosfatasas alcalinas) y el **alcohol** (varón, consumo intenso y sostenido).

Otras: hipertrigliceridemia (> 1000 mg/dL), post-CPRE, fármacos, hipercalcemia, autoinmune, trauma y tumores. A todo paciente se le solicita **ecografía abdominal** en las primeras 24–48 h para buscar colelitiasis y perfil lipídico y calcemia.

3. ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD

1.06.2.010 4.01.2.013

La clasificación de Atlanta revisada define pancreatitis **leve** (sin falla orgánica ni complicaciones locales), **moderadamente grave** (falla orgánica transitoria < 48 h o complicación local) y **grave** (falla orgánica persistente > 48 h).

Scores predictivos: **BISAP** (BUN > 25, alteración de conciencia, SIRS, edad > 60, derrame pleural) es el más simple; APACHE-II el más usado en UCI; los criterios de Ranson requieren 48 h. Un **hematocrito elevado y en ascenso, o un BUN que sube** a las 24 h, predicen necrosis y mala evolución.

4. MANEJO INICIAL (PRIMERAS 24–48 HORAS)

Reposición de volumen agresiva y precoz: cristaloides, de preferencia **Ringer lactato**, 5–10 mL/kg/h ajustando por diuresis (meta > 0,5 mL/kg/h), frecuencia cardíaca y hematocrito. Es la intervención que más impacta en la mortalidad. 1.06.2.010 4.01.2.013

Analgesia potente (opioides; la meperidina ya no se prefiere). **Régimen cero** inicial, con **realimentación oral precoz** (dentro de 24–72 h) apenas cede el dolor y el íleo, incluso en pancreatitis grave (nutrición enteral por sonda nasoyeyunal si no tolera vía oral). La nutrición parenteral se evita. 1.06.2.010 4.01.2.013 4.01.3.001

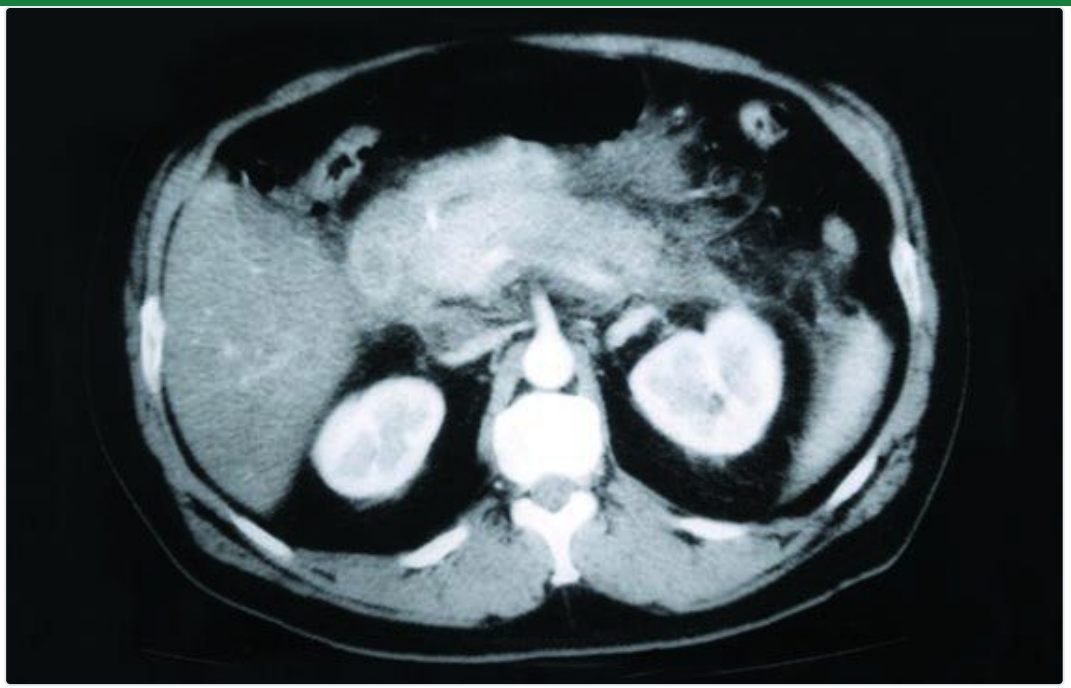
NO se indican antibióticos profilácticos en la pancreatitis aguda no infectada, ni siquiera en la necrótica estéril. Los antibióticos se reservan para la necrosis infectada demostrada o la colangitis concomitante. 1.06.2.010 4.01.2.013

Pancreatitis biliar: colecistectomía en el mismo ingreso una vez resuelto el episodio leve; **CPRE urgente (< 24 h)** solo si hay colangitis asociada u obstrucción biliar persistente.

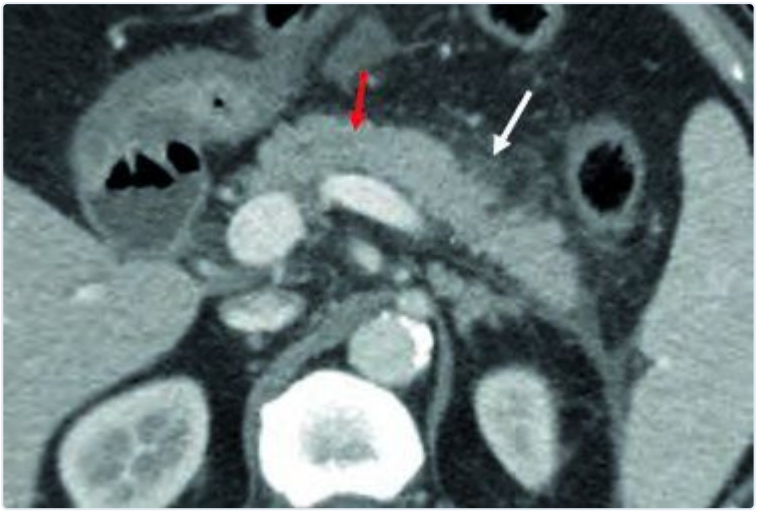
5. PANCREATITIS CRÓNICA

Concepto y causas (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): inflamación crónica con fibrosis y pérdida progresiva de la función exocrina y endocrina. La causa más frecuente es el **alcohol** (junto con el tabaco); otras: genética (PRSS1, CFTR), hipertrigliceridemia, hipercalcemia, obstrucción (estenosis, páncreas divisum) y autoinmune (IgG4). **Clínica:** dolor epigástrico crónico o en crisis, irradiado al dorso, que empeora con la comida; con los años aparecen **esteatorrea** y baja de peso (insuficiencia exocrina) y **diabetes**. Tríada clásica: calcificaciones pancreáticas + esteatorrea + diabetes. **(ver Imagen 4.2B)** 4.01.1.029 1.06.1.025

Diagnóstico y tratamiento inicial: la amilasa y la lipasa suelen ser normales. Se diagnostica por imágenes: **calcificaciones en la radiografía o la TAC** (casi patognomónicas), atrofia con conducto de Wirsung dilatado, y elastasa fecal baja. Tratamiento: **abstinencia de alcohol y tabaco**, dieta fraccionada con grasa moderada, **enzimas pancreáticas con cada comida**, vitaminas liposolubles y B_{12}, insulina si hay diabetes, y analgesia escalonada (paracetamol, luego tramadol u opioides). Si el dolor es refractario, hay estenosis del colédoco o seudoquiste sintomático, se deriva para endoscopía o cirugía. Tiene mayor riesgo de cáncer de páncreas, por lo que un cambio del dolor o baja de peso rápida obliga a re-estudiar.



A. PANCREATITIS EDEMATOSA



B. PÁNCREAS EDEMATOSO (TC)



C. GREY TURNER

Imagen 4.2

TABLA 4.2 · DOLOR EPIGÁSTRICO AGUDO — CÓMO SE SEPARA LA PANCREATITIS DE SUS IMITADORES

1.06.2.010, 1.06.4.005, 4.01.1.029, 4.01.2.013, 4.01.3.001, 1.06.1.025

DIAGNÓSTICO	CLAVE QUE LO DISTINGUE	EXAMEN QUE CONFIRMA
Pancreatitis aguda	Dolor transfixiante al dorso + lipasa > 3× · íleo	Lipasa/amilasa; TAC a las 72 h si evoluciona mal
Coledocolitiasis	Dolor + ictericia, sin fiebre · lipasa normal o poco elevada	Ecografía (colédoco > 7 mm) → colangio-RM
Colangitis aguda	Tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre	Ecografía + hemocultivos → CPRE
Úlcera perforada	Dolor brusco "en puñalada", abdomen en tabla	Radiografía de tórax de pie: neumoperitoneo
IAM de cara inferior	Factores de riesgo CV, síntomas vagales	ECG de 12 derivaciones + troponina
Isquemia mesentérica	Dolor desproporcionado al examen, FA, acidosis con lactato	Angio-TAC de abdomen

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.2

Hombre de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso de 12 horas irradiado al dorso, con vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando y doloroso a la palpación epigástrica sin signos peritoneales. Laboratorio: leucocitos 13.000/mm³, PCR 55 mg/L, lipasa 640 U/L (VN < 60), bilirrubina total 2,8 mg/dL de predominio directo, ecografía con colelitiasis y colédoco de 6 mm.

Conducta oficial. Cumple 2 de 3 criterios de Atlanta (dolor típico + lipasa > 3 veces el límite superior), por lo que el diagnóstico es pancreatitis aguda, de etiología biliar (colelitiasis, patrón colestásico leve). Aunque coexista una probable coledocolitiasis, "manda" la pancreatitis por ser la condición más grave. El manejo inicial es hospitalización, reposición agresiva con Ringer lactato ajustada a diuresis, analgesia, régimen cero con realimentación precoz y ecografía ya realizada; NO se inician antibióticos profilácticos. La CPRE urgente solo se justificaría si apareciera colangitis (fiebre alta, mayor ictericia, compromiso hemodinámico).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC.
- La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el hematocrito y el BUN en ascenso a las 24 h sí predicen necrosis.
- Pilar del tratamiento: reposición de volumen precoz y agresiva con Ringer lactato, ajustada a diuresis. Es lo que más reduce la mortalidad.
- Realimentación oral precoz (24–72 h) apenas cede el dolor, incluso en pancreatitis grave. Se evita la nutrición parenteral.
- NO antibióticos profilácticos en pancreatitis no infectada. CPRE urgente (< 24 h) solo si hay colangitis asociada.
- Pancreatitis biliar leve: colecistectomía en el mismo ingreso para prevenir la recurrencia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Reconstrucción EUNACOM 2013 · Pregunta #121

1. Hombre de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando y doloroso a la palpación epigástrica. Exámenes: escleras ictéricas leves, lipasa 190 U/L (VN < 60), bilirrubina total 3,1 mg/dL directa, ecografía con colédoco de 9 mm y microlitiasis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Colangitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Coledocolitiasis
D) Colecistitis aguda
E) Cólico biliar simple

Reconstrucción EUNACOM Julio 2016 · Pregunta #54

2. Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril, con dolor en disminución y tolera líquidos. Ecografía: colelitiasis, vía biliar de calibre normal, sin cálculos en el colédoco. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?

A) CPRE de urgencia en las próximas 24 horas
B) Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio
C) Alta con colecistectomía programada en 6 a 8 semanas
D) Colangiorresonancia y luego CPRE si es positiva
E) Manejo médico indefinido, sin cirugía, por el riesgo quirúrgico

Más preguntas online de Pancreatitis Aguda →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.2

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis	Solo dolor = cólico biliar; + fiebre = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; +...	**Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso...**	—
Pancreatitis Aguda	Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen...	**La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Solo dolor = cólico biliar; + fiebre = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + fiebre + ictericia = colangitis...

Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso asintomática — riesgo de cáncer de vesícula en...

La colecistitis aguda es la única patología biliar de resolución quirúrgica urgente (colecistectomía < 72 h).

Coledocolitiasis: eco → colangiorresonancia → CPRE. Directo a CPRE si hay colangitis o si la eco ve el cálculo.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso asintomática — riesgo de cáncer de vesícula en Chile.
- La colecistitis aguda es la única patología biliar de resolución quirúrgica urgente (colecistectomía < 72 h).
- La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el hematocrito y el BUN en ascenso a las 24 h sí predicen necrosis.
- Pilar del tratamiento: reposición de volumen precoz y agresiva con Ringer lactato, ajustada a diuresis. Es lo que más reduce la mortalidad.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Solo dolor = cólico biliar; + fiebre = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + fiebre + ictericia =... Tema 4.1 →

Diagnóstico = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > 3× el límite superior + imagen compatible. Con los dos... Tema 4.2 →

MANUAL EUNACOM DE GASTROENTEROLOGÍA

BLOQUE 05 DE 06 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

4	13	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

5.1	Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis	82
5.2	Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular	85
5.3	Hemorragia Digestiva Alta y Baja	88
5.4	Cuerpo Extraño Digestivo	92

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.06.2.001, 4.01.2.006, 1.06.1.016	Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.007, 1.06.2.001, 1.07.2.001	Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular	Sospecha	Inicial	Derivar
1.06.2.007, 1.06.4.007, 4.01.1.009, 4.01.2.004, 2.01.1.043, 2.01.2.010	Hemorragia Digestiva Alta y Baja	Específico	Inicial	Derivar
6.03.2.008, 1.06.2.002	Cuerpo Extraño Digestivo	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 05 · ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
13 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Apendicitis: dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha + anorexia; diagnóstico clínico → apendicectomía.
- Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: primero test de embarazo y evaluación ginecológica.
- Plastrón apendicular (masa en FID): antibióticos primero y apendicectomía diferida; no es lo mismo que la apendicitis perforada.
- **! TRAMPA** · Diverticulitis: TAC de abdomen y pelvis; la colonoscopía está contraindicada en el episodio agudo.
- Hinchey I–II (absceso) → antibióticos ± drenaje; Hinchey III–IV (peritonitis) → operación de Hartmann.
- Fístula colovesical (complicación de la diverticulitis): neumaturia e infecciones urinarias recurrentes.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis	EUNACOM Diciembre 2025 · #18 · EUNACOM Diciembre 2025 · #110 · EUNACOM Diciembre 2025 · #144 · EUNACOM Diciembre 2022 · #62
Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular	EUNACOM Diciembre 2025 · #18 · EUNACOM Diciembre 2022 · #15 · EUNACOM Julio 2017 · #96 · EUNACOM Julio 2013 · #100
Hemorragia Digestiva Alta y Baja	EUNACOM Diciembre 2025 · #165 · EUNACOM Julio 2024 · #36 · EUNACOM Enero 2023 · #75 · EUNACOM Enero 2023 · #74
Cuerpo Extraño Digestivo	EUNACOM Diciembre 2024 · #50

5.1. Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.2.001 4.01.2.006 1.06.1.016

¿POR QUÉ?

Dos cuadros casi simétricos. La apendicitis es el joven con dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha, con anorexia: es diagnóstico clínico y va a pabellón. La diverticulitis es "la apendicitis del lado izquierdo" del mayor de 50, se estudia con TAC (la colonoscopía está prohibida en agudo) y se clasifica por Hinchey, que decide antibióticos vs drenaje vs cirugía de Hartmann. Y en toda mujer joven con dolor en fosa ilíaca derecha, lo primero es descartar embarazo.

1. ABDOMEN AGUDO: PRINCIPIOS

1.06.2.001

El abdomen agudo es un diagnóstico clínico: no todos son quirúrgicos ni todos llevan antibióticos. Signos peritoneales: resistencia muscular, Blumberg (dolor al descomprimir), abdomen en tabla, ausencia de ruidos. **(ver Imagen 5.1C)**

En toda **mujer en edad fértil** con dolor abdominal bajo, la primera conducta es **test de embarazo y evaluación ginecológica** (embarazo ectópico, proceso inflamatorio pelviano, quiste ovárico complicado).

2. APENDICITIS AGUDA

4.01.2.006

Dolor periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha en 12–24 h, con anorexia, náuseas y febrícula. Signos: McBurney, Rovsing, psoas (apéndice retrocecal), obturador (apéndice pélvico). **(ver Imagen 5.1A)**

Diagnóstico clínico (apoyado por leucocitosis y PCR); ecografía en niños y mujeres en edad fértil; TAC si hay duda en el adulto. Tratamiento: apendicectomía (laparoscópica). La apendicitis perforada se opera de urgencia con lavado y antibióticos. **(ver Imagen 5.1B)**

3. PLASTRÓN APENDICULAR

4.01.2.006

Masa palpable en la fosa ilíaca derecha con varios días de evolución: el epiplón ha "tapado" el apéndice inflamado, conteniendo el proceso.

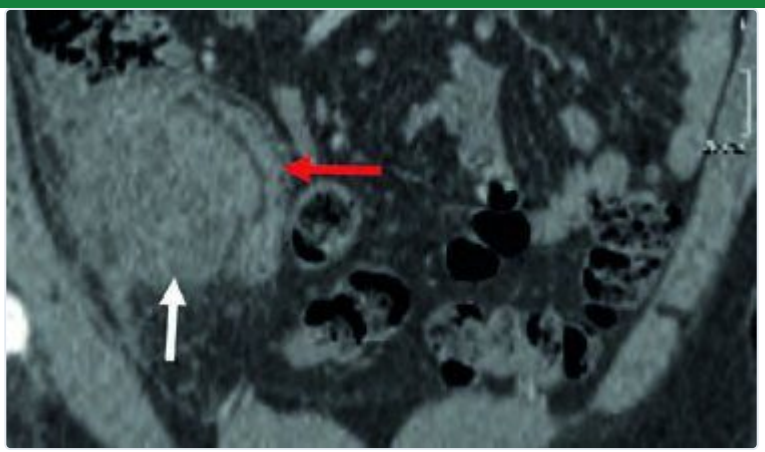
Conducta: primero antibióticos (ceftriaxona + metronidazol) por varias semanas → apendicectomía diferida (o de intervalo) a las 6–8 semanas. No es lo mismo que la apendicitis perforada (peritonitis difusa), que sí va a cirugía inmediata.

4. DIVERTICULITIS AGUDA

1.06.1.016

Dolor en la fosa ilíaca izquierda + fiebre + cambio del hábito, en un > 50 años ("apendicitis izquierda"). Diagnóstico: TAC de abdomen y pelvis con contraste (engrosamiento del sigmoides, estrías de la grasa, absceso). La **colonoscopía está contraindicada en el episodio agudo** (riesgo de perforación); se hace a las 6–8 semanas para descartar cáncer.

Clasificación de Hinchey: I–II (absceso) → antibióticos ± drenaje percutáneo; III (peritonitis purulenta) y IV (peritonitis fecal) → cirugía de urgencia (operación de Hartmann). Fístula colovesical → neumaturia e infecciones urinarias recurrentes.



A. MCBURNEY, ROVSING Y OTROS

B. APENDICITIS EN TC



C. PIEZA OPERATORIA

Imagen 5.1

TABLA 5.1 · DIVERTICULITIS AGUDA — CLASIFICACIÓN DE HINCHEY Y CONDUCTA 1.06.2.001, 4.01.2.006, 1.06.1.016

HINCHEY	HALLAZGO EN EL TAC	TRATAMIENTO
I	Absceso pericólico pequeño	Antibióticos (± manejo ambulatorio en casos leves)
II	Absceso pélvico o a distancia	Antibióticos + drenaje percutáneo guiado por TAC
III	Peritonitis purulenta generalizada	Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
IV	Peritonitis fecal (perforación libre)	Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
Post-episodio (6–8 sem)	—	Colonoscopía para descartar cáncer

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.1

Hombre de 58 años consulta por 2 días de dolor en la fosa ilíaca izquierda, fiebre de 38,3 °C y deposiciones más frecuentes. Al examen tiene dolor y defensa localizada en la fosa ilíaca izquierda, sin signos peritoneales generalizados. El TAC de abdomen muestra engrosamiento del sigmoides con estrías de la grasa pericólica y una colección de 2 cm adyacente.

Conducta oficial. Diverticulitis aguda con un absceso pericólico pequeño, sin peritonitis generalizada: corresponde a un Hinchey I. El tratamiento es antibióticos (ceftriaxona + metronidazol, endovenosos u orales según la gravedad) y reposo intestinal; el drenaje percutáneo se reserva para los abscesos mayores o a distancia (Hinchey II), y la cirugía urgente (operación de Hartmann) para la peritonitis (Hinchey III–IV). La colonoscopía está contraindicada ahora y se programa a las 6–8 semanas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Apendicitis: dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha + anorexia; diagnóstico clínico → apendicectomía.
- Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: primero test de embarazo y evaluación ginecológica.
- Plastrón apendicular (masa en FID): antibióticos primero y apendicectomía diferida; no es lo mismo que la apendicitis perforada.
- Diverticulitis: TAC de abdomen y pelvis; la colonoscopía está contraindicada en el episodio agudo.
- Hinchey I–II (absceso) → antibióticos ± drenaje; Hinchey III–IV (peritonitis) → operación de Hartmann.
- Fístula colovesical (complicación de la diverticulitis): neumaturia e infecciones urinarias recurrentes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Mujer de 24 años consulta por dolor que comenzó alrededor del ombligo y en 12 horas se localizó en la fosa ilíaca derecha, con náuseas y falta de apetito. Al examen tiene Blumberg positivo en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la primera conducta?

A) Apendicectomía laparoscópica inmediata
B) Test de embarazo y evaluación ginecológica
C) TAC de abdomen y pelvis con contraste
D) Iniciar antibióticos empíricos y observar 24 horas
E) Colonoscopía urgente

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Mujer de 63 años con diverticulitis aguda. El TAC muestra abundante líquido y aire libre intraperitoneal, con signos de peritonitis fecal difusa. Está febril, taquicárdica e hipotensa. ¿Cuál es la conducta?

A) Antibióticos endovenosos y reevaluar en 48 horas
B) Drenaje percutáneo guiado por TAC
C) Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
D) Colonoscopía para localizar la perforación
E) Resección sigmoidea laparoscópica con anastomosis primaria diferida

Más preguntas online de Abdomen Agudo →

5.2. Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 4.01.2.007 1.06.2.001 1.07.2.001

¿POR QUÉ?

La frase que resuelve la pregunta es "dolor intensísimo con un abdomen que casi no duele al palparlo". Esa disociación entre lo que el paciente refiere y lo que el examinador encuentra, en alguien con fibrilación auricular, es una embolia de la arteria mesentérica superior hasta que se demuestre lo contrario, y hay que anticoagular ante la sola sospecha. La ventana para salvar el intestino es de horas.

1. EMBOLIA DE LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR

Contexto: fibrilación auricular (u otra fuente cardioembólica). Dolor abdominal de inicio súbito e intensísimo con **disociación clínica**: el abdomen se palpa blando, sin defensa ni Blumberg, en las primeras horas. Puede haber vómitos y diarrea al inicio; luego hematoquecia y, tardíamente, peritonitis por necrosis. 4.01.2.007 1.06.2.001

Diagnóstico: angio-TAC (o angiografía, que además puede ser terapéutica). Tratamiento: **anticoagulación con heparina ante la sospecha** + revascularización (embolectomía o trombólisis) + resección del intestino necrótico. 4.01.2.007



Angio-TAC con defecto de llene

2. TROMBOSIS VENOSA MESENTÉRICA

Contexto: estados de hipercoagulabilidad, cirrosis, cirugía abdominal reciente. Dolor subagudo (días), con signos peritoneales más precoces que en la embolia. 4.01.2.007

Diagnóstico: TAC con contraste (visualiza el trombo en la vena mesentérica). Tratamiento: anticoagulación (es, en esencia, una trombosis venosa); cirugía solo si hay necrosis o perforación.

3. COLITIS ISQUÉMICA

La forma más frecuente de isquemia intestinal. Afecta las "zonas frontera" del colon (ángulo esplénico, unión rectosigmoidea). Clínica: dolor cólico en el hemiabdomen izquierdo + hematoquecia, en un adulto mayor con ateroesclerosis o tras un episodio de hipotensión. **(ver Imagen 5.2)** 4.01.2.007



Colitis isquémica

Diagnóstico: TAC de abdomen (engrosamiento segmentario del colon); la colonoscopía confirma en casos seleccionados. La mayoría es transitoria y se resuelve con manejo médico (reposo intestinal, hidratación, antibióticos); cirugía solo si hay necrosis, perforación o estenosis.

4. MANEJO COMÚN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

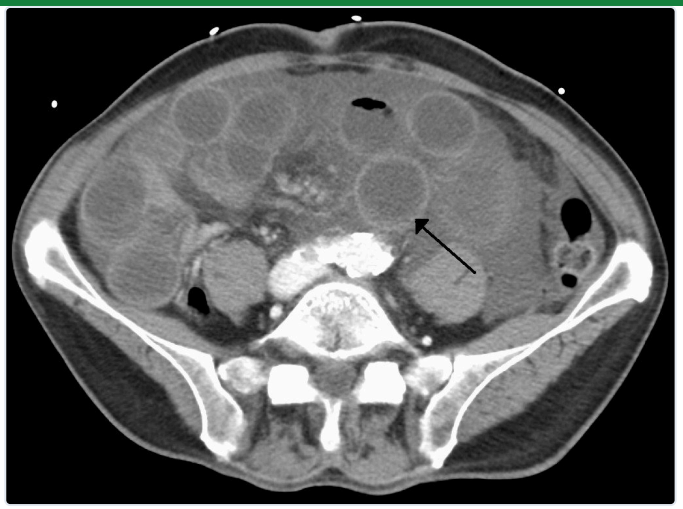
Las tres comparten: hidratación endovenosa, antibióticos (ceftriaxona + metronidazol) por el riesgo de translocación bacteriana, corrección de la causa y cirugía solo si hay necrosis o perforación. 4.01.2.007

Diferenciales del dolor abdominal desproporcionado: pancreatitis (lipasa), aneurisma aórtico roto (masa pulsátil, hipotensión, TAC), cetoacidosis diabética, porfiria. 1.06.2.001

5. ABDOMEN AGUDO EN EL ADULTO MAYOR

Por qué es distinto (nivel: diagnóstico específico, tratamiento inicial, derivar): en el adulto mayor el abdomen agudo se presenta de manera **atípica y tardía**: el dolor es menos intenso y mal localizado, a menudo sin fiebre ni leucocitosis y con defensa muscular escasa; puede debutar como **delirium**, caída o deterioro funcional. Los corticoides, los AINE y la diabetes enmascaran los signos. Por eso la mortalidad es varias veces mayor que en el joven y se retrasa el diagnóstico. 1.07.2.001

Causas más frecuentes y conducta: colecistitis y colangitis, obstrucción intestinal (bridas, hernias, cáncer de colon, vólvulo), diverticulitis, apendicitis (frecuentemente ya perforada), úlcera perforada e **isquemia mesentérica** (fibrilación auricular, ateroesclerosis), además de causas extradigestivas (infarto inferior, aneurisma aórtico). Conducta: ABC, hidratación, analgesia, exámenes (hemograma, lactato, lipasa, ECG) y **TAC de abdomen precoz** con alto umbral para operar; ante peritonitis o sospecha de isquemia, cirugía sin esperar.



ISQUEMIA INTESTINAL

Imagen 5.2

TABLA 5.2 · ABDOMEN AGUDO VASCULAR — LAS TRES ENTIDADES 4.01.2.007, 1.06.2.001, 1.07.2.001

ENTIDAD	INICIO / SIGNOS PERITONEALES	CONTEXTO	EXAMEN
Embolia mesentérica	Súbito / ausentes al inicio (disociación)	Fibrilación auricular	Angio-TAC / angiografía
Trombosis venosa mesentérica	Subagudo (días) / precoces	Hipercoagulabilidad, cirrosis	TAC con contraste
Colitis isquémica	Variable / según necrosis	Ateroesclerosis, hipotensión previa	TAC de abdomen

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Mujer de 76 años con fibrilación auricular no anticoagulada consulta por dolor abdominal de inicio brusco hace 4 horas, de intensidad 10/10, difuso, con dos vómitos y una deposición diarreica. Al examen el abdomen está blando, depresible, levemente sensible de forma difusa, sin defensa ni signo de Blumberg. Está taquicárdica y con lactato elevado.

Conducta oficial. Dolor abdominal súbito e intensísimo con un examen abdominal casi normal (disociación clínica), en una paciente con fibrilación auricular no anticoagulada y lactato elevado: es una embolia de la arteria mesentérica superior hasta que se demuestre lo contrario. La conducta es anticoagular con heparina de inmediato ante la sospecha, confirmar con angio-TAC y revascularizar; si hay signos de necrosis, laparotomía con resección del segmento comprometido. La ventana terapéutica es de horas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Embolia mesentérica: fibrilación auricular + dolor súbito e intensísimo + abdomen sin signos peritoneales (disociación clínica).
- Ante la sospecha de embolia mesentérica se anticoagula con heparina de inmediato; el examen es la angio-TAC/angiografía.
- Trombosis venosa mesentérica: dolor subagudo con signos peritoneales, en hipercoagulables → TAC con contraste + anticoagulación.
- Colitis isquémica: dolor en el hemiabdomen izquierdo + hematoquecia en el adulto mayor; suele resolver con manejo médico.
- Las tres: hidratación + antibióticos; cirugía solo si hay necrosis o perforación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 70 años con antecedente de ateroesclerosis, tras un episodio de hipotensión por una hemorragia digestiva, presenta dolor cólico en el flanco izquierdo y elimina deposiciones con sangre roja. El abdomen está sensible en el flanco izquierdo, sin peritonismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embolia de la arteria mesentérica superior
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Colitis isquémica
D) Diverticulitis aguda
E) Enfermedad de Crohn

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Paciente de 72 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito y muy intenso. El examen abdominal es prácticamente normal, sin defensa ni Blumberg. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?

A) TAC de abdomen sin contraste
B) Ecografía abdominal
C) Angio-TAC (o angiografía) mesentérica
D) Radiografía de abdomen simple
E) Colonoscopía urgente

Más preguntas online de Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular →

5.3. Hemorragia Digestiva Alta y Baja

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.06.2.007 | 1.06.4.007 | 4.01.1.009 | 4.01.2.004 | 2.01.1.043 | 2.01.2.010

¿POR QUÉ?

Dos errores anulan la respuesta. El primero: esperar el hematocrito para decidir. Al inicio de un sangrado agudo el hematocrito es normal, porque se pierde sangre completa; la gravedad la marca la hemodinamia (taquicardia → ortostatismo → hipotensión). El segundo: olvidar que el 10 % de las hemorragias que parecen bajas son en realidad altas con tránsito rápido, así que si la colonoscopía urgente no encuentra la causa, el siguiente paso es una endoscopía alta.

1. DEFINICIONES Y CLÍNICA

La hemorragia digestiva alta se origina proximal al ángulo de Treitz (esófago, estómago, duodeno): hematemesis y melena (deposición negra, alquitranada; requiere ≥ 8 h de tránsito). La hemorragia digestiva baja es distal al Treitz: hematoquecia y rectorragia. **(ver Imagen 5.3C)** 1.06.2.007 | 4.01.2.004 | 2.01.1.043 | 2.01.2.010

La hematoquecia puede aparecer también en una HDA masiva con tránsito acelerado. 1.06.2.007

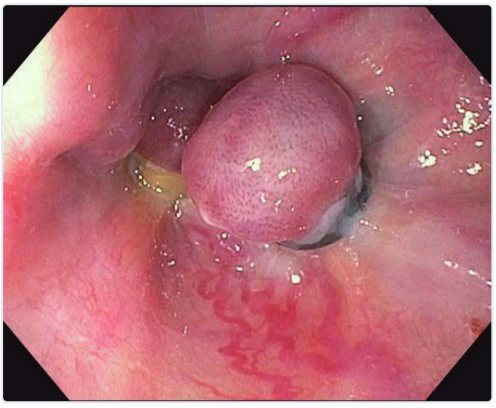
2. GRAVEDAD Y MANEJO INICIAL (COMÚN A ALTA Y BAJA)

La gravedad se mide por el **compromiso hemodinámico, no por el hematocrito** (que al inicio es normal): taquicardia (lo más precoz) → ortostatismo → hipotensión (shock). 1.06.2.007 | 4.01.2.004 | 2.01.1.043 | 2.01.2.010

Manejo: dos vías venosas gruesas + cristaloides (suero fisiológico o Ringer). La transfusión no es la reanimación inicial: se reserva para la anemia persistente tras la reposición o el sangrado masivo. Una vez estabilizado → endoscopía / colonoscopía diagnóstica y terapéutica. **(ver Imagen 5.3B)** 1.06.2.007 | 1.06.4.007 | 4.01.2.004 | 2.01.1.043 | 2.01.2.010

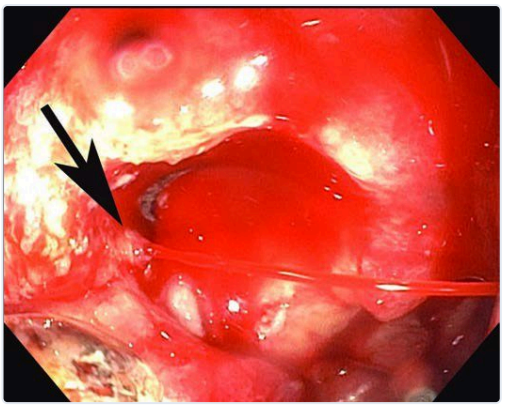
3. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: CAUSAS

Várices esofágicas: cirrótico, hemorragia masiva; agregar terlipresina + antibióticos (profilaxis de PBE) + tiamina si es alcohólico; ligadura endoscópica. **(ver Imagen 5.3A)** 1.06.2.007 | 4.01.2.004



Várices esofágicas en endoscopía y ligadura con bandas

Úlcera gastroduodenal: síndrome ulceroso previo, melena; agregar IBP endovenoso en dosis alta + terapia endoscópica (según la clasificación de Forrest); erradicar H. pylori. Mallory-Weiss: vómitos alimentarios → luego hematemesis; suele ser autolimitado y de buen pronóstico. 1.06.2.007 | 1.06.4.007 | 4.01.2.004



Desgarro de Mallory-Weiss en la unión gastroesofágica

4. HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA: CAUSAS Y ALGORITMO

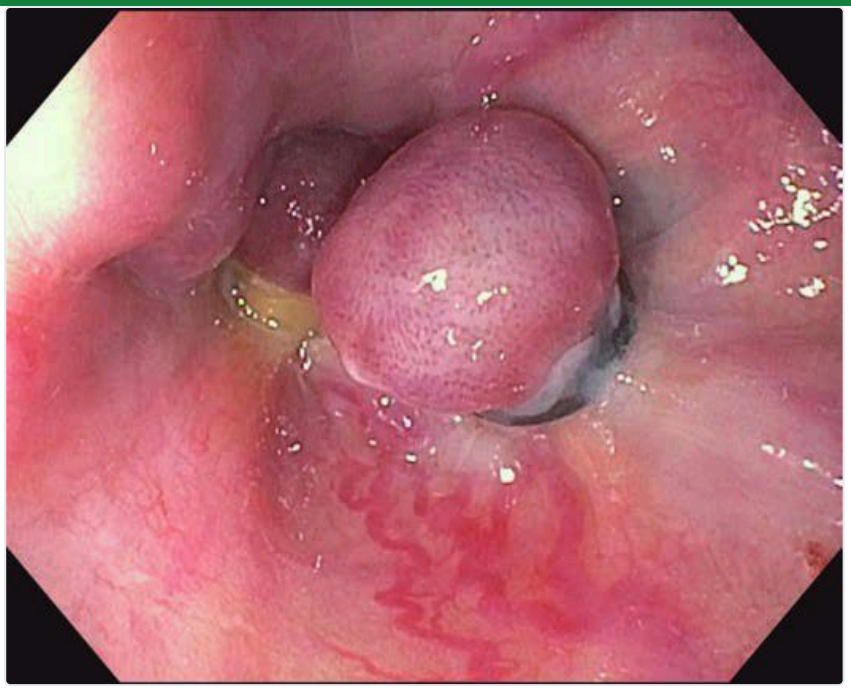
Causas: enfermedad diverticular (la causa más frecuente de HDB masiva), angiodisplasias (adulto mayor), cáncer de colon, hemorroides internas; divertículo de Meckel en el niño. 1.06.2.007 | 2.01.1.043 | 2.01.2.010

No masiva (estable): preparación de colon → colonoscopía en 24 h. **Masiva (inestable):** colonoscopía urgente → si no localiza, endoscopía digestiva alta ("regla del 10 %") → angio-TAC/angiografía (puede embolizar) → cintigrafía con glóbulos rojos marcados para sangrados lentos → cirugía (habitualmente hemicolectomía derecha) si todo falla y el paciente sigue inestable. 1.06.2.007 | 1.06.4.007

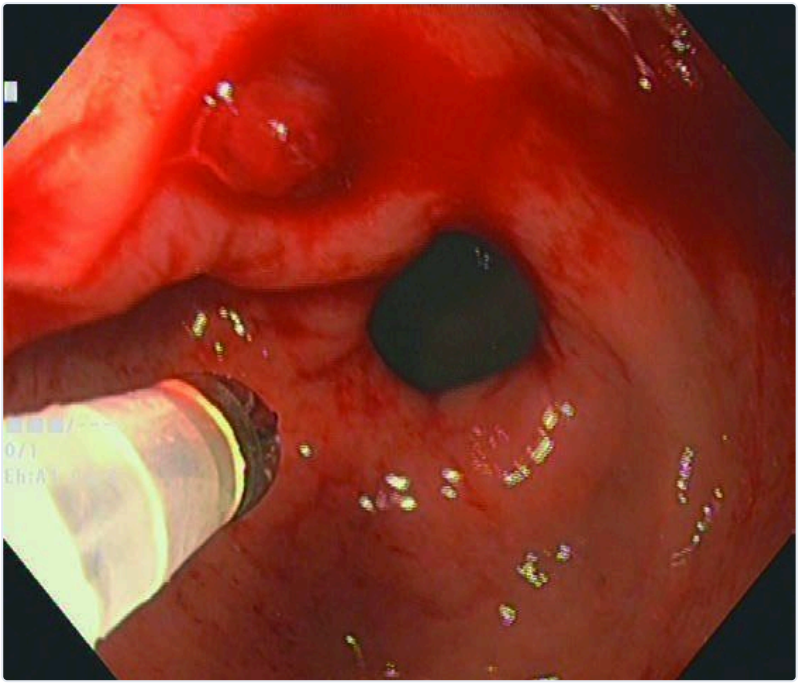
5. TUMORES DEL INTESTINO DELGADO

Tumores del intestino delgado (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): son raros (menos del 5 % de los tumores digestivos) y de diagnóstico tardío. Los principales: **adenocarcinoma** (más en Crohn, celiaquía y poliposis), **tumor neuroendocrino o carcinoide** (el más frecuente en el íleon; sus metástasis hepáticas dan el síndrome carcinoide con rubor, diarrea y broncoespasmo; se mide el ácido 5-hidroxiindolacético urinario), **linfoma** (celiaquía refractaria) y **GIST**. Se presentan como anemia, hemorragia digestiva baja oculta o recurrente, dolor cólico u obstrucción intestinal. 4.01.1.009

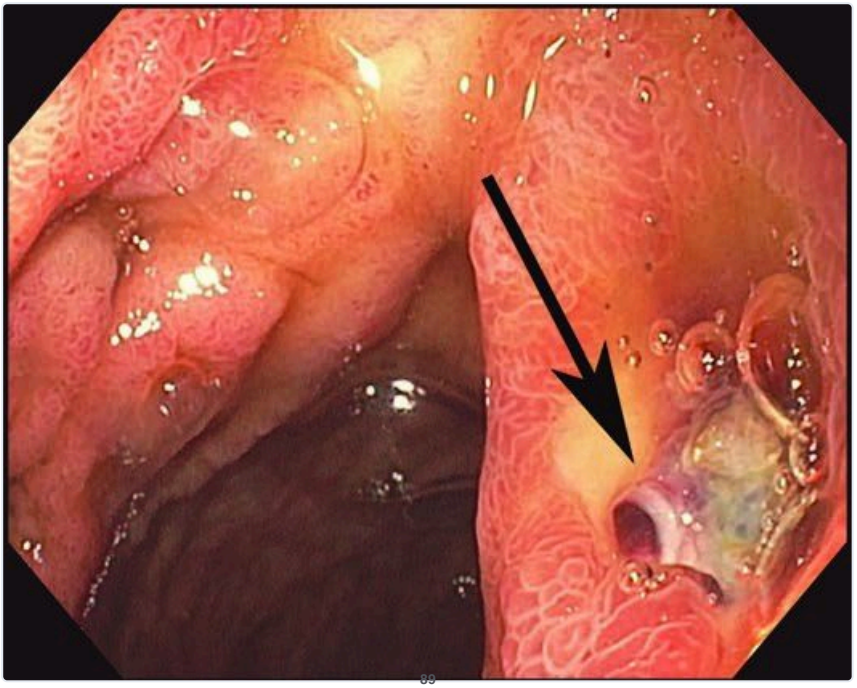
Estudio y conducta: cuando la endoscopía alta y la colonoscopía son normales en una hemorragia oscura se estudia el delgado con **cápsula endoscópica**, enteroscopía, enteroTAC o enteroRM. El tratamiento es la resección quirúrgica con linfadenectomía; los tumores neuroendocrinos metastásicos se manejan con análogos de somatostatina, y el GIST con imatinib. El médico general sospecha ante una anemia ferropénica o hemorragia sin causa y deriva.



A. VÁRICE CON LIGADURA



B. SANGRADO ACTIVO



C. VASO VISIBLE

Imagen 5.3

TABLA 5.3 · HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA — CAUSA Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO

1.06.2.007, 1.06.4.007, 4.01.1.009, 4.01.2.004, 2.01.1.043, 2.01.2.010

CAUSA	PISTA CLÍNICA	ADEMÁS DEL SUERO Y LA ENDOSCOPÍA
Várices esofágicas	Cirrótico, sangrado masivo, protrombina baja	Terlipresina + antibióticos + tiamina
Úlcera gastroduodenal	Síndrome ulceroso previo, melena	IBP endovenoso en dosis alta; erradicar H. pylori
Mallory-Weiss	Vómitos alimentarios y luego hematemesis	Suele ser autolimitado; observar si está estable
Lesión de Dieulafoy / angiodisplasia	Sangrado recurrente sin lesión evidente	Hemostasia endoscópica

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.3

Hombre de 55 años con cirrosis por alcohol llega por vómito de abundante sangre roja. Está pálido y sudoroso, con frecuencia cardíaca de 120/min y presión arterial de 85/50 mmHg. El hematocrito informado es de 38 %.

Conducta oficial. Hemorragia digestiva alta con compromiso hemodinámico (taquicardia e hipotensión) en un cirrótico: lo más probable es una hemorragia variceal. La gravedad la define la hemodinamia, no el hematocrito, que al inicio puede estar normal porque se pierde sangre completa. La conducta es reanimación con dos vías gruesas y cristaloides, terlipresina endovenosa, antibióticos (profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea), tiamina y endoscopía digestiva alta con ligadura en las primeras 12 horas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La gravedad de una hemorragia digestiva se mide por la hemodinamia (taquicardia → ortostatismo → hipotensión), no por el hematocrito.
- Reanimación inicial: dos vías gruesas + cristaloides. La transfusión no es el primer paso.
- Várices: terlipresina + antibióticos + tiamina + ligadura. Úlcera: IBP endovenoso + terapia endoscópica.
- Mallory-Weiss (vómitos y luego hematemesis): buen pronóstico, suele ser autolimitado.
- HDB masiva que no se localiza en la colonoscopía → endoscopía digestiva alta (10 % son en realidad altas).
- Causa más frecuente de HDB masiva: enfermedad diverticular. En el niño, divertículo de Meckel.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Al momento de la presentación de una hemorragia digestiva alta, ¿cuál de los siguientes parámetros determina mejor la gravedad del cuadro?

A) El hematocrito
B) La hemoglobina
C) La frecuencia cardíaca y la presión arterial
D) El volumen estimado de la hematemesis
E) El recuento de plaquetas

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Paciente de 68 años con hemorragia digestiva baja masiva e inestabilidad hemodinámica. Se realiza una colonoscopía urgente que, por la abundante sangre, no logra identificar el sitio del sangrado. ¿Cuál es el siguiente paso?

A) Repetir la colonoscopía tras una nueva preparación
B) Endoscopía digestiva alta
C) TAC de abdomen sin contraste
D) Laparotomía exploradora inmediata
E) Alta con control ambulatorio en 48 horas

Más preguntas online de Hemorragia Digestiva Alta y Baja →

5.4. Cuerpo Extraño Digestivo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.03.2.008 1.06.2.002

¿POR QUÉ?

La regla es sencilla. En el esófago se retira siempre por endoscopía (riesgo de perforación y mediastinitis). Pasado el esófago, se puede observar si es un objeto romo y pequeño y el niño está bien, con radiografías cada dos semanas. Pero hay una lista que se saca siempre esté donde esté: pilas de botón, dos o más imanes, objetos afilados o mayores de 5 cm, y las bolitas absorbentes. El dolor torácico con un cuerpo extraño esofágico es perforación hasta que se demuestre lo contrario.

1. EVALUACIÓN INICIAL

Ante la sospecha de ingesta de un cuerpo extraño: radiografía de cuello, tórax y abdomen para localizarlo (los objetos radiolúcidos, como el plástico o las espinas de pescado, pueden no verse). 6.03.2.008

Síntomas de alarma con cuerpo extraño esofágico: sialorrea (no logra tragar la saliva), odinofagia y, sobre todo, **dolor torácico** → sospechar perforación y mediastinitis.

2. CUERPO EXTRAÑO EN EL ESÓFAGO

Se retira siempre por endoscopía digestiva alta, de forma urgente si hay obstrucción completa (sialorrea, no traga saliva), si es una pila o un objeto afilado, o si lleva > 24 h impactado. **(ver Imagen 5.4C)** 6.03.2.008

Una **pila de botón** en el esófago es una emergencia: genera quemadura eléctrica y necrosis en pocas horas → extracción inmediata. **(ver Imagen 5.4A y B)**

3. CUERPO EXTRAÑO MÁS ALLÁ DEL ESÓFAGO

Objeto romo, pequeño, paciente asintomático: se observa con control radiológico cada 1–2 semanas hasta que se elimine (no hay que buscarlo en las deposiciones). 6.03.2.008

Se retira siempre, esté donde esté: pilas, ≥ 2 imanes (se atraen entre asas y producen necrosis y perforación), objetos afilados o > 5 cm, y las bolitas de polímero absorbente (se expanden con el agua y obstruyen).

4. COMIDA IMPACTADA Y COMPLICACIONES

Alimento impactado en el esófago: si el paciente puede tragar líquidos y no tiene dolor → observar hasta 24 h. Si no traga líquidos, tiene dolor o lleva > 24 h → endoscopía para desimpactar. Tras el episodio conviene estudiar el esófago (esofagitis eosinofílica, estenosis, anillo). 6.03.2.008 1.06.2.002

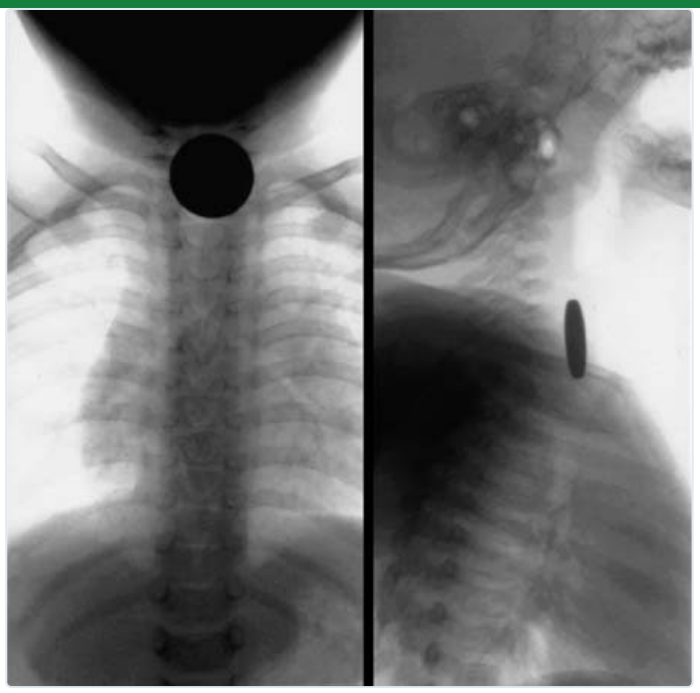


Bolo de carne impactado en el esófago distal

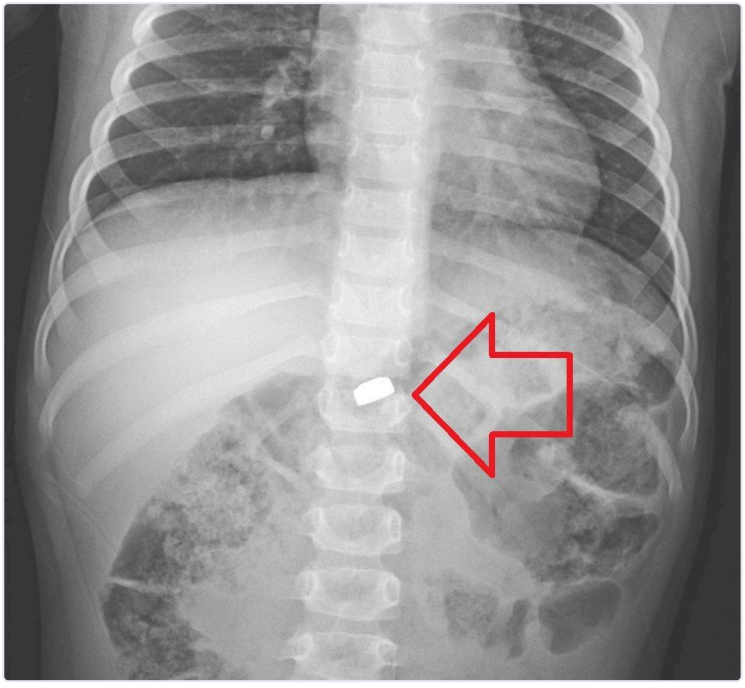
Si un cuerpo extraño distal produce obstrucción intestinal o perforación, el tratamiento es quirúrgico. No se debe hacer la maniobra de Heimlich por un cuerpo extraño digestivo (solo se usa en la obstrucción completa de la vía aérea). 6.03.2.008

5. OTRAS CAUSAS DE AFAGIA AGUDA

Afagia o disfagia aguda (urgencia; nivel: diagnóstico específico, tratamiento inicial, derivar): la impactación alimentaria no es la única causa. Considerar: **esofagitis infecciosa** (Candida, herpes, citomegalovirus) en inmunosuprimidos o con VIH, con odinofagia intensa; **esofagitis por pastillas** (doxiciclina, bifosfonatos, potasio) y **cáustica**; esofagitis eosinofílica con impactaciones repetidas en el adulto joven atópico; **causas orofaríngeas** (absceso periamigdalino o retrofaríngeo, epiglotitis, angioedema o anafilaxia) y neurológicas (ACV de tronco, miastenia). Primero se evalúa la **vía aérea** y la capacidad de manejar la saliva; luego se orienta por el contexto y se pide endoscopía urgente si hay sialorrea, dolor torácico o sospecha de perforación. 1.06.2.002



A. MONEDA EN EL ESÓFAGO



B. PILA DE BOTÓN



C. BOLO DE CARNE IMPACTADO

Imagen 5.4

TABLA 5.4 · CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO — ¿RETIRAR U OBSERVAR? 6.03.2.008, 1.06.2.002

SITUACIÓN	CONDUCTA
Cualquier cuerpo extraño en el esófago	Retiro endoscópico (urgente si obstrucción, pila o afilado)
Pila de botón en el esófago	Emergencia: extracción inmediata
Objeto romo y pequeño, ya en el estómago, asintomático	Observar + radiografía cada 1–2 semanas
Pilas, ≥ 2 imanes, objeto afilado o > 5 cm, bolitas absorbentes	Retirar siempre, en cualquier ubicación
Alimento impactado, tolera líquidos y sin dolor	Observar hasta 24 h
Alimento impactado con dolor o sin tragar líquidos	Endoscopía para desimpactar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Niño de 2 años es llevado a urgencias porque hace una hora tragó una pila de botón del control remoto. Está asintomático. La radiografía de tórax muestra la pila a nivel del esófago medio, con el signo del "doble halo".

Conducta oficial. Una pila de botón alojada en el esófago es una emergencia médica: el paso de corriente y la hidrólisis generan una quemadura alcalina de la pared en cuestión de horas, con riesgo de perforación, fístula traqueoesofágica y mediastinitis. La conducta es la extracción endoscópica inmediata, sin esperar. Si la pila ya hubiera pasado al estómago y el niño estuviera asintomático, igual se retira (las pilas se sacan en cualquier ubicación), pero sin el mismo carácter de emergencia.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Sospecha de cuerpo extraño digestivo: radiografía de cuello, tórax y abdomen.
- En el esófago se retira siempre por endoscopía; el dolor torácico sugiere perforación.
- Pila de botón en el esófago = emergencia (quemadura en horas) → extracción inmediata.
- Se retira en cualquier ubicación: pilas, ≥ 2 imanes, objetos afilados o > 5 cm, bolitas absorbentes.
- Objeto romo y pequeño ya en el estómago, asintomático: observar con radiografías cada 1–2 semanas.
- Alimento impactado: observar 24 h si tolera líquidos y no duele; endoscopía si no traga o tiene dolor.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 45 años consulta por sensación de cuerpo extraño retroesternal tras comer un trozo grande de carne hace 6 horas. Tiene dolor retroesternal y no consigue tragar ni siquiera su saliva. ¿Cuál es la conducta?

A) Observación por 24 horas
B) Radiografía de tórax y control en 12 horas
C) Endoscopía digestiva alta para desimpactar
D) Bebida carbonatada y enzimas proteolíticas para disolver la carne
E) TAC de tórax con contraste

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Niño de 5 años se tragó una moneda hace 3 horas. Está asintomático, sin sialorrea ni dificultad para tragar. La radiografía muestra la moneda en la cámara gástrica. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

A) Endoscopía digestiva alta urgente
B) Laparotomía para extraer la moneda
C) Observación con control radiológico cada 1–2 semanas
D) Administrar un laxante para acelerar el tránsito
E) Maniobra de Heimlich

Más preguntas online de Cuerpo Extraño Digestivo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis	Apendicitis: dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha + anorexia...	**Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: primero test de embarazo y evaluación...**	Diverticulitis: TAC de abdomen y pelvis; la colonoscopía está contraindicada en el...
Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular	Embolia mesentérica: fibrilación auricular + dolor súbito e intensísimo + abdomen sin...	**Ante la sospecha de embolia mesentérica se anticoagula con heparina de inmediato; el...**	—
Hemorragia Digestiva Alta y Baja	La gravedad de una hemorragia digestiva se mide por la hemodinamia (taquicardia →...	**Reanimación inicial: dos vías gruesas + cristaloides. La transfusión no es el primer...**	—
Cuerpo Extraño Digestivo	Sospecha de cuerpo extraño digestivo: radiografía de cuello, tórax y abdomen.	**En el esófago se retira siempre por endoscopía; el dolor torácico sugiere perforación.**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Apendicitis: dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha + anorexia; diagnóstico clínico → apendicectomía.

Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: primero test de embarazo y evaluación ginecológica.

Plastrón apendicular (masa en FID): antibióticos primero y apendicectomía diferida; no es lo mismo que la apendicitis perforada.

Diverticulitis: TAC de abdomen y pelvis; la colonoscopía está contraindicada en el episodio agudo.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: primero test de embarazo y evaluación ginecológica.
- Plastrón apendicular (masa en FID): antibióticos primero y apendicectomía diferida; no es lo mismo que la apendicitis perforada.
- Ante la sospecha de embolia mesentérica se anticoagula con heparina de inmediato; el examen es la angio-TAC/angiografía.
- Trombosis venosa mesentérica: dolor subagudo con signos peritoneales, en hipercoagulables → TAC con contraste + anticoagulación.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Apendicitis: dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha + anorexia; diagnóstico clínico → apendicectomía.	Tema 5.1 →
Embolia mesentérica: fibrilación auricular + dolor súbito e intensísimo + abdomen sin signos peritoneales...	Tema 5.2 →
La gravedad de una hemorragia digestiva se mide por la hemodinamia (taquicardia → ortostatismo → hipotensión), no...	Tema 5.3 →
Sospecha de cuerpo extraño digestivo: radiografía de cuello, tórax y abdomen.	Tema 5.4 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

06 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
6.1	Diarrea Aguda y Crónica en el Niño	99
6.2	Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño	102
6.3	Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	105
6.4	Trauma Abdominal y Torácico	108

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.039, 2.01.1.040, 2.01.2.006, 2.01.1.042, 2.01.1.007, 2.01.4.017, 1.04.4.011, 1.06.1.026	Diarrea Aguda y Crónica en el Niño	Específico	Completo	Completo
2.01.1.046, 2.01.1.041, 2.01.1.038, 5.01.1.027, 5.01.1.032, 2.01.5.007	Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño	Específico	Completo	Completo
2.01.1.116, 2.01.2.019, 4.01.1.003, 2.01.1.133, 4.01.1.012, 2.01.4.002, 2.01.4.009, 1.06.4.003	Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.2.010, 4.01.2.016, 1.05.2.011	Trauma Abdominal y Torácico	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Diarrea aguda del niño: hidratar según el grado (Plan A oral / B SRO 50–100 mL/kg / C suero fisiológico 20 mL/kg en bolo).

! TRAMPA · Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibiótico solo en disentería por Shigella o E. coli enteroinvasora (ciprofloxacino).

Salmonella no tifoidea no complicada: no se trata con antibióticos (prolonga el estado de portador).

Diarrea crónica del lactante más frecuente: diarrea crónica inespecífica por jugos hiperosmolares → suspender jugos.

! TRAMPA · Siempre descartar giardiasis antes de diagnosticar enfermedad celíaca.

Alergia a la proteína de leche de vaca: diagnóstico por prueba terapéutica con reintroducción; no hay test sanguíneo validado.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Diarrea Aguda y Crónica en el Niño	EUNACOM Julio 2025 · #74 · EUNACOM Julio 2025 · #146 · EUNACOM Diciembre 2025 · #65 · EUNACOM Julio 2025 · #6
Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño	EUNACOM Diciembre 2025 · #137 · EUNACOM Julio 2025 · #72 · EUNACOM Diciembre 2025 · #66 · EUNACOM Julio 2024 · #79
Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	EUNACOM Diciembre 2025 · #146 · EUNACOM Diciembre 2024 · #120 · EUNACOM Julio 2024 · #33 · EUNACOM Julio 2024 · #10
Trauma Abdominal y Torácico	EUNACOM Diciembre 2025 · #123 · EUNACOM Julio 2025 · #71 · EUNACOM Julio 2024 · #102 · EUNACOM Diciembre 2024 · #33

6.1. Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.039 2.01.1.040 2.01.2.006 2.01.1.042 2.01.1.007 2.01.4.017 1.04.4.011 1.06.1.026

¿POR QUÉ?

En la diarrea aguda del niño casi todo es rotavirus y casi todo se resuelve hidratando por boca; el error clásico es indicar loperamida (contraindicada) o un antibiótico que no cambia el curso. En la diarrea crónica del lactante, la causa más frecuente es la más simple: demasiado jugo. Y hay dos cuadros que "imitan" a la celíaca y hay que descartar antes: la giardiasis y la alergia a la proteína de leche de vaca.

1. DIARREA AGUDA: HIDRATACIÓN

2.01.1.039 2.01.2.006

Mayoritariamente viral (rotavirus). El pilar es la hidratación según el grado de deshidratación: **Plan A** (sin deshidratación): sales de rehidratación oral 100–200 mL tras cada deposición, en casa. **Plan B** (deshidratación moderada, 5–10 %): SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h; fraccionar si vomita. **(ver Imagen 6.1A y B)**

Plan C (deshidratación grave > 10 %, shock, compromiso de conciencia, íleo, vómitos incoercibles): suero fisiológico endovenoso en bolo de 20 mL/kg; vía intraósea si no se logra acceso venoso.

2. DIARREA AGUDA: FÁRMACOS

2.01.1.039

Los antidiarreicos están **contraindicados** en la diarrea aguda pediátrica. Se pueden usar antieméticos si hay vómitos.

Antibiótico solo ante Shigella o E. coli enteroinvasora (disentería + fiebre alta + mal estado general): ciprofloxacino oral (excepción a la regla de no usar quinolonas en niños); cefotaximo endovenoso si hay sepsis. La **Salmonella no tifoidea no complicada no se trata** (prolonga el estado de portador).

3. DIARREA CRÓNICA DEL LACTANTE Y PREESCOLAR

2.01.1.040

Diarrea crónica inespecífica (la más frecuente): por exceso de jugos azucarados/hiperosmolares; el niño crece bien y está sano → suspender los jugos.

2.01.1.040 2.01.1.007 2.01.4.017 1.04.4.011 1.06.1.026

Giardiasis: preescolar de zona rural, con flatulencia y dolor cólico, a menudo varios miembros de la familia afectados; puede dar malabsorción. Diagnóstico: parasitológico seriado (3 muestras). Tratamiento: tinidazol o metronidazol. **Siempre descartar Giardia antes de diagnosticar celíaca.**

4. CELÍACA, FIBROSIS QUÍSTICA Y ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA

2.01.1.040 2.01.1.042

Enfermedad celíaca: desde el año de vida (con la introducción del gluten); malabsorción + anemia ferropénica + anticuerpos anti-transglutaminasa → biopsia duodenal; dieta sin gluten de por vida. Fibrosis quística: diarrea con esteatorrea (insuficiencia pancreática) + neumonías recurrentes (Pseudomonas, S. aureus) → test del sudor (cloro ≥ 60 mmol/L confirma).

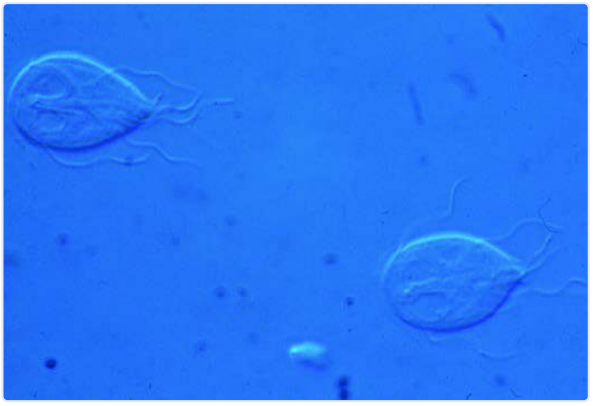
2.01.1.040

Alergia a la proteína de leche de vaca: lactante con síntomas gastrointestinales (diarrea crónica, reflujo, sangre en las deposiciones, lesiones perianales) y alérgicos (exantema, sibilancias). Diagnóstico por prueba terapéutica: fórmula extensamente hidrolizada (o dieta materna sin lácteos) por 2–4 semanas → mejora → se reintroduce y reaparecen los síntomas = confirmado. No hay test sanguíneo validado.

5. PARASITOLÓGICO SERIADO, OTRAS ENTEROPARASITOSIS Y FIBROSIS QUÍSTICA

2.01.4.017 1.04.4.011

Cómo se interpreta el parasitológico seriado (nivel: interpretar y emplear): se piden **3 muestras en días alternos** (un solo examen pierde casos, sobre todo de Giardia), con conservante; en una diarrea líquida se busca además el trofozoíto en fresco. Se informan **quistes o trofozoítos** (Giardia, Entamoeba) y **huevos** (Ascaris, Trichuris). Los **oxiuros** no se ven bien aquí: se usa el **test de Graham** (cinta adhesiva en la región perianal, por la mañana). La larva de Strongyloides requiere técnica especial. Un resultado positivo se trata; uno negativo con alta sospecha se repite. **(ver Imagen 6.1C)**



Trofozoíto de Giardia lamblia en microscopía



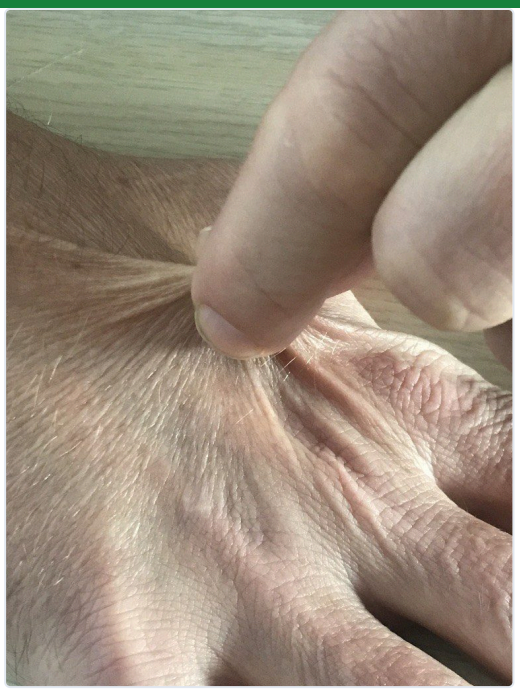
Huevos de Enterobius vermicularis (oxiuros)

2.01.1.007 1.06.1.026

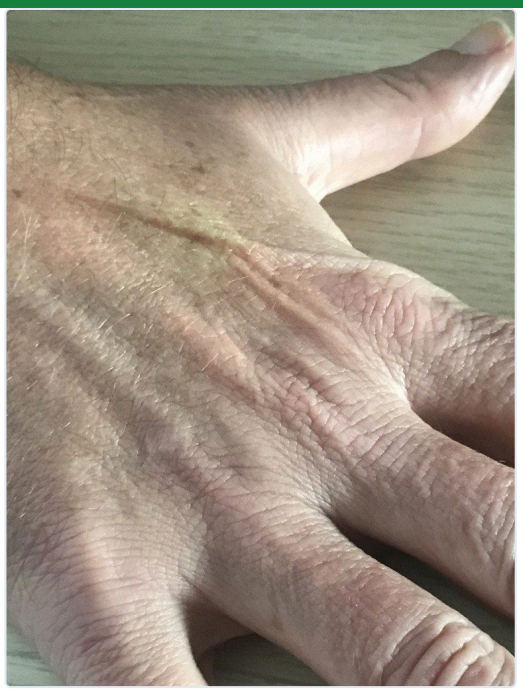
Otras enteroparasitosis del niño y de la parasitosis intestinal: oxiuriasis (prurito anal nocturno, vulvovaginitis, irritabilidad): albendazol o mebendazol, repetir a las 2 semanas y tratar a toda la familia con higiene de manos y uñas. **Ascariasis**: dolor cólico, tos y eosinofilia en la fase pulmonar (Löffler); puede obstruir el intestino o la vía biliar; albendazol. **Tricocefalosis**: diarrea con moco, anemia y prolapso rectal en la infestación intensa. **Teniasis**: proglótidos en las deposiciones; praziquantel. Todas se previenen con agua segura, lavado de manos y eliminación de excretas.

2.01.1.042

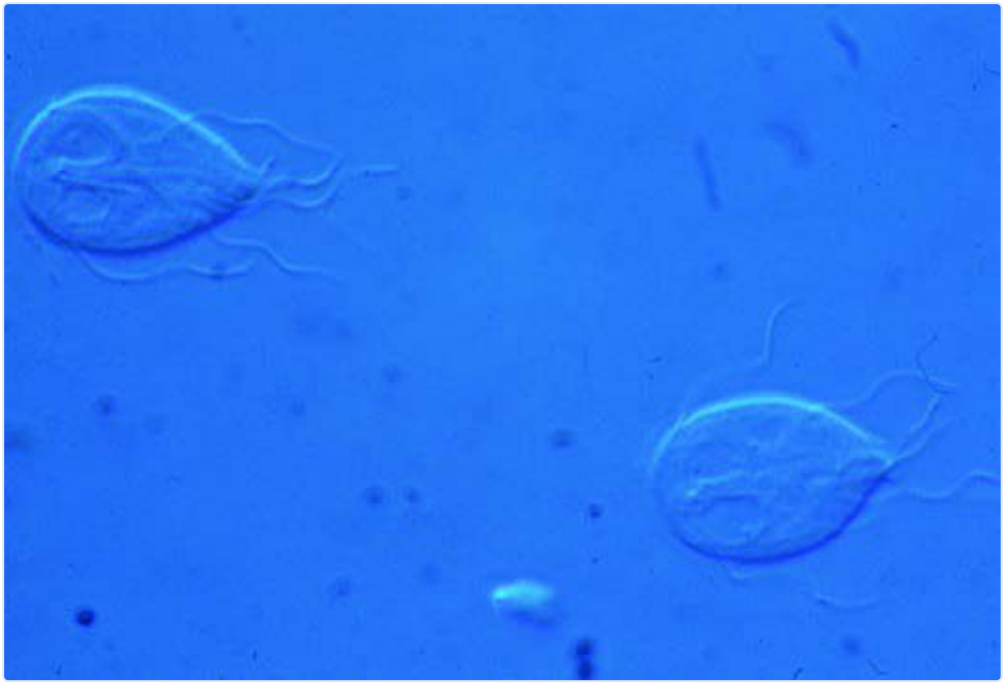
Fibrosis quística, manejo inicial (nivel: sospecha, tratamiento inicial, derivar): se sospecha en el lactante con **diarrea crónica con esteatorrea**, mal incremento ponderal pese a buen apetito, infecciones respiratorias repetidas, prolapso rectal, antecedente de íleo meconial y sabor salado de la piel. El diagnóstico es el **test del sudor** (cloro > 60 mmol/L) confirmado con estudio genético. Conducta: derivar a un centro especializado y, mientras tanto, **enzimas pancreáticas con cada comida**, vitaminas A, D, E y K, dieta hipercalórica con sal, kinesioterapia respiratoria y vacunas al día.



A. SIGNO DEL PLIEGUE



B. PLIEGUE PERSISTENTE



C. TROFOZOÍTOS DE GIARDIA

Imagen 6.1

TABLA 6.1 · DIARREA CRÓNICA DEL LACTANTE — ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

2.01.1.039, 2.01.1.040, 2.01.2.006, 2.01.1.042, 2.01.1.007, 2.01.4.017, 1.04.4.011, 1.06.1.026

CAUSA	PISTA CLÍNICA	ESTUDIO / CONDUCTA
Diarrea crónica inespecífica	Niño sano que crece bien; bebe muchos jugos	Clínico → suspender jugos
Giardiasis	Zona rural, flatulencia, varios familiares afectados	Parasitológico seriado → tinidazol
Enfermedad celíaca	Malabsorción + anemia ferropénica desde el año	Anti-transglutaminasa + biopsia duodenal
Fibrosis quística	Esteatorrea + neumonías recurrentes	Test del sudor
Alergia a la proteína de leche de vaca	Síntomas GI + alérgicos en el lactante	Prueba terapéutica con fórmula hidrolizada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 6.1

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días, sin sangre. Al examen está irritable, llora sin lágrimas, tiene las mucosas secas y los ojos hundidos, y ha perdido el 7 % de su peso. Bebe con avidez pequeñas cantidades de líquido que se le ofrecen.

Conducta oficial. Deshidratación moderada (7 % de pérdida de peso, mucosas secas, ojos hundidos, llanto sin lágrimas) por una diarrea aguda sin disentería: corresponde el Plan B, con sales de rehidratación oral 50–100 mL/kg en 4–6 horas, reevaluando. Como tolera la vía oral, no requiere suero endovenoso. No se indican antibióticos (no hay disentería ni fiebre alta persistente) y los antidiarreicos están contraindicados en pediatría.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Diarrea aguda del niño: hidratar según el grado (Plan A oral / B SRO 50–100 mL/kg / C suero fisiológico 20 mL/kg en bolo).
- Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibiótico solo en disentería por Shigella o E. coli enteroinvasora (ciprofloxacino).
- Salmonella no tifoidea no complicada: no se trata con antibióticos (prolonga el estado de portador).
- Diarrea crónica del lactante más frecuente: diarrea crónica inespecífica por jugos hiperosmolares → suspender jugos.
- Siempre descartar giardiasis antes de diagnosticar enfermedad celíaca.
- Alergia a la proteína de leche de vaca: diagnóstico por prueba terapéutica con reintroducción; no hay test sanguíneo validado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 6.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Preescolar de 4 años de una zona rural consulta por diarrea crónica de 2 meses, con abundante flatulencia y dolor abdominal tipo cólico. Dos hermanos tienen síntomas similares. Crece en un percentil bajo pero estable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?

A) Diarrea crónica inespecífica; suspender los jugos
B) Enfermedad celíaca; dieta sin gluten
C) Giardiasis; tinidazol (o metronidazol)
D) Fibrosis quística; enzimas pancreáticas
E) Alergia a la proteína de leche de vaca; fórmula hidrolizada

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Lactante de 4 meses alimentado con fórmula presenta diarrea crónica con estrías de sangre, reflujo y episodios de exantema y sibilancias. El incremento ponderal está enlentecido. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más apropiado?

A) Test del sudor
B) Anticuerpos anti-transglutaminasa
C) Prueba terapéutica con fórmula extensamente hidrolizada por 2–4 semanas y posterior reintroducción
D) Parasitológico seriado de deposiciones
E) Endoscopía digestiva alta con biopsias

Más preguntas online de Diarrea Aguda y Crónica en el Niño →

6.2. Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.046 | 2.01.1.041 | 2.01.1.038 | 5.01.1.027 | 5.01.1.032 | 2.01.5.007

¿POR QUÉ?

El reflujo del lactante se decide con una pregunta: ¿es un "lactante feliz" que crece bien? Entonces es fisiológico y solo hay que tranquilizar. Si hay mal incremento de peso, síntomas respiratorios o sangre, es patológico y se trata. En la constipación con fecaloma el orden es obligatorio: primero se desimpacta (polietilenglicol oral) y después se mantiene con laxantes por semanas; si se salta la desimpactación, el fecaloma no sale y todo empeora.

1. REFLUJO GASTROESOFÁGICO DEL LACTANTE

Fisiológico: "lactante feliz", regurgita pero crece bien y tiene el examen normal. Pico a los 2–6 meses, desaparece hacia el año-año y medio. Conducta: educar y tranquilizar, medidas posturales, fraccionar la alimentación. 2.01.1.046

Patológico: mal incremento ponderal, irritabilidad, rechazo alimentario, síntomas respiratorios (sibilancias, neumonías), hematemesis o episodios de aparente amenaza a la vida. Estudio (pH-metría/impedanciometría si hay duda) y tratamiento con **IBP (omeprazol)** como primera línea; la cirugía (funduplicatura) es la última opción.

2. DIFERENCIAL: ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO

Vómitos explosivos y proyectivos que aparecen entre la 2.ª y la 6.ª semana de vida (no desde el nacimiento), en un lactante ávido por comer, con deshidratación y alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica. 2.01.1.046

Diagnóstico: ecografía abdominal (píloro engrosado, "oliva pilórica"). Tratamiento: corregir la hidratación y los electrolitos y luego pilorotomía de Ramstedt. Si en lugar de alcalosis hay acidosis con hiperpotasemia, pensar en hiperplasia suprarrenal congénita. **(ver Imagen 6.2A y B)**

3. DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN EL NIÑO

Con signos de alarma (baja de peso, examen alterado, vómitos o sangre, fiebre recurrente, dolor que despierta): estudiar con exámenes e imágenes según la orientación. 2.01.1.041

Sin signos de alarma: lo más frecuente es el **dolor abdominal funcional** (psicógeno), periumbilical, que aumenta con el estrés escolar y cede en vacaciones y fines de semana. Tratamiento: explicar, tranquilizar y manejar el estrés; no hacen falta exámenes si el examen físico es normal. 2.01.1.041 5.01.1.032

4. CONSTIPACIÓN Y FECALOMA

Constipación funcional: < 3 deposiciones por semana, duras y dolorosas, con un círculo vicioso (dolor → retención → más constipación). El fecaloma es la causa más frecuente de masa abdominal en pediatría y produce encopresis y pseudoincontinencia (rebosamiento). Diagnóstico: examen abdominal y tacto rectal (con testigo y registro). 2.01.1.038 5.01.1.027



Rx de abdomen con fecaloma en niño

Manejo en dos fases en orden: (1) **desimpactación con polietilenglicol oral** (de elección), o enema; (2) mantenimiento con laxante osmótico por al menos 4 semanas + hábito de sentarse tras las comidas + fibra y agua. Siempre descartar organicidad (enfermedad de Hirschsprung si hubo retraso en la eliminación del meconio). 2.01.1.038

5. ENEMA EVACUADOR, SOMATIZACIÓN Y ENCOPRESIS

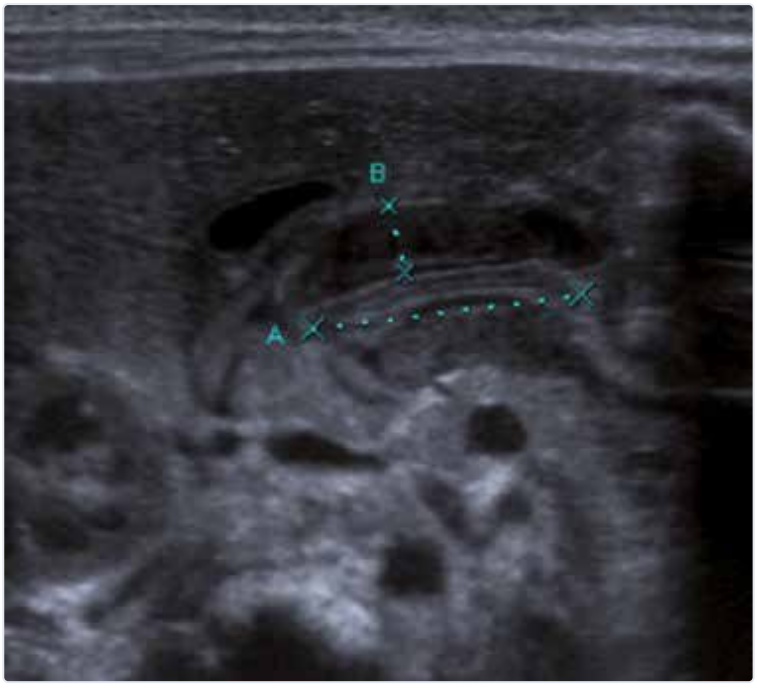
Proctoclisis o enema evacuador (nivel: realizar): niño en decúbito lateral izquierdo con las rodillas flexionadas; sonda rectal lubricada introducida 3–5 cm (menos en el lactante) y solución fisiológica tibia, 10 mL/kg, que pasa lentamente por gravedad; luego se mantienen juntos los glúteos unos minutos. **No usar agua sola** (hiponatremia) y evitar el enema de fosfato en menores de 2 años y en la enfermedad de Hirschsprung. Contraindicaciones: sospecha de obstrucción mecánica o abdomen agudo, enterocolitis necrotizante, neutropenia y cirugía anorrectal reciente. 2.01.5.007

Dolor abdominal funcional y somatización: se sospecha cuando el dolor es recurrente, periumbilical, sin signos de alarma y con un contexto de estrés (colegio, bullying, conflicto familiar, ausentismo). El manejo es **validar el síntoma** (el dolor es real), evitar exámenes innecesarios, explorar los estresores, llevar un diario de síntomas y mantener la asistencia escolar; se deriva a salud mental si hay un deterioro funcional importante o ansiedad o depresión. 5.01.1.032

Encopresis: escape involuntario de deposición en un niño de 4 años o más, casi siempre **retentiva** (rebosamiento por un fecaloma). Además de la desimpactación y el laxante, el manejo es **conductual**: sentarlo en el baño 5–10 minutos después de las comidas, con apoyo para los pies, registro de logros con refuerzo positivo y **sin castigo ni reproche**. Se deriva a salud mental si hay problemas de conducta o de ánimo asociados, o si no responde. 5.01.1.027



A. MÚSCULO PILÓRICO ENGROSADO



B. ECOGRAFÍA: OLIVA PILÓRICA

Imagen 6.2

TABLA 6.2 · REFLUJO DEL LACTANTE: FISIOLÓGICO VS PATOLÓGICO

2.01.1.046, 2.01.1.041, 2.01.1.038, 5.01.1.027, 5.01.1.032, 2.01.5.007

RASGO	FISIOLÓGICO	PATOLÓGICO
Estado del lactante	"Lactante feliz"	Irritable, rechazo alimentario
Incremento ponderal	Normal	Enlentecido o descenso
Síntomas respiratorios / sangre	Ausentes	Presentes
Conducta	Educar y tranquilizar	Estudiar + IBP (omeprazol)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 6.2

Lactante de 3 meses alimentado al pecho, traído por regurgitaciones después de casi todas las mamadas. Está tranquilo y sonriente, con un incremento de peso adecuado para su edad y un examen físico normal. Los padres están angustiados y piden "algo para el reflujo".

Conducta oficial. Es un reflujo gastroesofágico fisiológico del lactante: un "lactante feliz" que regurgita pero crece bien y tiene el examen normal. La conducta es educar y tranquilizar a los padres, explicar que el pico es entre los 2 y 6 meses y que se resuelve espontáneamente hacia el año, junto con medidas posturales y fraccionamiento de las tomas. No se indican inhibidores de la bomba de protones ni procinéticos ni estudios, que se reservan para el reflujo patológico (mal incremento, síntomas respiratorios, sangrado).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Reflujo del lactante fisiológico = "lactante feliz" que crece bien → educar y tranquilizar, sin fármacos.
- Reflujo patológico (mal incremento, síntomas respiratorios, sangre): IBP (omeprazol) de primera línea.
- Vómitos explosivos entre la 2.ª y 6.ª semana + alcalosis hipoclorémica = estenosis hipertrófica del píloro → ecografía → pilorotomía de Ramstedt.
- Dolor abdominal crónico sin signos de alarma: funcional/psicógeno, periumbilical, ligado al estrés escolar.
- El fecaloma es la causa más frecuente de masa abdominal en pediatría (encopresis, pseudoincontinencia).
- Constipación con fecaloma: primero desimpactar (polietilenglicol oral), después mantener con laxante ≥ 4 semanas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 6.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Recién nacido de 4 semanas, previamente sano, con 5 días de vómitos explosivos posprandiales. Se muestra ávido por alimentarse. Al examen tiene signos de deshidratación; en el laboratorio destaca hipopotasemia y alcalosis metabólica. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?

A) pH-metría esofágica de 24 horas
B) Radiografía de abdomen simple
C) Ecografía abdominal
D) Endoscopía digestiva alta
E) TAC de abdomen

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y manchado fecal en la ropa interior. Al examen se palpa una masa en el hipogastrio y, al tacto rectal, una gran masa fecal dura en la ampolla rectal. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Dieta rica en fibra y aumento de la ingesta de agua
B) Polietilenglicol por vía oral para desimpactar
C) Extracción digital del fecaloma bajo sedación
D) Laxantes osmóticos en dosis de mantenimiento de forma indefinida
E) Derivación quirúrgica

Más preguntas online de Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño →

6.3. Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.116 | 2.01.2.019 | 4.01.1.003 | 2.01.1.133 | 4.01.1.012 | 2.01.4.002 | 2.01.4.009 | 1.06.4.003

¿POR QUÉ?

Este tema se estudia por sus imágenes-clave, una por diagnóstico. Neumatosis intestinal en un prematuro = enterocolitis necrotizante. Lactante de 6–12 meses con llanto en crisis y deposiciones "en mermelada de grosella" = invaginación. Sangrado rectal indoloro y abundante en un niño sano = divertículo de Meckel. Doble burbuja en el recién nacido que vomita desde el primer día = atresia duodenal. Meconio que no sale en 48 horas = enfermedad de Hirschsprung.

1. ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE

Recién nacido prematuro (factor de riesgo principal), en los primeros días-semanas, con tríada: retención gástrica/vómitos + distensión abdominal + hematoquecia. **(ver Imagen 6.3B y C)** 2.01.1.116

Diagnóstico: radiografía de abdomen → **neumatosis intestinal** (aire en la pared, patognomónico); el neumoperitoneo indica perforación. Tratamiento: régimen cero + nutrición parenteral + antibióticos endovenosos; cirugía solo si hay perforación, necrosis o falla del tratamiento médico. **(ver Imagen 6.3A)** 2.01.1.116 | 2.01.4.002

2. INVAGINACIÓN INTESTINAL

Lactante de 6–12 meses, previamente sano, con crisis de llanto e hiperflexión de las piernas que van y vienen, y deposiciones "en mermelada de grosella" (sangre y moco). A veces masa palpable "en salchicha". 2.01.2.019

Diagnóstico: ecografía abdominal ("signo de la dona" o del "donut"). Tratamiento de primera línea: **reducción neumática** (o hidrostática) guiada por imagen; la cirugía es la última opción (si falla la reducción, hay perforación o hay una causa anatómica).

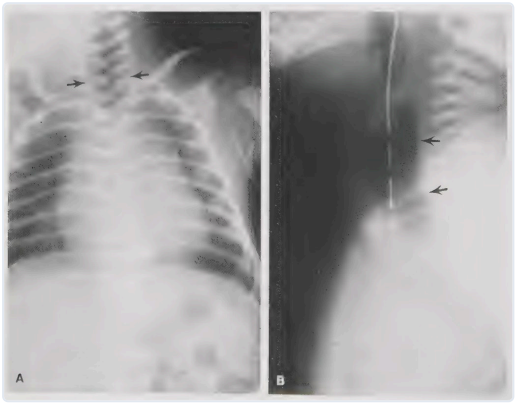
3. DIVERTÍCULO DE MECKEL Y PÓLIPOS JUVENILES

Divertículo de Meckel: resto del conducto onfalomesentérico en el íleon, con mucosa gástrica ectópica que ulcera y sangra. 4.01.1.003
Se presenta como hemorragia digestiva baja indolora y abundante en un niño pequeño, o como una diverticulitis que imita la apendicitis. Diagnóstico: **cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m**. Regla de los "2": 2 % de la población, a 2 pies de la válvula ileocecal, 2 pulgadas de largo, hacia los 2 años.

Pólipos juveniles: escolar sano con rectorragia escasa e intermitente; hamartomas benignos. Diagnóstico y tratamiento: colonoscopía con polipectomía.

4. MALFORMACIONES QUE OBSTRUYEN

Atresia duodenal: vómitos biliosos desde el primer día; radiografía con "doble burbuja"; asociada a síndrome de Down. 2.01.2.019 | 2.01.1.133
Atresia esofágica: sialorrea desde el nacimiento y sonda que no progresa al estómago. Hernia diafragmática congénita: dificultad respiratoria grave + abdomen excavado + ruidos hidroaéreos en el tórax → lo urgente es intubar y ventilar, la cirugía es diferida. 2.01.4.002



Atresia esofágica

Enfermedad de Hirschsprung: retraso en la eliminación del meconio (> 48 h) + distensión y constipación; se confirma con biopsia rectal (ausencia de células ganglionares) → resección del segmento aganglionico. Ano imperforado: diagnóstico por inspección; siempre examinar el ano del recién nacido. 2.01.1.133 | 4.01.1.012

5. ESTUDIOS RADIOLÓGICOS Y MEGACOLON

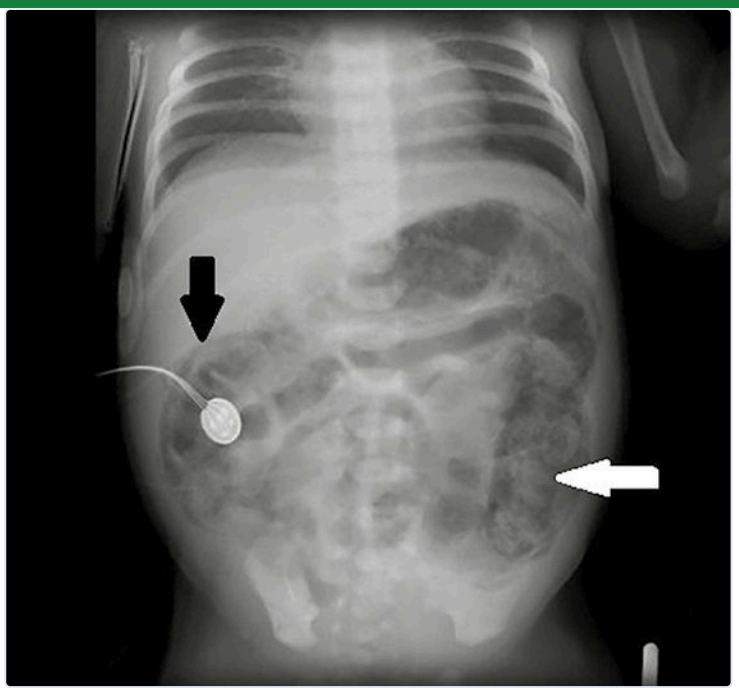
Radiografía de abdomen simple (nivel: interpretar y emplear): se revisa el patrón de gas, los niveles hidroaéreos y el aire fuera de la luz. **«Doble burbuja»** (estómago y duodeno distendidos sin gas distal) = atresia duodenal; **ausencia de gas distal** con asas dilatadas = obstrucción intestinal; **neumatosis** o gas en la vena porta = enterocolitis necrotizante; **neumoperitoneo** (aire bajo el diafragma, signo de Rigler) = perforación. Un abdomen sin gas puede indicar vólvulo o peritonitis. 2.01.4.002

Radiografía de esófago-estómago-duodeno (nivel: emplear informe): en el pediatra es el examen de la **anatomía**, no del reflujo. Se pide **de urgencia ante vómitos biliosos** del recién nacido o lactante para descartar **malrotación con vólvulo** (el duodeno no cruza la línea media y el ángulo de Treitz queda a la derecha, con aspecto «en tirabuzón»), una emergencia quirúrgica. También se usa si hay duda de estenosis hipertrófica del píloro o de una estenosis esofágica. 2.01.4.009

Enema baritada (nivel: emplear informe): en la sospecha de **Hirschsprung** muestra el segmento distal estrecho, una **zona de transición en cono** y el intestino dilatado por encima, con retención del bario a las 24 horas; se hace sin preparación previa (sin enemas ni tacto) y **no reemplaza a la biopsia rectal**, que confirma el diagnóstico. En el íleo meconial o la atresia ileal se observa un microcolon. 1.06.4.003


Enfermedad de Hirschsprung en la enema baritada: intestino dilatado sobre un segmento distal estrecho

Megacolon: es la dilatación del colon, con tres escenarios. **Congénito (Hirschsprung)** por aganglionosis. **Chagásico** en el adulto de zona endémica, por destrucción de los plexos mientéricos: constipación crónica, fecaloma y vólvulo del sigmoides (se descomprime por rectosigmoidoscopía y se opera). **Tóxico** en la colitis ulcerosa o por *C. difficile* (colon transverso > 6 cm con fiebre y shock): régimen cero, sonda nasogástrica, corticoides y antibióticos endovenosos y cirugía si no mejora; no se hace enema baritada ni colonoscopía. Se suma la pseudoobstrucción aguda (Ogilvie) en pacientes graves. 4.01.1.012



A. NEUMATOSIS INTESTINAL



B. SIGNO DE LA DONA



C. INVAGINACIÓN (ESQUEMA)

Imagen 6.3

TABLA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA — CLAVE DIAGNÓSTICA ÚNICA

2.01.1.116, 2.01.2.019, 4.01.1.003, 2.01.1.133, 4.01.1.012, 2.01.4.002, 2.01.4.009, 1.06.4.003

ENTIDAD	CLAVE	CONDUCTA
Enterocolitis necrotizante	Prematuro + neumatosis intestinal en la Rx	Régimen cero + NPT + antibióticos; cirugía si perfora
Invaginación intestinal	Lactante 6–12 m + "mermelada de grosella" + signo de la dona	Reducción neumática (cirugía si falla)
Divertículo de Meckel	HDB indolora y abundante en niño pequeño	Cintigrafía con Tc-99m → resección
Atresia duodenal	Vómito bilioso día 1 + doble burbuja	Cirugía
Enfermedad de Hirschsprung	Meconio > 48 h + constipación	Biopsia rectal → resección
Hernia diafragmática congénita	Distrés respiratorio + abdomen excavado	Intubar y ventilar; cirugía diferida

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 6.3

Lactante de 8 meses, previamente sano, es traído por episodios de llanto inconsolable de pocos minutos con flexión de las piernas, que se repiten cada 15–20 minutos, y decaimiento entre las crisis. En el pañal se observan deposiciones con aspecto de "mermelada de grosella". La ecografía abdominal muestra una imagen en "diana" en el cuadrante superior derecho.

Conducta oficial. La combinación de un lactante de 6–12 meses con crisis de dolor intermitente, decaimiento entre crisis y deposiciones "en mermelada de grosella" (sangre con moco), más el signo de la dona/diana en la ecografía, es diagnóstica de invaginación intestinal. El tratamiento de primera línea es la reducción neumática (o hidrostática) guiada por imagen; la cirugía se reserva para el fracaso de la reducción, la perforación o la sospecha de una causa anatómica de fondo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Prematuro + tríada (retención, distensión, hematoquecia) + neumatosis intestinal = enterocolitis necrotizante.
- Lactante 6–12 meses + llanto en crisis + "mermelada de grosella" = invaginación → reducción neumática de primera línea.
- Hemorragia digestiva baja indolora y abundante en un niño = divertículo de Meckel → cintigrafía con Tc-99m.
- Vómito bilioso el primer día de vida + "doble burbuja" en la radiografía = atresia duodenal.
- Retraso en la eliminación del meconio (> 48 h) = enfermedad de Hirschsprung → biopsia rectal.
- Hernia diafragmática congénita: lo urgente es intubar y ventilar; la reparación quirúrgica es diferida.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 6.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Recién nacido prematuro de 30 semanas, a los 6 días de vida, presenta residuo gástrico bilioso, distensión abdominal y deposiciones con sangre. La radiografía de abdomen muestra aire en el espesor de la pared intestinal. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Atresia duodenal
B) Invaginación intestinal
C) Enterocolitis necrotizante
D) Enfermedad de Hirschsprung
E) Vólvulo del intestino medio

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Niño de 3 años, sano, consulta por un episodio de deposición con abundante sangre roja oscura, sin dolor abdominal. Está pálido y taquicárdico; el abdomen es blando, sin masas. La colonoscopía no muestra lesiones. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?

A) Repetir la colonoscopía con mejor preparación
B) Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio-99m
C) Ecografía abdominal
D) Radiografía de abdomen simple
E) TAC de abdomen con contraste

Más preguntas online de Cirugía Pediátrica Digestiva →

6.4. Trauma Abdominal y Torácico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 4.01.2.010 4.01.2.016 1.05.2.011

¿POR QUÉ?

La regla es que el mecanismo manda. En el trauma cerrado, decide la clínica más la eco-FAST: estable con FAST negativa se observa. En el trauma por arma blanca, decide la exploración de la herida: si penetra el peritoneo, se explora. En el trauma por arma de fuego abdominal, siempre se opera. El lavado peritoneal diagnóstico quedó obsoleto y la eco-FAST lo reemplazó.

1. TRAUMA ABDOMINAL CERRADO

Se maneja con clínica + eco-FAST (busca líquido libre). Paciente estable con FAST negativa y sin signos peritoneales → observación (o TAC si hay mecanismo de alta energía). Inestable, con signos peritoneales o con líquido libre → laparotomía. **(ver Imagen 6.4A)** 4.01.2.010

El **lavado peritoneal diagnóstico está obsoleto**. La rotura de víscera hueca da peritonitis y neumoperitoneo; la de víscera sólida (bazo, hígado) da hemoperitoneo — el bazo y el hígado se manejan de forma conservadora si el paciente está estable. **(ver Imagen 6.4B y C)**

2. TRAUMA ABDOMINAL POR ARMA BLANCA

Se maneja con clínica + exploración de la herida. Si la herida no penetra el peritoneo → observación. Si **penetra el peritoneo**, o hay inestabilidad, signos peritoneales o evisceración → exploración quirúrgica. 4.01.2.010

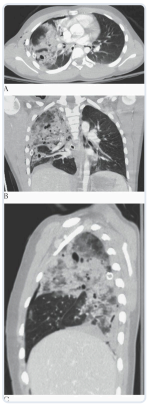
3. TRAUMA ABDOMINAL POR ARMA DE FUEGO

El trauma abdominal por proyectil de arma de fuego se **explora quirúrgicamente siempre** (la energía y la trayectoria producen lesiones múltiples de vísceras). 4.01.2.010

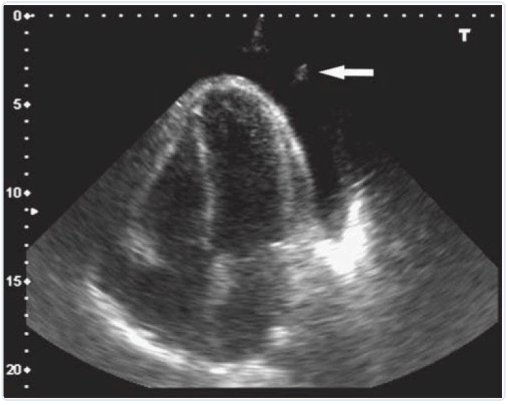
Excepcionalmente se maneja de forma no operatoria una herida claramente tangencial que no entra a la cavidad, en un paciente estable y bajo observación estricta con TAC.

4. TRAUMA TORÁCICO

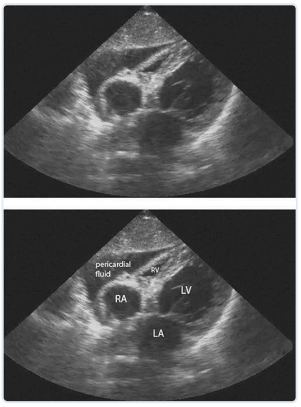
Cerrado y por arma blanca: clínica + radiografía de tórax y manejo de las complicaciones: neumotórax y hemotórax con tubo pleural, contusión pulmonar con soporte respiratorio, taponamiento con pericardiocentesis/ventana. 4.01.2.016 1.05.2.011



Contusión pulmonar en Rx/TC de tórax



Taponamiento cardíaco



Derrame pericárdico (eco)

Indicaciones de toracotomía: hemotórax masivo (> 1.500 mL de salida inicial por el tubo o > 200 mL/h por 2–4 h), taponamiento, lesión de grandes vasos o de la vía aérea, y todo trauma torácico por arma de fuego. 4.01.2.016

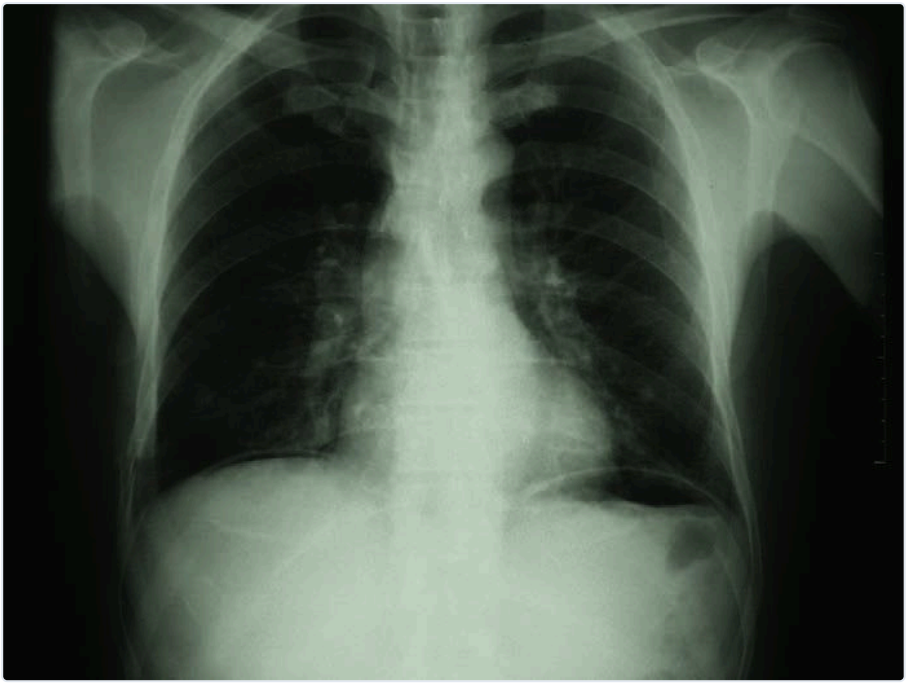
5. NEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

Neumotórax hipertensivo (nivel: diagnóstico específico, tratamiento completo): es una urgencia **clínica**, que no se confirma con radiografía. Tras un trauma o una ventilación con presión positiva aparecen disnea progresiva, **hipotensión y taquicardia**, ingurgitación yugular, murmullo vesicular abolido y **timpanismo** en un hemitórax; la desviación de la tráquea hacia el lado sano es un signo tardío. El aire atrapado comprime el mediastino y reduce el retorno venoso. 1.05.2.011

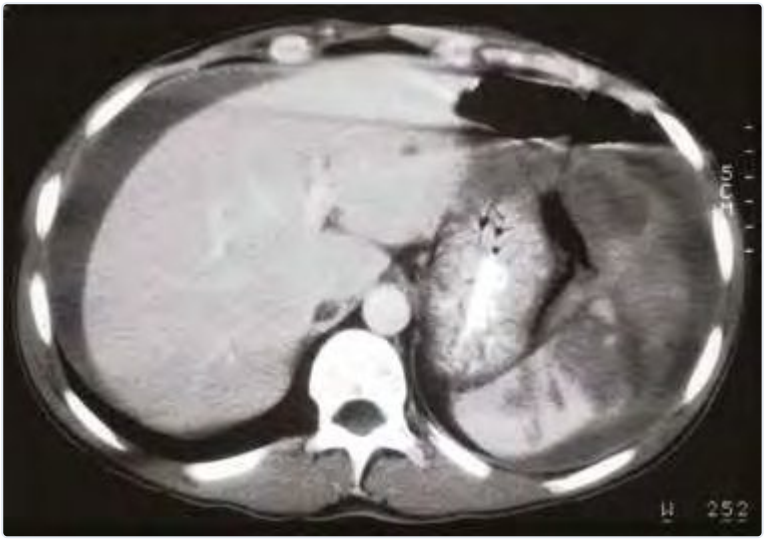
Tratamiento: descompresión inmediata con una aguja o un catéter grueso (14–16 G) en el **5.º espacio intercostal, por delante de la línea axilar media** (o el 2.º espacio en la línea medioclavicular), sobre el borde superior de la costilla; luego un **tubo pleural** definitivo con sello de agua y oxígeno. Después se pide la radiografía y se maneja la causa (trauma, fístula, barotrauma).



A. FAST POSITIVO



B. NEUMOPERITONEO



C. ROTURA ESPLÉNICA

Imagen 6.4

TABLA 6.4 · TRAUMA DE ABDOMEN — CONDUCTA SEGÚN EL MECANISMO 4.01.2.010, 4.01.2.016, 1.05.2.011

MECANISMO	EVALUACIÓN	CIRUGÍA SI...
Cerrado	Clínica + eco-FAST (± TAC)	Inestable, signos peritoneales o líquido libre
Arma blanca	Clínica + exploración de la herida	Penetra el peritoneo, inestable, peritonitis o evisceración
Arma de fuego	Clínica	Siempre (salvo herida tangencial demostrada)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 6.4

Hombre de 30 años sufre un choque automovilístico y llega hemodinámicamente estable, con dolor leve en el hipocondrio izquierdo y sin signos peritoneales. La eco-FAST no muestra líquido libre intraabdominal. La radiografía de tórax y pelvis son normales.

Conducta oficial. Trauma abdominal cerrado en un paciente estable, sin signos peritoneales y con eco-FAST negativa: la conducta es la observación con monitorización y reevaluaciones clínicas seriadas (se puede complementar con un TAC de abdomen si el mecanismo fue de alta energía). El lavado peritoneal diagnóstico está obsoleto y la exploración digital de la herida corresponde al trauma por arma blanca, no al cerrado. Se operaría si apareciera inestabilidad, peritonismo o líquido libre.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Trauma abdominal cerrado: clínica + eco-FAST; estable con FAST negativa → observación. El lavado peritoneal está obsoleto.
- Trauma abdominal por arma blanca: si la herida penetra el peritoneo → exploración quirúrgica.
- Trauma abdominal por arma de fuego: exploración quirúrgica siempre.
- Víscera hueca rota → peritonitis y neumoperitoneo; víscera sólida (bazo, hígado) → hemoperitoneo, manejo conservador si está estable.
- Trauma torácico: clínica + radiografía; hemotórax > 1.500 mL inicial o > 200 mL/h → toracotomía. Arma de fuego torácica → cirugía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 6.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Caso representativo · banco EUNACOM

1. Hombre de 25 años recibe una herida por arma blanca en el flanco derecho. Está estable, sin signos peritoneales. Al explorar la herida en pabellón se constata que atraviesa el peritoneo parietal. ¿Cuál es la conducta?

A) Observación clínica por 24 horas
B) Eco-FAST y decidir según el resultado
C) Exploración quirúrgica (laparotomía o laparoscopía)
D) Radiografía de abdomen simple y alta si es normal
E) Lavado peritoneal diagnóstico

Caso representativo · banco EUNACOM

2. Paciente de 40 años con trauma torácico cerrado. La radiografía muestra una opacidad de la base derecha con borramiento del ángulo costofrénico. Se instala un tubo pleural que drena 1.800 mL de sangre en la primera hora. ¿Cuál es la conducta?

A) Mantener el tubo pleural y observar
B) Toracotomía (exploración quirúrgica)
C) Transfundir glóbulos rojos y reevaluar en 6 horas
D) Retirar el tubo e instalar uno de mayor calibre
E) TAC de tórax con contraste antes de decidir

Más preguntas online de Trauma Abdominal y Torácico →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 6.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 6.1 A 6.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Diarrea Aguda y Crónica en el Niño	Diarrea aguda del niño: hidratar según el grado (Plan A oral / B SRO 50–100 mL/kg / C...	**Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibiótico solo en disentería por...**	Siempre descartar giardiasis antes de diagnosticar enfermedad celíaca.
Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño	Reflujo del lactante fisiológico = "lactante feliz" que crece bien → educar y...	**Reflujo patológico (mal incremento, síntomas respiratorios, sangre): IBP (omeprazol) de...**	—
Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	Prematuro + tríada (retención, distensión, hematoquecia) + neumatosis intestinal =...	**Lactante 6–12 meses + llanto en crisis + "mermelada de grosella" = invaginación →...**	—
Trauma Abdominal y Torácico	Trauma abdominal cerrado: clínica + eco-FAST; estable con FAST negativa → observación...	**Trauma abdominal por arma blanca: si la herida penetra el peritoneo → exploración...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Diarrea aguda del niño: hidratar según el grado (Plan A oral / B SRO 50–100 mL/kg / C suero fisiológico 20 mL/kg en bolo).

Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibiótico solo en disentería por Shigella o E. coli enteroinvasora...

Salmonella no tifoidea no complicada: no se trata con antibióticos (prolonga el estado de portador).

Diarrea crónica del lactante más frecuente: diarrea crónica inespecífica por jugos hiperosmolares → suspender jugos.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibiótico solo en disentería por Shigella o E. coli enteroinvasora (ciprofloxacino).
- Salmonella no tifoidea no complicada: no se trata con antibióticos (prolonga el estado de portador).
- Reflujo patológico (mal incremento, síntomas respiratorios, sangre): IBP (omeprazol) de primera línea.
- Vómitos explosivos entre la 2.ª y 6.ª semana + alcalosis hipoclorémica = estenosis hipertrófica del píloro → ecografía → pilorotomía de Ramstedt.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Diarrea aguda del niño: hidratar según el grado (Plan A oral / B SRO 50–100 mL/kg / C suero fisiológico 20 mL/kg...	Tema 6.1 →
Reflujo del lactante fisiológico = "lactante feliz" que crece bien → educar y tranquilizar, sin fármacos.	Tema 6.2 →
Prematuro + tríada (retención, distensión, hematoquecia) + neumatosis intestinal = enterocolitis necrotizante.	Tema 6.3 →
Trauma abdominal cerrado: clínica + eco-FAST; estable con FAST negativa → observación. El lavado peritoneal está...	Tema 6.4 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 Reconstrucción EUNACOM 2013 · Pregunta #12

Hombre de 27 años, sin antecedentes, consulta por 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y el...

CLAVE A **Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 14 días**

Úlcera duodenal activa en un paciente que no usa AINE: se asume infección por Helicobacter pylori aunque el test de ureasa sea negativo (falso negativo frecuente si hay sangrado reciente o uso previo de IBP/antibióticos), porque el 90 % de las úlceras duodenales son por H. pylori. La conducta es la terapia erradicadora de primera línea (IBP + amoxicilina + claritromicina, 14 días), no solo supresión ácida. B y E tratan la úlcera pero no la causa. D corresponde a manejo de ERGE, no de úlcera.

Perla. C retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 Reconstrucción EUNACOM Julio 2015 · Pregunta #124

Paciente con úlcera gástrica y test de ureasa positivo recibe amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 10 días...

CLAVE C **Indicar terapia erradicadora de segunda línea**

Falla de la erradicación de primera línea confirmada por test de control positivo: se indica un esquema de segunda línea que evite la claritromicina (terapia cuádruple con bismuto, o levofloxacino + amoxicilina + IBP). Repetir el mismo esquema (A) mantiene la resistencia a claritromicina. La endoscopía (B) sería obligatoria para el control de la úlcera gástrica en sí, pero la pregunta apunta a la conducta frente a la falla de erradicación.

Perla. D y E no corrigen la infección persistente.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 3 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 40 años con úlcera duodenal en la endoscopía. El test de ureasa para H. pylori resulta negativo. No usa AINE...

CLAVE B **Erradicar igualmente con esquema de primera línea**

Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test resulte negativo, porque el 90 % son por H. pylori y el test de ureasa tiene falsos negativos frecuentes (uso previo de IBP o antibióticos, sangrado reciente). Dar solo omeprazol (C) cicatriza pero no previene la recidiva.

Perla. Repetir exámenes (D, E) retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 35 años con epigastralgia urente de 2 meses, sin baja de peso, anemia ni disfagia. La endoscopía digestiva...

CLAVE C **Dispepsia funcional; educación, manejo del estrés y prueba con IBP**

Epigastralgia con endoscopía normal y sin signos de alarma es, por definición, dispepsia funcional (diagnóstico de exclusión que requiere endoscopía normal). El manejo es educación, manejo del estrés, moduladores del dolor y una prueba con IBP; se puede ofrecer erradicación de H. pylori si el test fuera positivo, lo que aquí no aplica.

Perla. No corresponde tratar como úlcera (A) ni repetir estudios invasivos sin nuevas banderas rojas.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 5 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 62 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 3 meses de disfagia que comenzó con la carne y el pan y...

CLAVE C **Endoscopía digestiva alta con biopsia**

Disfagia lógica (progresiva, de sólidos a líquidos) con baja de peso en un fumador es cáncer de esófago mientras no se demuestre lo contrario. El diagnóstico se hace con endoscopía digestiva alta y biopsia; el TAC y la endosonografía vienen después, para etapificar.

Perla. La manometría y el esofagograma se reservan para la disfagia ilógica (sospecha de trastorno motor).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 6 Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 71 años consulta por sensación de que la comida "se le queda en la garganta" desde hace un año, regurgitación...

CLAVE C **Divertículo de Zenker**

Disfagia alta (la comida se queda "en la garganta", a nivel del esfínter esofágico superior) con halitosis marcada y regurgitación de alimento no digerido es el cuadro típico del divertículo de Zenker: el alimento se acumula en el saco diverticular y fermenta. El diagnóstico se confirma con esofagograma con bario.

Perla. La halitosis es la clave que lo separa de la acalasia.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 7 Caso representativo · banco EUNACOM

Niño de 3 años que hace 2 horas bebió un sorbo de soda cáustica del envase mal rotulado. Presenta sialorrea y llanto al...

CLAVE C **Endoscopía digestiva alta en las primeras horas**

En la ingesta de cáusticos la primera medida es la endoscopía digestiva alta precoz para graduar el daño de la mucosa y decidir si se observa, se deja en régimen cero con nutrición parenteral o se opera.

Trampa. El lavado gástrico, el carbón activado, los neutralizantes y provocar el vómito están contraindicados porque el daño es inmediato y todas esas maniobras lo agravan (reexposición del esófago al cáustico, perforación).

TEMA 1.4 · PREGUNTA 8 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 45 años, tras una cena copiosa con alcohol y varios episodios de vómitos, presenta dolor torácico intenso y...

CLAVE B **Perforación esofágica (síndrome de Boerhaave)**

Vómitos intensos seguidos de dolor torácico y enfisema subcutáneo (crepitación cervical), con fiebre y taquicardia, configuran la tríada del síndrome de Boerhaave (perforación esofágica espontánea). El Mallory-Weiss también sigue a los vómitos, pero se manifiesta con hematemesis y no produce enfisema ni sepsis.

Trampa. El examen inicial es la radiografía de tórax buscando neumomediastino; la endoscopía está contraindicada.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 9 — Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 60 años consulta por baja de 8 kg de peso en 3 meses, epigastralgia sorda e hiporexia. No tiene ictericia...

CLAVE B **Endoscopía digestiva alta con biopsias**

Baja de peso con epigastralgia en un mayor de 40 años obliga a descartar cáncer gástrico, y el examen que confirma es la endoscopía digestiva alta con biopsias (además detecta la úlcera y permite tomar muestras para H. pylori). El TAC se usa después, para etapificar.

> **Perla.** Si el paciente además tuviera ictericia, la sospecha cambiaría a cáncer de páncreas y ahí sí el examen inicial sería el TAC.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 10 — Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 55 años con endoscopía por dispepsia que informa un adenocarcinoma gástrico limitado a la mucosa, sin invasión...

CLAVE B **La profundidad de invasión de la pared; resección (endoscópica o quirúrgica) con intención curativa**

El factor pronóstico principal del cáncer gástrico es la profundidad de invasión de la pared. Este es un cáncer incipiente (limitado a la mucosa), el de mejor pronóstico, y con esos criterios (lesión pequeña, bien diferenciada, sin úlcera, sin invasión submucosa) puede tratarse con resección endoscópica de la mucosa; en otros casos, gastrectomía.

> **Perla.** Observar (A) o solo erradicar H. pylori (C) deja el tumor sin tratar.

TEMA 1.6 · PREGUNTA 11 — Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 50 años, asintomática, a quien se realiza una endoscopía digestiva alta por anemia y se informa como hallazgo...

CLAVE C **Observación, sin tratamiento específico**

La hernia hiatal tipo I (por deslizamiento) asintomática se comporta casi como una variante normal y no requiere ningún tratamiento: solo se maneja el reflujo si el paciente tiene síntomas. La cirugía se reserva para las hernias paraesofágicas (por su riesgo de complicación mecánica) o para la ERGE grave refractaria.

> **Perla.** La anemia de esta paciente debe estudiarse por otras causas.

TEMA 1.6 · PREGUNTA 12 — Caso representativo · banco EUNACOM

En una radiografía de tórax de control se observa un ensanchamiento del mediastino anterior en un paciente de 40 años...

CLAVE B **TAC de tórax con contraste; timoma asociado a miastenia gravis**

Masa en el mediastino anterior + síntomas de miastenia gravis (diplopía y debilidad fluctuante que mejora con el reposo) orientan a un timoma. El examen de elección para cualquier masa mediastínica es el TAC de tórax con contraste.

> **Perla.** El timoma asociado a miastenia gravis tiene indicación de timectomía, que además puede mejorar la miastenia.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 13 — Reconstrucción EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta #41

Mujer de 48 años consulta por distensión y dolor abdominal de 1 año, alternando diarrea y constipación. En los últimos...

CLAVE B **Solicitar colonoscopía**

Tiene múltiples signos de alarma: edad > 50 (límite), baja de peso involuntaria, cambio reciente del hábito intestinal, rectorragia y antecedente familiar de cáncer de colon. Eso descarta el manejo como trastorno funcional (A, C, E) y obliga a colonoscopía para descartar cáncer colorrectal.

> **Perla.** El test de sangre oculta (D) es una herramienta de tamizaje poblacional en personas asintomáticas, no sirve para estudiar a un paciente sintomático con banderas rojas.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 14 — Caso tipo EUNACOM (banco 2022)

Hombre de 29 años consulta por dolor abdominal recurrente de 6 meses que alivia al defecar, asociado a deposiciones más...

CLAVE B **Diagnóstico de síndrome de intestino irritable e iniciar manejo**

Cumple criterios de Roma IV (dolor recurrente que alivia con la defecación y se asocia a cambio en la consistencia de las deposiciones) sin ningún signo de alarma y con exámenes básicos normales, incluyendo serología celíaca negativa. El diagnóstico de SII es clínico y positivo; corresponde iniciar tratamiento (educación, dieta, fármacos según síntoma) sin más estudios.

> **Perla.** Las alternativas A, C y D son estudios invasivos innecesarios en ausencia de banderas rojas.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 15 — Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 46 años presenta diarrea líquida de 3 semanas que comenzó 10 días después de terminar un tratamiento con...

CLAVE B **PCR de toxina para Clostridioides difficile en deposiciones**

Diarrea que aparece hasta un mes después del uso de antibióticos obliga a descartar Clostridioides difficile. El examen de elección actual es la PCR de toxina en deposiciones, más sensible que la detección de toxinas A y B.

> **Perla.** El tratamiento es metronidazol oral y, si falla, vancomicina oral; la respuesta se evalúa por la clínica, no repitiendo la PCR (puede quedar positiva por semanas).

TEMA 2.2 · PREGUNTA 16 — Caso representativo · banco EUNACOM

Niño de 2 años con diarrea acuosa de 2 días y fiebre de 38,5 °C, sin sangre en las deposiciones, con buen estado...

CLAVE D **No indicar antibióticos**

La diarrea aguda del niño, por regla general, no lleva antibiótico. Solo se indica ante disentería con mal estado general, fiebre alta persistente por varios días, dolor abdominal intenso o aislamiento de Shigella o E. coli enteroinvasora.

> **Perla.** Este niño está en buen estado, sin disentería y con fiebre de pocas horas: el manejo es hidratación y observación.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 17 — Caso representativo · banco EUNACOM

Paciente con enfermedad celíaca que lleva 1 año con dieta sin gluten. Refiere seguirla de forma estricta, pero persiste...

CLAVE B **Linfoma T asociado a enteropatía (linfoma MALT)**

La causa más frecuente de falta de respuesta en la celíaca es la transgresión dietética, pero en ese caso los anticuerpos suelen mantenerse elevados.

> **Trampa.** Aquí los anticuerpos están negativos (lo que confirma buena adherencia) y aun así persiste la malabsorción: eso obliga a descartar un linfoma T asociado a enteropatía, complicación grave de la enfermedad celíaca que requiere imágenes y biopsias repetidas.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 18 — Caso representativo · banco EUNACOM

Recién nacido de 12 días con ictericia prolongada, hepatomegalia, mal incremento ponderal y cataratas bilaterales...

CLAVE C **Fórmula de soya (sin galactosa)**

Ictericia, daño hepático, cataratas y retraso del desarrollo en el recién nacido configuran una galactosemia. El tratamiento es eliminar toda la galactosa: están contraindicadas la lactancia materna y las fórmulas de origen animal. La fórmula sin lactosa no sirve, porque aporta galactosa (la lactasa añadida hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa).

> **Perla.** Se usa fórmula de soya u otra de origen vegetal.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 19 — EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 26

Hombre de 25 años con 1 mes de diarrea, dolor abdominal y malestar general; ha tenido disentería en algunas ocasiones y...

CLAVE B **Enfermedad de Crohn**

La colonoscopía define el caso: inflamación en parches (zonas de mucosa indemne) y respeto del recto.

Trampa. Cualquiera de esas dos características, por sí sola, descarta la colitis ulcerosa —que es continua y siempre rectal— y establece el diagnóstico de enfermedad de Crohn.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 20 — EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 21

Paciente de 45 años con antecedente de colitis ulcerosa diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años. Desde hace...

CLAVE D **Solicitar colonoscopía**

La colitis ulcerosa de larga data multiplica el riesgo de cáncer colorrectal, sobre todo rectal, y todo sangrado digestivo bajo nuevo en un adulto exige colonoscopía completa: la rectosigmoidoscopía no explora el colon proximal y dejaría lesiones sin ver.

Trampa. No se asume un brote ni se inician corticoides antes de descartar neoplasia.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 21 — EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 164

Mujer de 35 años con diarrea crónica mucosanguinolenta de 6 meses, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Colonoscopía...

CLAVE B **Colitis ulcerosa**

Compromiso mucoso continuo desde el recto hacia proximal, sin mucosa sana intercalada, con pseudopólipos y clínica de pujo y tenesmo: es una colitis ulcerosa. La ausencia de parches, de compromiso ileal y de lesiones perianales descarta el Crohn. Tratamiento según extensión:

Perla. 5-ASA tópico y oral.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 22 — Caso representativo · banco EUNACOM

En una colonoscopía realizada a un hombre de 28 años con antecedentes familiares de cáncer de colon se describen más de...

CLAVE B **Colectomía total (proctocolectomía) profiláctica**

Cientos de pólipos adenomatosos en un paciente joven con historia familiar corresponden a una poliposis adenomatosa familiar, que evoluciona a cáncer colorrectal en prácticamente el 100 % de los casos si no se interviene. La conducta es la colectomía total (proctocolectomía) profiláctica.

Perla. La polipectomía endoscópica es inviable por el número de lesiones y no elimina el riesgo.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 23 — Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 55 años, asintomático, sin antecedentes familiares, consulta para "chequeo". ¿Cuál es la estrategia de...

CLAVE B **Test de sangre oculta inmunoquímico y, si es positivo, colonoscopía; o colonoscopía cada 10 años**

En personas de riesgo promedio se recomienda tamizaje desde los 50 años con test de sangre oculta inmunoquímico (anual o bienal), derivando a colonoscopía a los positivos, o bien colonoscopía cada 10 años. El CEA y el TAC no son herramientas de tamizaje.

Trampa. Esperar a que aparezcan síntomas anula el objetivo del cribado, que es detectar adenomas y cánceres tempranos.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 24 — Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 34 años consulta por dolor anal intenso que aparece cada vez que defeca y dura media hora después, junto con...

CLAVE B **Baños de asiento y manejo de la constipación (fibra, agua, laxante osmótico)**

El cuadro es una fisura anal (dolor con la defecación que persiste por espasmo del esfínter interno, rectorragia escasa, fisura visible, contexto de constipación). El tratamiento inicial es médico: baños de asiento para relajar el esfínter interno y corregir la constipación.

Perla. La esfinterotomía lateral interna solo se plantea en la fisura crónica que no responde al tratamiento médico.

TEMA 2.6 · PREGUNTA 25 — Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 45 años consulta porque desde hace 3 meses tiene un pequeño orificio en la piel de la región glútea, cercano...

CLAVE B **Fístula anal; tratamiento quirúrgico**

Un orificio cutáneo perianal que supura de forma crónica tras un absceso drenado es una fístula anal (trayecto que comunica el canal anal con la piel). El tratamiento es quirúrgico (fistulotomía o colocación de sedal).

Trampa. Es el error clásico confundirla con la fisura: se escriben parecido, pero la fisura es una herida dolorosa de manejo médico y la fístula es un trayecto de manejo quirúrgico.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 26 — Caso representativo · banco EUNACOM

Estudiante de 22 años, asintomático, consulta porque en un examen preventivo le encontraron una bilirrubina total de...

CLAVE C **Síndrome de Gilbert; tranquilizar y no requiere tratamiento**

Hiperbilirrubinemia indirecta aislada, con el resto de las pruebas hepáticas y el hemograma normales, en un joven asintomático: es un síndrome de Gilbert, un trastorno hereditario benigno de la conjugación de la bilirrubina que afecta al 5–10 % de la población y suele hacerse evidente con el ayuno o las infecciones.

Perla. No requiere estudio adicional ni tratamiento.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 27 — Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 55 años con dolor cólico en el hipocondrio derecho e ictericia de 2 días, sin fiebre. Laboratorio: bilirrubina...

CLAVE B **Colangiorresonancia**

El patrón es colestásico con dolor y sin fiebre: coledocolitiasis. La ecografía muestra la vía biliar dilatada pero no ve el cálculo, así que el siguiente paso es la colangiorresonancia para confirmarlo antes de someter a la paciente a una CPRE (que es invasiva y tiene riesgo de pancreatitis).

Perla. Se va directo a CPRE solo si hay colangitis o si la ecografía ya vio el cálculo en el colédoco.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 28 — EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 122

Una paciente se realiza exámenes porque su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para...

CLAVE A **Vacunada contra la hepatitis B**

El AgHBs negativo descarta infección activa y los anti-HBs positivos indican inmunidad. Como no se informan anti-HBc, el patrón "anti-HBs aislado" corresponde a inmunidad por vacuna (una infección resuelta también tendría anti-HBc IgG positivos).

Perla. En ningún caso hay enfermedad activa ni período de ventana.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 29 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 26

Mujer de 30 años con 10 días de astenia, fiebre, malestar y dolor epigástrico; hace 2 días se agregó ictericia y hoy...

CLAVE B **Hospitalizar**

Es una hepatitis A aguda (IgM anti-VHA positiva) con transaminasas muy elevadas y, sobre todo, protrombinemia de 52 %. Aún no hay encefalopatía, por lo que no cumple criterios de hepatitis fulminante, pero la caída del tiempo de protrombina es el marcador de gravedad y de riesgo de progresión: obliga a hospitalizar para vigilancia.

Perla. El manejo ambulatorio se reserva para la hepatitis A no complicada con protrombina normal.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 30 EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 83

Mujer de 20 años en tratamiento con isotretinoína hace 10 días por acné consulta por dolor abdominal, malestar y...

CLAVE D **Hepatitis por fármacos**

La IgM anti-VHA negativa descarta hepatitis A aguda (la IgG solo marca contacto previo). El AgHBs negativo descarta infección B activa; los anti-HBc totales positivos sin AgHBs indican solo exposición pasada.

Perla. Por descarte, y por la relación temporal con un fármaco hepatotóxico conocido (isotretinoína), el diagnóstico es hepatitis por fármacos: la conducta es suspender el fármaco de inmediato.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 31 Caso representativo · banco EUNACOM

Paciente con cirrosis y várices esofágicas medianas encontradas en una endoscopía de tamizaje. Nunca ha presentado...

CLAVE B **Propranolol (o carvedilol) por vía oral, titulado por frecuencia cardíaca**

La profilaxis primaria de la hemorragia variceal (paciente que nunca ha sangrado) es el betabloqueo no selectivo, titulado para reducir la frecuencia cardíaca.

Trampa. La ligadura endoscópica se añade en la profilaxis secundaria (tras un primer sangrado) o se usa sola cuando el betabloqueo está contraindicado (asma, EPOC grave, intolerancia).

TEMA 3.3 · PREGUNTA 32 Caso representativo · banco EUNACOM

Cirrótico con ascitis refractaria a diuréticos que además ha tenido dos episodios de encefalopatía hepática en el...

CLAVE B **No instalar el TIPS: la encefalopatía es una contraindicación**

El TIPS crea una derivación portosistémica que hace que la sangre intestinal "salte" el hígado; eso alivia la hipertensión portal pero aumenta la carga de amonio y otras toxinas que llegan al cerebro, por lo que la encefalopatía hepática (aun leve o recurrente) es una contraindicación.

Perla. En este paciente se mantienen las paracentesis seriadas con albúmina y se prioriza la evaluación para trasplante.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 33 Caso representativo · banco EUNACOM

En una ecografía abdominal solicitada por dispepsia se informa una lesión hepática de 3 cm, hiperecogénica, homogénea y...

CLAVE B **Hemangioma hepático; observación**

Una lesión hiperecogénica, homogénea y bien delimitada en un hígado sano corresponde casi siempre a un hemangioma, la lesión hepática benigna más frecuente. La conducta es la observación; si hay dudas por el tamaño o características atípicas, se confirma con RM.

Perla. La cirugía solo se plantea en hemangiomas gigantes y sintomáticos.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 34 Caso representativo · banco EUNACOM

En un paciente de 60 años, sin colelitiasis, se detecta en la ecografía un pólipo vesicular único, sésil, de 14 mm, que...

CLAVE B **Colecistectomía**

Un pólipo vesicular ≥ 10 mm, único, sésil, con crecimiento demostrado y en un paciente mayor de 50 años reúne varios criterios de sospecha de malignidad, por lo que la conducta es la colecistectomía (la única "biopsia" adecuada de un pólipo vesicular es la vesícula completa).

Perla. El seguimiento se reserva para los pólipos pequeños, múltiples y homogéneos (colesterolínicos).

TEMA 4.1 · PREGUNTA 35 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 62 años consulta por dolor en el hipocondrio derecho, ictericia progresiva, fiebre de 39 °C con calofríos y...

CLAVE B **Colangitis aguda grave; reposición de volumen, antibióticos y CPRE urgente para drenaje**

Dolor + ictericia + fiebre (tríada de Charcot) con hipotensión y compromiso de conciencia constituyen la péntada de Reynolds: una colangitis aguda grave. La prioridad es la reanimación con volumen, los antibióticos de amplio espectro y, sobre todo, el drenaje biliar urgente mediante CPRE.

Perla. La colecistectomía se difiere hasta que el paciente se estabilice.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 36 Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 40 años, sin síntomas, a quien en una ecografía de rutina se le detecta una colelitiasis (múltiples cálculos...

CLAVE C **Colecistectomía laparoscópica electiva**

En Chile, que tiene la incidencia de cáncer de vesícula más alta del mundo, la conducta ante una colelitiasis —aunque sea asintomática— es la colecistectomía laparoscópica electiva. El GES garantiza esta cirugía preventiva en el grupo de 35 a 49 años.

Perla. La disolución con ursodesoxicólico y la observación no protegen del cáncer.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 37 Reconstrucción EUNACOM 2013 · Pregunta #121

Hombre de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras...

CLAVE B **Pancreatitis aguda**

La lipasa está sobre 3 veces el límite superior (> 180 U/L) junto con dolor típico: cumple criterios de pancreatitis aguda, y aunque coexista una coledocolitiasis (colédoco dilatado, patrón colestásico), "manda" la pancreatitis por ser la condición más grave y la que define la conducta. No hay fiebre ni compromiso hemodinámico que hagan pensar en colangitis (A).

Trampa. El colédoco dilatado y la ictericia descartan un cólico biliar simple (E) y la colecistitis (D) cursaría con Murphy y sin esta magnitud de ictericia.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 38 Reconstrucción EUNACOM Julio 2016 · Pregunta #54

Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril...

CLAVE B **Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio**

En la pancreatitis biliar leve que ya resolvió, la colecistectomía laparoscópica debe realizarse en el mismo ingreso, porque diferirla se asocia a alta tasa de recurrencia de pancreatitis, colecistitis o colangitis en las semanas siguientes. La CPRE urgente (A) solo se indica si hay colangitis u obstrucción biliar persistente, lo que aquí no ocurre (afebril, vía biliar normal). La colangiorresonancia (D) no aporta porque la probabilidad de coledocolitiasis es baja.

Perla. Diferir la cirugía (C) o no operar (E) deja al paciente expuesto a un nuevo evento.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 39 Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 24 años consulta por dolor que comenzó alrededor del ombligo y en 12 horas se localizó en la fosa ilíaca…

CLAVE B **Test de embarazo y evaluación ginecológica**

En toda mujer en edad fértil con dolor en la fosa ilíaca derecha y sospecha de apendicitis, lo primero es descartar patología ginecológica y, sobre todo, un embarazo ectópico: se solicita test de embarazo y evaluación ginecológica (con ecografía). Recién después se confirma la apendicitis (clínica + ecografía) y se lleva a pabellón.

Perla. Operar sin este paso puede pasar por alto un ectópico roto.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 40 Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 63 años con diverticulitis aguda. El TAC muestra abundante líquido y aire libre intraperitoneal, con signos de…

CLAVE C **Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)**

Aire y líquido libre con peritonitis fecal corresponde a un Hinchey IV (perforación libre con contaminación fecal), que junto con el Hinchey III (peritonitis purulenta) es indicación de cirugía de urgencia: resección del sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón rectal (operación de Hartmann), reconstruyendo el tránsito meses después.

Perla. El manejo médico o percutáneo solo sirve en los abscesos (Hinchey I–II).

TEMA 5.2 · PREGUNTA 41 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 70 años con antecedente de ateroesclerosis, tras un episodio de hipotensión por una hemorragia digestiva…

CLAVE C **Colitis isquémica**

Dolor en el hemiabdomen izquierdo con hematoquecia en un adulto mayor con ateroesclerosis, precipitado por un episodio de hipotensión (bajo flujo), es característico de la colitis isquémica, que afecta las zonas frontera de irrigación del colon (ángulo esplénico, rectosigmoides). Suele ser transitoria y responde al manejo médico.

Perla. La embolia mesentérica da dolor mucho más intenso y difuso, con disociación clínica, en el contexto de fibrilación auricular.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 42 Caso representativo · banco EUNACOM

Paciente de 72 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito y muy intenso. El examen abdominal es…

CLAVE C **Angio-TAC (o angiografía) mesentérica**

La sospecha es una embolia mesentérica (fibrilación auricular + dolor súbito intenso + disociación clínica). El examen de elección es el angio-TAC, que muestra el defecto de llene en la arteria mesentérica superior; la angiografía formal se usa cuando además se planea un tratamiento endovascular.

Perla. El TAC sin contraste y la radiografía simple no muestran el émbolo y hacen perder tiempo valioso.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 43 Caso representativo · banco EUNACOM

Al momento de la presentación de una hemorragia digestiva alta, ¿cuál de los siguientes parámetros determina mejor la…

CLAVE C **La frecuencia cardíaca y la presión arterial**

En el sangrado agudo se pierde sangre completa (plasma y glóbulos rojos en proporción), por lo que el hematocrito inicial suele ser normal y solo cae horas después, cuando el líquido intersticial diluye la masa eritrocitaria. La gravedad al momento de la presentación la marca el compromiso hemodinámico: taquicardia (lo más precoz), ortostatismo y, finalmente, hipotensión.

Trampa. Nunca se debe esperar el hematocrito para iniciar la reanimación.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 44 Caso representativo · banco EUNACOM

Paciente de 68 años con hemorragia digestiva baja masiva e inestabilidad hemodinámica. Se realiza una colonoscopía…

CLAVE B **Endoscopía digestiva alta**

Cerca del 10 % de las hemorragias que se manifiestan como hematoquecia tienen en realidad un origen alto (HDA masiva con tránsito acelerado). Por eso, si la colonoscopía urgente no localiza el sangrado en un paciente inestable, el siguiente paso es la endoscopía digestiva alta.

Perla. Si tampoco la localiza, se continúa con angio-TAC/angiografía (que puede ser terapéutica) y, en último término, cirugía.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 45 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 45 años consulta por sensación de cuerpo extraño retroesternal tras comer un trozo grande de carne hace 6…

CLAVE C **Endoscopía digestiva alta para desimpactar**

La comida impactada en el esófago con dolor e incapacidad de tragar la saliva (obstrucción esofágica completa) requiere endoscopía digestiva alta para retirarla, sin demora, por el riesgo de aspiración y de perforación. Solo se puede observar hasta 24 horas cuando el paciente está sin dolor y tolera líquidos.

Perla. Tras resolver el episodio conviene estudiar el esófago (esofagitis eosinofílica, estenosis, anillo de Schatzki).

TEMA 5.4 · PREGUNTA 46 Caso representativo · banco EUNACOM

Niño de 5 años se tragó una moneda hace 3 horas. Está asintomático, sin sialorrea ni dificultad para tragar. La…

CLAVE C **Observación con control radiológico cada 1–2 semanas**

Una moneda (objeto romo, no cáustico, no magnético) que ya pasó el esófago y está en el estómago, en un niño asintomático, se maneja con observación y control radiológico cada 1–2 semanas: la gran mayoría se elimina espontáneamente sin complicaciones. La endoscopía se reservaría si el objeto no progresa en 3–4 semanas o si aparecen síntomas.

Perla. Solo las pilas, los imanes múltiples y los objetos afilados o largos se retiran aunque estén en el estómago.

TEMA 6.1 · PREGUNTA 47 Caso representativo · banco EUNACOM

Preescolar de 4 años de una zona rural consulta por diarrea crónica de 2 meses, con abundante flatulencia y dolor...

CLAVE C **Giardiasis; tinidazol (o metronidazol)**

Diarrea crónica con flatulencia y dolor cólico en un preescolar de zona rural, con varios convivientes afectados, es muy sugerente de giardiasis. Se confirma con parasitológico seriado (3 muestras en días distintos) y se trata con tinidazol o metronidazol.

Trampa. La giardiasis puede producir un síndrome de malabsorción idéntico al de la celíaca, por lo que siempre debe descartarse antes de ese diagnóstico.

TEMA 6.1 · PREGUNTA 48 Caso representativo · banco EUNACOM

Lactante de 4 meses alimentado con fórmula presenta diarrea crónica con estrías de sangre, reflujo y episodios de...

CLAVE C **Prueba terapéutica con fórmula extensamente hidrolizada por 2–4 semanas y posterior reintroducción**

Un lactante con síntomas gastrointestinales (diarrea con sangre, reflujo, mal incremento) y alérgicos (exantema, sibilancias) sugiere alergia a la proteína de leche de vaca. El diagnóstico se hace con prueba terapéutica: se cambia a fórmula extensamente hidrolizada (o de aminoácidos) por 2–4 semanas y, si mejora, se reintroduce la proteína de leche de vaca; la reaparición de los síntomas confirma el diagnóstico.

Perla. No existe un test sanguíneo validado para esta condición.

TEMA 6.2 · PREGUNTA 49 Caso representativo · banco EUNACOM

Recién nacido de 4 semanas, previamente sano, con 5 días de vómitos explosivos posprandiales. Se muestra ávido por...

CLAVE C **Ecografía abdominal**

Vómitos explosivos y proyectivos que comienzan entre la 2.ª y la 6.ª semana de vida, en un lactante hambriento, con deshidratación y alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica (por la pérdida de ácido clorhídrico en los vómitos), son característicos de la estenosis hipertrófica del píloro. El diagnóstico se confirma con ecografía abdominal, que muestra el músculo pilórico engrosado.

Perla. El tratamiento es la corrección hidroelectrolítica seguida de la pilorotomía de Ramstedt.

TEMA 6.2 · PREGUNTA 50 Caso representativo · banco EUNACOM

Niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y manchado fecal en la ropa interior. Al examen se...

CLAVE B **Polietilenglicol por vía oral para desimpactar**

Antes de cualquier medida de mantenimiento hay que desimpactar el fecaloma, y el tratamiento de elección para la desimpactación es el polietilenglicol por vía oral (alternativa: enema). El manchado fecal es pseudoincontinencia por rebosamiento alrededor del fecaloma.

Perla. La dieta y los laxantes de mantenimiento (fase 2) recién se inician una vez vaciado el recto; la extracción digital se reserva para casos excepcionales.

TEMA 6.3 · PREGUNTA 51 Caso representativo · banco EUNACOM

Recién nacido prematuro de 30 semanas, a los 6 días de vida, presenta residuo gástrico bilioso, distensión abdominal y...

CLAVE C **Enterocolitis necrotizante**

Un recién nacido prematuro con la tríada de retención gástrica, distensión abdominal y hematoquecia, junto con neumatosis intestinal (aire en la pared del intestino) en la radiografía, tiene una enterocolitis necrotizante.

Perla. El manejo inicial es régimen cero, nutrición parenteral total, sonda para descompresión y antibióticos endovenosos; la cirugía se indica ante neumoperitoneo (perforación) o deterioro pese al tratamiento médico.

TEMA 6.3 · PREGUNTA 52 Caso representativo · banco EUNACOM

Niño de 3 años, sano, consulta por un episodio de deposición con abundante sangre roja oscura, sin dolor abdominal...

CLAVE B **Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio-99m**

Una hemorragia digestiva baja abundante e indolora en un niño pequeño, con colonoscopía normal, orienta a un divertículo de Meckel: la mucosa gástrica ectópica que contiene secreta ácido y ulcera el íleon adyacente. El examen de elección es la cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m, que es captado por esa mucosa gástrica ectópica.

Perla. La colonoscopía no alcanza el íleon donde se ubica el divertículo.

TEMA 6.4 · PREGUNTA 53 Caso representativo · banco EUNACOM

Hombre de 25 años recibe una herida por arma blanca en el flanco derecho. Está estable, sin signos peritoneales. Al...

CLAVE C **Exploración quirúrgica (laparotomía o laparoscopía)**

En el trauma abdominal por arma blanca la conducta se define por la exploración de la herida: si penetra el peritoneo, se indica exploración quirúrgica, porque el riesgo de lesión visceral (intestino, mesenterio) es alto aunque el paciente esté inicialmente estable y sin peritonismo. Si la herida no atraviesa el peritoneo, se puede observar.

Perla. El lavado peritoneal está en desuso.

TEMA 6.4 · PREGUNTA 54 Caso representativo · banco EUNACOM

Paciente de 40 años con trauma torácico cerrado. La radiografía muestra una opacidad de la base derecha con borramiento...

CLAVE B **Toracotomía (exploración quirúrgica)**

Un hemotórax con salida inicial mayor de 1.500 mL por el tubo pleural (o un débito sostenido de más de 200 mL/h durante 2–4 horas) indica una hemorragia activa importante y es indicación de toracotomía. Mantener solo el drenaje o transfundir sin controlar la fuente lleva al shock.

Trampa. El TAC no debe retrasar la cirugía en un sangrado de este volumen.